

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



NOMBRE DE LA TESIS:

MODELO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEDENTARIO MEDIANTE LÓGICA DIFUSA Y DATOS BIOMÉTRICOS

POR:

LUIS ANGEL MARTÍNEZ CORRAL

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN FORMACIÓN E INNOVACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Chihuahua, Chih., México

27 de Octubre de 2025

Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos

Dr. Said Alejandro De La Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas
Universidad Autónoma de Chihuahua

DR(A) Haydee Parra Acosta
Coordinador de la Maestría

DR(A) Abimael Guzmán Pando
Director de Tesis

DR(A) David Ricardo López Flores
Asesor(a)

DR(A) Celia María Quiñez Cruz
Asesor(a)

DR(A) Javier Camarillo Cisneros
Asesor(a)

RESUMEN

El comportamiento sedentario representa un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, cuya medición objetiva en condiciones de vida libre presenta desafíos metodológicos significativos. Los métodos tradicionales de evaluación (cuestionarios de autorreporte) adolecen de sesgos de memoria y deseabilidad social, mientras que las técnicas de referencia se restringen a entornos de laboratorio que no capturan la complejidad del comportamiento ecológico. Este estudio desarrolló un modelo de clasificación del sedentarismo mediante lógica difusa que integra datos biométricos de dispositivos portátiles de consumo, aplicado bajo el paradigma *Bring Your Own Device* (BYOD) en condiciones de vida libre.

La cohorte estuvo conformada por 10 adultos jóvenes con seguimiento longitudinal retrospectivo multianual (media: 133.7 semanas; rango: 7-298 semanas), acumulando 9,185 días de registro biométrico continuo mediante Apple Watch. Tras preprocesamiento (imputación jerárquica, normalización antropométrica), se generaron 1,337 semanas válidas con cuatro variables derivadas: Actividad relativa, Superávit calórico basal, Delta cardíaco y HRV-SDNN. La metodología empleó un enfoque híbrido: clustering K-Means no supervisado ($K=2$) para establecer verdad operativa a partir de patrones empíricos, seguido de un Sistema de Inferencia Difusa Mamdani que codifica conocimiento experto mediante cinco reglas lingüísticas interpretables.

La validación Leave-One-User-Out demostró $F1\text{-Score}=0.840$ (Precisión=0.833, Recall=0.850), con variabilidad inter-sujeto excepcional ($CV=4.8\%$), superando estudios comparables. El análisis de ablación reveló que HRV-SDNN, aunque débil discriminador univariado ($p=0.24$), resulta crítico en modelo multivariado (ablación: -50 % $F1\text{-Score}$). El sistema propuesto clasifica comportamiento sedentario con alta fiabilidad, preservando interpretabilidad clínica mediante reglas transparentes aplicables en monitorización ecológica de salud pública.

Palabras clave: comportamiento sedentario, lógica difusa, BYOD, wearables, LOUO, vida libre

Línea de investigación: Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) en Formación Biomédica

Sublínea de investigación: Bioinformática y Aplicaciones de Inteligencia Artificial en Salud

Investigador Estudiante:

Luis Angel Martínez Corral

Equipo de investigación:

Dr. Abimael Guzmán Pando

Dr. David Ricardo López Flores

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Dr. Javier Camarillo Cisneros

Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

UACH México

Web: <https://uach.mx/fm/>

Correo: p261337@uach.mx

Chihuahua, México, 2025

© Universidad Autónoma de Chihuahua

© Los autores

Todos los derechos reservados. Se permite la distribución, uso y copia citando la fuente completa.



Chihuahua, Chih., a _____ de _____ de 2025

Dr. Said Alejandro de la Cruz Rey
Secretario de Investigación y Posgrado
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

P R E S E N T E.-

Por medio de la presente nos permitimos informar a usted que el C. Luis Angel Martínez Corral, con número de matrícula 261337, ha concluido la elaboración de la tesis “Modelo de Evaluación del Comportamiento Sedentario mediante Lógica Difusa y Datos Biométricos”, como requisito para obtener el grado de: **Maestro en Formación e Innovación para Profesionales de la Salud.**

Así mismo, manifestamos que la tesis ha sido revisada y aprobada por los abajo firmantes, miembros del Comité de Grado.

Sin otro particular, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

“MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM”

Director de Tesis

Dr. Abimael Guzmán Pando

Co-Director de Tesis

Dr. David Ricardo López Flores

Asesor de Tesis

Dra. Celia María Quiñez Cruz

Asesor de Tesis

Dr. Javier Camarillo Cisneros

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a _____ por _____

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a:

[Escribe aquí tus agradecimientos a las personas que apoyaron tu trabajo]

Índice de contenidos

1	Introducción	12
2	Marco Teórico y Antecedentes	14
2.1	Marco Teórico	14
2.1.1	Definición de Sedentarismo	14
2.1.2	Definición del Comportamiento Sedentario	14
2.1.3	Diferencia entre Comportamiento Sedentario e Inactividad Física	15
2.1.4	Directrices de la OMS sobre Actividad Física	15
2.1.5	Actividad Física y Ejercicio Físico	16
2.1.6	Condición Física Relacionada con la Salud	16
2.1.7	Actividad y Capacidad Aeróbica	16
2.1.8	Frecuencia Cardíaca	17
2.1.9	Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV)	18
2.1.10	MET (Equivalente Metabólico)	19
2.1.11	Dispositivos y Tecnologías Electrónicas Portátiles	19
2.1.12	Sensores integrados en dispositivos portátiles	20
2.1.13	Inteligencia Artificial para el Reconocimiento del Comportamiento Sedentario	21
2.1.14	Teoría de lógica difusa para el análisis de datos biométricos	22
2.1.15	Síntesis del Marco Conceptual	23
2.2	Antecedentes	23
2.2.1	Impacto del Comportamiento Sedentario	23
2.2.2	Instrumentos de evaluación del Comportamiento Sedentario	25
2.2.3	Cómo afecta el CS en la CVRS	26
2.2.4	Uso de sensores para el análisis del Comportamiento Sedentario	26
2.2.5	Monitores de Actividad Física Portables de consumo público	27
2.2.6	El enfoque de la Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos	30
2.2.7	Fundamento filosófico del enfoque difuso	31
2.2.8	La Lógica Difusa en la Salud Digital y el Monitoreo Biométrico	32
2.2.9	Sistemas Neuro-Difusos y Aprendizaje Automático Difuso	34
2.3	Clustering No Supervisado y Establecimiento de Ground Truth	35
2.3.1	Clustering como Herramienta de Descubrimiento de Patrones	35
2.3.2	Línea de Base: Umbrales Heurísticos para Sedentarismo	35

2.3.3	Vacío Metodológico: Clustering + Sistema de Inferencia Difusa	35
2.4	Validación Cruzada Leave-One-User-Out en Wearables	36
2.4.1	LOUO: Estándar para Generalización Inter-Sujeto	36
2.4.2	LOUO en Cohortes Pequeñas ($N < 20$)	36
2.5	Vacíos en la Literatura y Posicionamiento del Proyecto	37
2.5.1	Identificación de Vacíos Metodológicos	37
2.5.2	Síntesis: Posicionamiento del Proyecto	37
3	Delimitación del Objeto de Estudio	39
3.1	Problema de Investigación	39
3.2	Pregunta de Investigación	40
3.3	Hipótesis	40
3.3.1	Hipótesis Conceptual (HC)	40
3.3.2	Hipótesis Nula (H_0)	40
3.4	Objetivo General	41
3.5	Objetivos Específicos	41
3.6	Fundamento del Pivote Metodológico	41
3.6.1	Hipótesis Inicial y Necesidad de Pivote	41
3.6.2	Limitaciones del SF-36 como Ground Truth en Cohortes Pequeñas	42
3.6.3	Justificación del Pivote a Enfoque Data-Driven	42
3.6.4	Re-posicionamiento del SF-36: De Ground Truth a Validación Convergente	43
3.7	Justificación del Tamaño de Muestra ($N=10$)	43
3.7.1	Trade-Off: Profundidad Longitudinal vs. Cantidad de Participantes	43
3.7.2	Precedentes de Cohortes Pequeñas en Literatura Q1	43
3.7.3	Justificación de $N=10$ en Nuestro Estudio	44
3.8	Estrategia de Validación LOUO	44
3.8.1	Protocolo LOUO Implementado	44
3.8.2	Justificación Metodológica de LOUO	44
3.8.3	Limitaciones Reconocidas y Trabajo Futuro	45
4	Justificación	46
5	Materiales y Métodos	47
5.1	Diseño del Estudio	47
5.1.1	Pivote Metodológico	47
5.2	Población de Estudio	48
5.2.1	Estrategia de Reclutamiento	48

5.2.2	Tamaño de Muestra y Justificación Estadística	48
5.2.3	Características Demográficas de la Cohorte	49
5.3	Definición Operacional de Variables	49
5.3.1	Relación entre Variables	49
5.3.2	Variables Independientes	50
5.3.3	Variables Dependientes	50
5.3.4	Variables de Control	50
5.3.5	Operacionalización de las Variables	50
5.4	Preprocesamiento y Análisis Exploratorio de Datos	52
5.4.1	Extracción de Variables desde Apple HealthKit	52
5.4.2	Análisis de Calidad y Variabilidad de Datos	52
5.4.3	Transición a Ingeniería de Características	54
5.5	Ingeniería de Características y Agregación Temporal	54
5.5.1	Actividad Relativa	55
5.5.2	Superávit Calórico Basal	55
5.5.3	Delta Cardíaco	56
5.5.4	Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV-SDNN)	56
5.5.5	Agregación Semanal y Justificación de Medianas	56
5.6	Plan de Análisis Estadístico	57
5.6.1	Fase 1: Caracterización y Análisis de Variabilidad	57
5.6.2	Fase 2: Establecimiento de la Verdad Operativa mediante Clustering	57
5.6.3	Fase 3: Diseño y Configuración del Sistema de Inferencia Difusa	58
5.6.4	Fase 4: Validación del Sistema Difuso mediante Leave-One-User-Out	58
5.6.5	Fase 5: Análisis de Robustez y Contribución de Variables	59
5.7	Técnicas y Procedimiento	59
5.7.1	Selección del Dispositivo	59
5.7.2	Análisis de Sensores	59
5.7.3	Elección del Apple Watch	60
5.7.4	Protocolo del Instrumento	60
5.8	Base Metodológica del Sistema de Inferencia Difusa	62
5.8.1	Formalización Matemática del Sistema de Inferencia Difusa	65
5.9	Aspectos Éticos y de Bioseguridad	70
5.9.1	Principios Éticos	71
5.9.2	Procedimiento para Obtener el Consentimiento	71
5.9.3	Contenido del Formulario de Consentimiento	71
5.9.4	Evaluación de Riesgos	71

5.9.5	Protección de Grupos Vulnerables	72
5.9.6	Confidencialidad y Privacidad de los Datos	72
5.9.7	Política de Retención y Eliminación Segura	72
5.9.8	Derechos de los Participantes	73
5.9.9	Cumplimiento de Normativas y Legislación	73
5.9.10	Plan de Contingencia y Manejo de Incidentes	73
5.10	Financiamiento y Lugar Donde Se Realizará El Proyecto	74
6	Resultados	75
6.1	Caracterización de la Cohorte y Análisis de Variabilidad de Datos	75
6.2	Establecimiento de la Verdad Operativa: Análisis de Conglomerados	77
6.3	Rendimiento del Sistema de Inferencia Difusa	80
6.3.1	Posicionamiento en el Contexto de Estudios con Validación LOUO	80
6.4	Análisis de Robustez y Contribución Sinérgica de las Variables	84
6.4.1	Paradoja HRV: Debilidad Univariada, Fortaleza Multivariada	85
6.4.2	Validación Convergente Exploratoria con SF-36	86
6.5	Tesis	87
7	Discusión	89
7.1	Discusión de Hallazgos Principales	89
7.1.1	Desempeño Predictivo del Modelo Difuso en Validación Leave-One-User- Out	89
7.1.2	Paradoja de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca: Débil Univariada- mente, Crítica Multivariadamente	91
7.1.3	Robustez del Pipeline Híbrido: Clustering No Supervisado como Ground Truth Operativa	92
7.2	Comparación con Investigaciones Previas	94
7.2.1	Convergencias con la Literatura Científica	94
7.2.2	Divergencias Relevantes y Explicaciones	94
7.3	Logros de la Investigación	95
7.4	Limitaciones del Estudio	96
7.4.1	Limitaciones Metodológicas	96
7.4.2	Limitaciones Muestrales	97
7.4.3	Limitaciones Contextuales	98
7.4.4	Limitaciones de Recursos	98
7.5	Implicaciones de los Hallazgos	98
7.5.1	Implicaciones Teóricas	98

7.5.2	Implicaciones Prácticas	99
7.5.3	Implicaciones Metodológicas	100
7.6	Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis	100
7.6.1	Objetivo General	100
7.6.2	Objetivos Específicos	100
7.6.3	Hipótesis	101
7.7	Reflexión Final y Líneas Futuras de Investigación	102
8	Conclusiones	104
Anexos		105
8.1	Nomenclatura y Simbología Matemática	105
8.1.1	Símbolos Matemáticos Generales	106
Referencias		107

Introducción

El comportamiento sedentario (CS) se ha consolidado como uno de los principales retos de salud pública del siglo XXI, vinculado estrechamente con la transición epidemiológica, la urbanización acelerada y el cambio en los patrones de movilidad y trabajo. Las largas jornadas en posición sentada, el predominio de actividades digitales y la disminución de la actividad física incidental han generado un aumento sostenido en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la depresión. Este panorama, descrito por la Organización Mundial de la Salud (OMS), refleja la urgencia de desarrollar herramientas que permitan medir, interpretar y reducir los efectos del sedentarismo en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) Bull et al., 2020; Guthold et al., 2020; World Health Organization, 2020a.

El estudio del CS tradicionalmente se ha sustentado en instrumentos de autoinforme, como el GPAQ o el SF-36, que aunque válidos y ampliamente utilizados, presentan limitaciones inherentes a la subjetividad y la falta de resolución temporal Romero et al., 2022; Shamah-Levy et al., 2023. En la última década, el desarrollo de dispositivos portátiles con sensores biométricos —acelerómetros, fotopletismografía (PPG) y sensores de frecuencia cardíaca— ha permitido capturar datos fisiológicos y de actividad con alta precisión, abriendo la posibilidad de análisis objetivos, continuos y personalizados Henriksen et al., 2018; Strain et al., 2020; White et al., 2019. Esta evolución tecnológica sitúa al monitoreo digital de la salud como una pieza central en el diseño de intervenciones preventivas basadas en evidencia.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) y, particularmente, la lógica difusa, ofrecen un marco teórico y computacional idóneo para modelar fenómenos complejos donde las relaciones entre variables no son lineales ni deterministas. A diferencia de los métodos estadísticos tradicionales, la lógica difusa admite grados intermedios de pertenencia y permite representar razonamientos humanos en términos lingüísticos (.actividad alta", "HRV baja", riesgo moderado"), otorgando interpretabilidad y flexibilidad a los modelos biomédicos Kaur y Khehra, 2022; Ross, 2010; Zadeh, 1965. Su integración en sistemas de inferencia Mamdani posibilita traducir datos biométricos en reglas semánticamente comprensibles, fortaleciendo la capacidad explicativa de los algoritmos frente al enfoque opaco de los modelos de caja negra.

El presente proyecto propone un modelo de evaluación del comportamiento sedentario basado en lógica difusa e información biométrica proveniente del Apple Watch, que integra variables

de actividad física (minutos en movimiento, pasos diarios, gasto calórico) con indicadores autonómicos derivados de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV-SDNN). Este enfoque busca caracterizar la relación entre patrones de sedentarismo y percepción de CVRS, capturando la dinámica diaria del equilibrio entre esfuerzo, recuperación y bienestar. A través de un sistema de inferencia difusa con reglas adaptativas, se modela la interacción entre la activación fisiológica y los hábitos conductuales, ofreciendo una aproximación más precisa y contextualizada del impacto del sedentarismo sobre la salud.

Desde una perspectiva metodológica, el modelo difuso se nutre de datos reales obtenidos de Apple HealthKit, los cuales son procesados mediante un protocolo reproducible que garantiza la integridad y trazabilidad de la información. Se construye una base de control difuso con funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales para las variables de entrada, y un conjunto de reglas del tipo “Si actividad alta y HRV baja, entonces riesgo alto”. El sistema se valida mediante métricas de rendimiento (exactitud, sensibilidad y especificidad) y se contrasta con los resultados del SF-36, reforzando la consistencia del modelo entre mediciones objetivas y percepciones subjetivas.

La relevancia científica de este trabajo radica en su contribución a la comprensión integral del sedentarismo como fenómeno fisiológico y conductual, integrando la dimensión autonómica del organismo en el análisis de la actividad física. Su valor metodológico se centra en el desarrollo de un sistema explicable y flexible, capaz de adaptarse a distintas poblaciones y contextos de uso. Desde el punto de vista social, la investigación aporta un marco empírico para diseñar estrategias de promoción de la salud personalizadas y sostenibles, en consonancia con la Agenda 2030 y el Plan Mundial sobre Actividad Física 2018–2030 de la OMS World Health Organization, 2018.

En suma, este proyecto articula tres dimensiones convergentes: la necesidad epidemiológica de reducir el comportamiento sedentario, la oportunidad tecnológica de los dispositivos portátiles para capturar datos de alta resolución y el potencial analítico de la lógica difusa para transformar esos datos en conocimiento clínicamente significativo. Con ello, se establece un precedente metodológico para futuras investigaciones en salud digital, inteligencia artificial y promoción de la salud basada en evidencia.

Marco Teórico y Antecedentes

El presente capítulo profundiza en la comprensión del comportamiento sedentario (CS), un fenómeno que incide de manera significativa en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Se definen conceptos clave, se analizan sus efectos multifacéticos en la salud y se examinan las herramientas actuales para evaluarlos, incluyendo cuestionarios de autoinforme y tecnologías avanzadas. Además, se aborda la integración de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) como biomarcador y el papel de la inteligencia artificial (IA) y la lógica difusa (FL) en el análisis de datos biomédicos.

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Definición de Sedentarismo

El sedentarismo se refiere a un estilo de vida donde prevalece uno o varios CS que se prolongan de forma regular, y que requieren de poca o ninguna Actividad Física (AF) (Tremblay et al., 2010). Además, el concepto de Sedentarismo no excluye la práctica del Ejercicio Físico (EF), de forma que una persona puede ser considerada Sedentaria aun si llegara a practicar EF, pero sin llegar a cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo que se dedica mucho tiempo invertido en conductas sedentarias y prevalece una estimación de gasto calórico total diario muy bajo.

2.1.2 Definición del Comportamiento Sedentario

El CS se refiere a cualquier comportamiento realizado por el individuo en posición acostado, reclinado, sentado o de pie, mientras se está despierto, sin ambulación en dependencia de un bajo gasto energético (Tremblay et al., 2017). Como ejemplo, mientras se está sentado, reclinado o acostado, cuando se hace uso de dispositivos electrónicos, mientras se lee, o se está escribiendo, también cuando se va sentado en el autobús, automóvil o tren. De pie en una fila, de pie en la iglesia, de pie para una conversación de pasillo, y al usar un escritorio de pie, se consideran comportamientos sedentarios o estáticos. Por tanto, el CS se refiere a las actividades que no aumentan el gasto de energía sustancialmente por encima del nivel de reposo, con un gasto energético inferior a 1,5 Unidades Metabólicas Equivalentes (MET) (Álvarez et al., 2020; Pate et al., 2008).

Es importante mencionar que esta definición no es la única, el CS se puede categorizar de

varias maneras, según la duración, intensidad, frecuencia y cantidad total de AF (Tremblay et al., 2017).

2.1.3 Diferencia entre Comportamiento Sedentario e Inactividad Física

Es importante mencionar que el CS puede tener un impacto negativo en la salud, incluso en personas que cumplen con las recomendaciones de AF propuestas por la OMS. En otras palabras, paradójicamente, en la actualidad es posible cumplir con las recomendaciones de AF mediante EF y también presentar tiempos sedantes superiores a 8 horas por día, es decir, ser “físicamente activo pero sedentario” (Reyes Molina et al., 2023).

En la actualidad, se emplea el término sedentario o con alto CS para referirse a individuos que prolongan actividades con bajo gasto energético (Tremblay et al., 2017). Además, para referirse a personas sedentarias, se suele utilizar el término de persona con inactividad física o que es inactiva físicamente, cuando un individuo con un nivel de AF es insuficiente para cumplir con las recomendaciones actuales de AF propuesta por la OMS.

2.1.4 Directrices de la OMS sobre Actividad Física

Las últimas instrucciones que se enmarcan en las Directrices de AF y Hábitos Sedentarios del año 2020, la OMS ponen énfasis en que “cada movimiento cuenta”, se menciona que para reducir el CS es importante la promoción de la actividad física incidental ya que puede ayudar a incrementar gradualmente la AF realizada en un día hacia cantidades recomendadas para una salud óptima. No obstante, las recomendaciones de AF son las siguientes.

Para niños y adolescentes se recomienda realizar al menos una media de 60 minutos de AF diaria principalmente aeróbica de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana.

Los adultos deben acumular a lo largo de la semana un mínimo de entre 150 y 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada, o bien un mínimo de entre 75 y 150 minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa, o bien una combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, con el fin de obtener beneficios notables para la salud.

Por último, las personas mayores (a partir de 65 años) pueden realizar la AF como actividad recreativa o de ocio (juegos, deportes o ejercicios programados) y en el marco de los desplazamientos (caminar e ir en bicicleta o en algún otro medio rodado), el trabajo o los que haceres domésticos, en el contexto ocupacional, educativo, doméstico y comunitario cotidiano (Bull et al., 2020; World Health Organization, 2020b).

2.1.5 Actividad Física y Ejercicio Físico

La AF y el EF, aunque a menudo se usan indistintamente y son términos que son ampliamente utilizados para describir el movimiento humano, es relevante destacar que estos no son sinónimos, y sus definiciones difieren.

La AF es cualquier movimiento corporal producido por la contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por encima de un nivel basal (Caspersen et al., 1985). No obstante, también existen actividades físicas incidentales, como parte de las actividades físicas de la vida diaria que no posee estructura, no requiere compromiso de tiempo, y no tiene propósitos de salud, fines recreativos o del Principio FITT (i.e., Frecuencia, Intensidad, Tiempo, Tipo). Entre ellas, las realizadas en el hogar, trabajo, estudio y tiempo libre; como el uso de escaleras, desplazamientos activos, estar de pie, ir de compras, jardinería o tareas domésticas, AF ocupacional, actividades lúdicas con niños, paseo de mascotas, entre otras (Reyes Molina et al., 2023).

El ejercicio es una subcategoría de la AF que es “planificada, estructurada, repetitiva e intencional en el sentido de que el objetivo es mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física”. El ejercicio y el entrenamiento físico se utilizan con frecuencia de manera indistinta y general, se refieren a la AF realizada con el propósito de mejorar o mantener la condición física, el rendimiento físico o la salud (Caspersen et al., 1985).

2.1.6 Condición Física Relacionada con la Salud

Es necesario diferenciar la condición física que se relaciona con el rendimiento, de la condición física relacionada con la salud. Esta última, está determinada por la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza y resistencia muscular, la flexibilidad y la composición corporal. Mientras que la Condición Física relacionada con el Rendimiento lo está, por los factores relacionados con la salud más la coordinación, potencia, velocidad y equilibrio.

Por tanto, la Condición Física Relacionada con la Salud representa el estado de los sistemas metabólicos y de las variables predictoras para el riesgo de morbilidad y mortalidad, las cuales pueden alterarse de manera favorable al aumentar la AF o el EF regular sin que se produzca un aumento en el Volumen Máximo de Oxígeno ($VO_{2\text{máx}}$) relacionado con el entrenamiento (Riebe et al., 2018).

2.1.7 Actividad y Capacidad Aeróbica

La actividad aeróbica (también llamada resistencia o actividad cardiovascular), ocurre cuando los músculos grandes se mueven de manera rítmica durante un período sostenido. La actividad

aeróbica hace que la Frecuencia Cardíaca (FC) aumente y que la respiración se vuelva más difícil. La AF aeróbica tiene 3 componentes: intensidad, frecuencia y duración. La intensidad describe el esfuerzo con el que una persona trabaja para realizar la actividad. Las intensidades más estudiadas son moderadas (equivalentes en esfuerzo a caminar a paso ligero) y vigorosas (equivalentes en esfuerzo a correr o trotar). La frecuencia describe la frecuencia con la que una persona realiza actividad aeróbica. La duración describe cuánto tiempo una persona realiza una actividad (Piercy et al., 2018).

La capacidad aeróbica es una de las características más relacionada con la salud, debido a que representa una de las cualidades más importantes de la condición física. La ejecución de la actividad aeróbica requiere principalmente del estado funcional de los sistemas respiratorio, locomotor y cardiovascular (Riebe et al., 2018). La capacidad aeróbica o funcional, constituye una medida directa del grado general de salud ya que refleja la capacidad de funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, metabólico y respiratorio (González et al., 2018; Riebe et al., 2018).

2.1.8 Frecuencia Cardíaca

El control de la FC es el método más popular y sencillo de controlar la intensidad de la AF. Para ello se valora la FC de reposo y la Frecuencia Cardíaca Máxima ($FC_{máx}$) definida como el número máximo de latidos que puede realizar el corazón durante un minuto. Su utilidad se debe a la correlación relativamente lineal existente entre la FC y la intensidad del esfuerzo, valorada mediante el consumo de oxígeno expresado como $VO_{2máx}$ o también con los METs (Abellán et al., 2014).

En seguida, se muestran varias fórmulas de estimación, algunas son menos conocidas, pero todas están avaladas por estudios científicos que demuestran su validez, reproducibilidad y confiabilidad.

Fórmula de Fox & Haskell

Propuesta por la ACSM's expone la estimación de la $FC_{máx}$ de la siguiente manera (Fox & Haskell, 1968):

$$FC_{máx} \text{ (estimada)} = 220 - \text{edad (en años)} \quad (2.1)$$

Fórmula de Tanaka

Recomendada para el trabajo de personas mayores (Tanaka et al., 2001), ya que sus autores consideran que la fórmula de la ACSM's $FC_{máx}$ infravalora las pulsaciones reales en estas edades

la fórmula es la siguiente:

$$FC_{\text{máx}} (\text{estimada}) = 208 - (0,7 \times \text{edad}) \quad (2.2)$$

Fórmula de Karvonen

Desarrollada por el fisiólogo finlandés Martti Karvonen en 1957, es una herramienta sencilla y ampliamente utilizada para estimar la intensidad de trabajo aeróbico durante el ejercicio. Esta fórmula se basa en la Frecuencia Cardíaca en Reposo (FC_r) medida en posición de bipedestación y la $FC_{\text{máx}}$ de un individuo para determinar la que zona de intensidad según la FC objetivo para la AF (Abellán et al., 2014).

La fórmula de Karvonen se utiliza para establecer diferentes zonas de intensidad de entrenamiento:

- Zona de baja intensidad (40–60 %)
- Zona de intensidad moderada (60–70 %)
- Zona de alta intensidad (70–80 %)
- Zona de intensidad máxima (>80 %)

$$FC_{\text{obj}} = FC_r + (FC_{\text{máx}} - FC_r) \times \text{Int.} \quad (2.3)$$

2.1.9 Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV)

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) representa las fluctuaciones en el tiempo entre latidos consecutivos del corazón (Quigley et al., 2024; Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996). Estas variaciones son controladas por el sistema nervioso autónomo, lo que convierte a la HRV en un biomarcador no invasivo y continuo del estado autonómico del individuo. Una HRV alta generalmente se asocia con un buen estado de salud y una mayor capacidad de adaptación fisiológica, mientras que una HRV baja puede indicar estrés, fatiga o condiciones de salud subyacentes. El parámetro HRV-SDNN (desviación estándar de los intervalos NN) es una métrica común para cuantificar la HRV (Damoun et al., 2024; Laborde et al., 2017), proporcionando información valiosa sobre el equilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático. La integración de la HRV permite un monitoreo más dinámico y sensible de la respuesta fisiológica a la actividad física y el sedentarismo, ofreciendo una visión más completa del bienestar general (Bonneval et al., 2025).

2.1.10 MET (Equivalente Metabólico)

Un MET es la cantidad de oxígeno necesaria para el mantenimiento durante 1 minuto de las funciones metabólicas del organismo con el individuo en reposo y sentado, equivalente a $3,5 \text{ ml} \times \text{kg} \times \text{min}$. Además, el MET se utiliza para proporcionar la relación entre la tasa de energía gastada durante una actividad y la tasa de energía gastada en reposo. Los MET son una forma útil, conveniente y estandarizada de describir la intensidad absoluta de las actividades físicas (Riebe et al., 2018).

La prescripción basada en el coste energético de la actividad mediante MET, es la aplicación más lógica para sujetos aparentemente sanos y aquellos con valores altos de $\text{VO}_{2\text{máx}}$, pero resulta menos aplicable en personas con ENT o en individuos con baja capacidad funcional (Abellán et al., 2014).

La variable $\text{VO}_{2\text{máx}}$ es el producto del gasto cardíaco o débito cardíaco máximo ($\text{D} \cdot \text{lt sangre} \cdot \text{mín.}^{-1}$) y la diferencia arteriovenosa de oxígeno ($\text{mlO}_2 \cdot \text{lt sangre}^{-1}$), se expresa típicamente en términos relativos ($\text{ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$) en lugar de absolutos ($\text{ml} \cdot \text{min}^{-1}$), lo que permite comparaciones significativas entre individuos con diferente peso corporal. La variación significativa en $\text{VO}_{2\text{máx}}$ entre poblaciones y niveles de condición física se debe principalmente a diferencias en gasto cardíaco máximo (D) por lo tanto, el $\text{VO}_{2\text{máx}}$ está estrechamente relacionado con la capacidad funcional del corazón.

2.1.11 Dispositivos y Tecnologías Electrónicas Portátiles

Actualmente se habla de que vivimos una “cuarta revolución industrial” o una “cuarta revolución tecnológica” la cual precede a la era de la microelectrónica, las tecnologías de la información, tecnologías de las comunicaciones y por supuesto a la World Wide Web (internet). Lo que ha derivado en grandes innovaciones surgidas, que van desde la digitalización, el manejo de grandes volúmenes de información (Big data), la IA, la robótica, las neurociencias y la biotecnología, entre otras (Martínez et al., 2020).

La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es una organización líder en el desarrollo de normas internacionales para la electro-tecnología. Sus normas son utilizadas por millones de personas en todo el mundo para garantizar la seguridad, la eficiencia y la interoperabilidad de los productos eléctricos, electrónicos y relacionados.

De acuerdo con la IEC, para el uso de la palabra “Wearables” del inglés que se utiliza comúnmente para referirse a los “dispositivos y tecnologías electrónicas portátiles” se refiere a un amplio rango de dispositivos electrónicos que se pueden llevar puestos o integrados en la ropa u otros objetos.

La IEC define el alcance del Comité Técnico 124 (TC 124) como la “estandarización en el campo de los dispositivos y tecnologías electrónicas portátiles” e incluye; Materiales y dispositivos adheribles: Estos son dispositivos electrónicos delgados y flexibles que se pueden adherir a la piel u otras superficies. Materiales y dispositivos implantables, se trata de dispositivos electrónicos que se colocan quirúrgicamente debajo de la piel o dentro del cuerpo. Materiales y dispositivos ingeribles, son dispositivos electrónicos que se pueden tragar y viajar a través del sistema digestivo para realizar mediciones o administrar medicamentos. Materiales y dispositivos textiles electrónicos, se trata de textiles que incorporan componentes electrónicos, lo que les otorga nuevas funcionalidades (Comisión Electrotécnica Internacional, 2019).

2.1.12 Sensores integrados en dispositivos portátiles

Acelerómetro

Un acelerómetro es un sensor de chip que está formado por un elemento capacitivo microelectromecánico, y piezoeléctrico que detecta el cambio en la aceleración de una pequeña masa en el sensor, como el que se muestra en la Figure 2.1, el cual es un dispositivo que mide la fuerza estática que incluye la gravedad, y la fuerza dinámica que puede incluir vibraciones y movimiento. La forma en que mide es en metros por segundo al cuadrado (m/s^2) o por la fuerza G (g) que mide la aceleración de la gravedad.



Figura 2.1: Módulo de sensor tipo acelerómetro modelo MMA7361

Fotopletismografía

La Fotopletismografía (PPG) es una técnica ampliamente usada para medir la (FC) y la saturación de oxígeno en sangre (SpO_2) de manera no invasiva. Como ejemplo en la Figure 2.2 se

muestra el sensor óptico PPG modelo ADPD1081 que está basado en un sistema optoelectrónico formado por un diodo emisor de luz LED y un elemento fototransistor que funciona como receptor y que en conjunto se encargan de iluminar la piel, y detectar las variaciones lumínicas que se producen debido a los efectos de reflexión y absorción de la luz por la sangre en los vasos sanguíneos (Bent et al., 2020; Shcherbina et al., 2017).

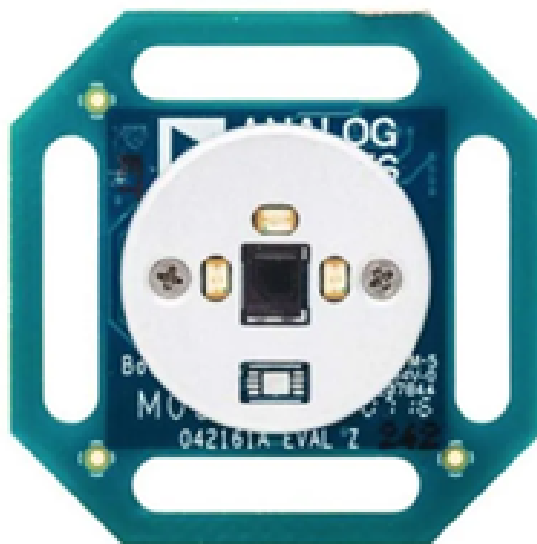


Figura 2.2: Sensor óptico PPG modelo ADPD1081

La FC y el $VO_{2\text{máx}}$ tienden a estar linealmente relacionados en una gran parte del rango de trabajo aeróbico. Cuando se conoce esta relación, la FC del ejercicio puede ser utilizada para estimar el $VO_{2\text{máx}}$, y luego calcular el gasto de energía durante las actividades de la vida diaria. Estudios recientes demuestran que las ventajas que presenta este método son: información acerca de la intensidad duración y frecuencia, por lo cual es adecuado para la mayoría de las personas, relativamente económico y permite un análisis fácil y rápido de los datos (Henriksen et al., 2018; White et al., 2019).

2.1.13 Inteligencia Artificial para el Reconocimiento del Comportamiento Sedentario

En el contexto de las ciencias de la computación, la IA se refiere a una disciplina y un conjunto de capacidades cognoscitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas, y que pueden mejorar conforme recopilen información. Sin embargo, durante la última década, la investigación de la IA en el ámbito de la salud y la medicina ha comenzado a mostrar resultados prometedores y aplicaciones prácticas, como la detección totalmente

automática de nuevos biomarcadores para el diagnóstico clínico (Farrahi & Rostami, 2024). La IA ha sido reconocida como una fuerza productiva y disruptiva en la atención médica llegando a considerarla como una herramienta innovadora con el potencial de impactar en las prácticas clínica (J. C. Santos et al., 2021; Syed-Abdul et al., 2020).

La tecnología portátil y los sensores están emergiendo como herramientas prometedoras para el monitoreo continuo y en tiempo real de la salud. Desde relojes inteligentes hasta rastreadores de AF y ropa conectada a Internet, los dispositivos portátiles equipados con sensores permiten a los usuarios medir y analizar datos relacionados con su estado fisiológico, actividades y bienestar general. Los rastreadores de AF contienen acelerómetros y monitores ópticos de fotoplethysmografía ya son ampliamente utilizados por los consumidores para contar pasos y controlar la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, estos sensores portátiles son de grado clínico para medir con precisión los signos vitales. Por ejemplo, la Presión Arterial (PA), la Frecuencia Respiratoria (FR), (SpO_2), la temperatura de la piel, y más. La integración inalámbrica y los algoritmos de IA permiten que los dispositivos portátiles realicen un seguimiento de los indicadores de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana y proporcionen comentarios a los usuarios (Khan et al., 2024).

2.1.14 Teoría de lógica difusa para el análisis de datos biométricos

La teoría de FL, desarrollada inicialmente por Lotfi Zadeh en 1965, se basa en la idea de que la verdad no siempre es una cuestión de blanco o negro, sino que puede estar en un espectro de grises. A diferencia de la lógica clásica, que trabaja con valores binarios (0 o 1), la FL permite valores intermedios, lo que la hace especialmente útil para manejar información imprecisa, vaga o incierta. Se ha demostrado que los sistemas difusos son aproximadores universales, esto se debe al isomorfismo entre dos álgebras; Un álgebra abstracta (que trata con grupos, campos y anillos) y un álgebra lineal (que maneja espacios vectoriales, vectores de estado y matrices de transición). Este isomorfismo refleja la estructura de un sistema difuso, que comprende una implicación entre acciones y conclusiones (antecedentes y consecuentes). Así como una función algebraica mapea una variable de entrada a una variable de salida, un sistema difuso mapea un grupo de entrada a un grupo de salida, que pueden ser proposiciones lingüísticas u otras formas de información difusa (Ross, 2010).

La base sobre la cual se asienta la teoría de sistemas difusos es un teorema fundamental del análisis real en álgebra conocido como el teorema de Stone-Weierstrass, desarrollado inicialmente por Weierstrass en 1885 y simplificado por Stone en 1937. Este teorema establece que cualquier función continua definida en un intervalo cerrado puede ser aproximada tan cerca como se desee por una función polinómica (Gupta, 2011; Ross, 2010). Los sistemas difusos, aprovechando este principio, tienen la capacidad de aproximar comportamientos de sistemas donde las funciones

analíticas o las relaciones numéricas no existen.

Los sistemas difusos son particularmente útiles en dos contextos generales: Primero en situaciones que involucran sistemas altamente complejos cuyos comportamientos no se entienden completamente. Segundo en situaciones donde una solución aproximada pero rápida es suficiente. Estos sistemas tienen un alto potencial para comprender sistemas complejos, tales como sistemas biológicos o médicos, donde la relación entre causas y efectos no se entienden completamente, pero pueden observarse (Kaur & Khehra, 2022).

2.1.15 Síntesis del Marco Conceptual

El marco teórico presentado establece la base conceptual para comprender la compleja interacción entre el comportamiento sedentario, la actividad física y la calidad de vida relacionada con la salud. La revisión de las definiciones, las directrices de la OMS y las tecnologías de monitoreo resalta la necesidad de enfoques innovadores. Las bases conceptuales para un modelo híbrido que integra mediciones objetivas de comportamiento sedentario, biomarcadores autonómicos continuos y herramientas de inteligencia artificial. La integración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la aplicación de la lógica difusa emergen como elementos clave para el desarrollo de un modelo más preciso y adaptable, capaz de capturar la dinámica de estas interacciones en contextos de vida real.

2.2 Antecedentes

En esta sección de antecedentes se enmarca la problemática actual que representa el comportamiento sedentario, y las principales motivaciones para realizar esta investigación. Se presentan los elementos básicos que permiten estudiar los patrones de CS y la percepción de la CVRS. Asimismo, se aborda la implementación IA al análisis de datos obtenidos de sensores biométricos en monitores de AF, portables de consumo público.

2.2.1 Impacto del Comportamiento Sedentario

El CS es un factor de riesgo importante para una serie de Enfermedades No Transmisibles (ENT), incluyendo obesidad, enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer, depresión y falta de sueño. Actualmente, el CS se contempla como parte de una Sindemia Global, lo que lo vuelve difícil de comprender. Existe un nexo entre los Riesgos Dietéticos, el alto Índice de Masa Corporal (IMC), y los Ambientes Obeso-Génicos con el estudio del CS, ya que estos factores combinados aumentan el riesgo de padecer ENT y están directamente relacionados con la Salud, Bienestar y CV de los individuos (Swinburn et al., 2019).

La investigación realizada de Murray et al. (2020), concluyó que ningún estado perteneciente a la OMS ha tenido una disminución significativa en la proporción de la población con IMC alto, entre 1990 y 2019 o en la última década. Dada la creciente prevalencia del CS en la sociedad moderna y su impacto adverso en la salud, la OMS desde el 2004 en la Asamblea Mundial de la salud emitió la “Estrategia Mundial de la OMS sobre Dieta, AF y Salud (DPAS por sus siglas en inglés)”, en donde se definía un plan de acción para implementar directrices sobre AF para la salud (Meusel et al., 2006).

A pesar del lanzamiento de la DPAS, ningún país ha revertido significativamente la tendencia al aumento de las tasas de obesidad o diabetes, Guthold et al. (2020) mencionan que la mayoría de los niños y adolescentes, no cumplen con los requerimientos mínimos de AF y que el CS en menores aumentó significativamente del 2001 al 2016. En los hallazgos de la OMS a través de la Encuesta sobre la capacidad de los países para afrontar las enfermedades no transmisibles (2021), se menciona que casi un tercio de los adultos tampoco alcanzan los niveles recomendados de AF. En México el CS en adultos es mayor llegando al 40 % según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 (Campos et al., 2023). Asimismo, se estima que, en 2019, las ENT provocaron cinco millones de muertes a nivel global y en la Región de las Américas, las ENT representan casi cuatro de cada cinco muertes anuales (Strategic Plan Advisory Group PAHO, 2020). Además, en 2022, aproximadamente 2500 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, igualmente 390 millones de menores padecían de sobrepeso (World Health Organization, 2022).

Como resultado, muchos países de ingresos bajos y medianos se enfrentan ahora a una carga cada vez mayor de riesgos modernos para la salud a medida que aumenta la esperanza de vida y las principales causas de muerte y discapacidad se desplazan hacia las ENT. Los costos actuales del CS se estiman en alrededor de más de \$300 000 millones de dólares al año a nivel mundial, esto debido a los costos directos de la atención médica y la pérdida de productividad económica (Okunogbe et al., 2021). Siendo la responsabilidad por la exposición a conductas sedentarias no solo de los individuos, sino también de los gobiernos y los ministerios de salud. Por tanto, la prevención y tratamiento se debe extender a toda la población no solo a los grupos que están clínicamente en alto riesgo de padecer una ENT (World Health Organization, 2009).

La consecución a esta problemática consiste en alcanzar la meta 3.4 de los ODS, que es reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT para 2030. Por consiguiente, se propone el plan de aceleración que se ha desarrollado en consonancia con las recomendaciones dirigidas a fortalecer y vigilar la reducción del CS, y su plazo coincide con la hoja de ruta 2023–2030 relativa a la ejecución del plan de acción mundial para la prevención y el control de las ENT 2013–2030. Aunado a esto en el “Informe sobre la situación mundial de la AF” mencionan que en la aplicación del el “Plan de acción mundial sobre AF 2018–2030 (GAPPA por sus siglas en inglés)” (World

Health Organization, 2022) la implementación ha sido lenta y desigual. Además, se ofrece una primera visión del impacto de la COVID-19, poniendo de manifiesto la importancia de la AF regular para la salud mental y física.

Recalcando que mientras el mundo sigue respondiendo a la pandemia de COVID-19 y recuperándose de ella, es necesario implementar medidas encaminadas a prevenir conductas sedentarias, que se detallan en las siguientes secciones.

2.2.2 Instrumentos de evaluación del Comportamiento Sedentario

Con relación a los sistemas de vigilancia y los instrumentos de evaluación es importante mencionar que hasta hace poco los principales métodos para medir la AF y los comportamientos sedentarios era a través de la auto notificación utilizando materiales de evaluación como el Cuestionario Mundial sobre AF (Global Physical Activity Questionnaire, GPAQ), la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (Global Student Health Survey, GSHS) y el cuestionario Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) (CDC & WHO, s.f.; World Health Organization, 2020a). Estos métodos tienen ventajas ampliamente demostradas. Sin embargo, el informe sobre la situación mundial de la AF del 2022 también reconoce una importante laguna en el seguimiento del GAPP. Entre ellas destaca la ausencia de vigilancia de la AF entre las personas con discapacidad, así como entre los niños menores de nueve años (World Health Organization, 2022).

Para poner en contexto en México Ensanut 2022, que es una encuesta probabilística con diseño de muestra polietápico y estratificado, con representatividad nacional y de ocho regiones en México. Para evaluar los niveles de AF en niños de 10–14 años, se utilizó la pregunta “En los últimos 7 días, ¿Cuántos días estuviste activo durante al menos 60 minutos al día?” del cuestionario (HBSC). Y aunque este instrumento de evaluación es ampliamente utilizado en México y en el mundo, posee limitaciones como la tendencia al sesgo de notificación (reportar de manera inexacta o incompleta la información) y el error de medición (utilizar instrumentos no adecuados o realizar mal las mediciones) (Romero et al., 2022).

Dado el reconocimiento de estas deficiencias en los sistemas de vigilancia, se propone por parte de la OMS el análisis de las potenciales ventajas que se tienen de recopilar datos de dispositivos portátiles y móviles. Para apoyar en el seguimiento de la AF buscando datos coherentes y congruentes que garanticen la armonía de los datos en su uso y eficiencia. Tomando en cuenta eso, menciona que se necesita un consenso mundial sobre las herramientas técnicas, los protocolos y los obstáculos financieros, para su uso en los sistemas de seguimiento nacionales y mundiales.

2.2.3 *Cómo afecta el CS en la CVRS*

Fomentar estilos de vida activos y saludables permite a la población, una mejor percepción de CVRS, de acuerdo con la investigación realizada por Chaves y cols., la capacidad aeróbica y la CVRS son condiciones que están asociadas a un declive que progresa con la edad y a estilos de vida sedentarios, en su investigación determinaron que la capacidad aeróbica tiende a disminuir a un ritmo entre 5 a 15 % por década, luego que un individuo pasa de los 30 años de edad en personas sedentarias, en contraparte, las personas físicamente activas pueden retener una reserva suficiente de aptitud aeróbica, para mantener la capacidad funcional durante su edad adulta (Chaves et al., 2017).

2.2.4 *Uso de sensores para el análisis del Comportamiento Sedentario*

Los monitores de AF más recientes, implementan el uso de sensores, los cuales son un dispositivo de entrada que mide una magnitud o un parámetro físico para proveer una salida que pueda ser manipulada por un sistema (Álvarez et al., 2020). Los sensores se clasifican de diversas maneras, pero las más comunes son por tipo de variable a medir o por el principio de transducción. Estos son componentes capaces de obtener, medidas fisiológicas, posición, orientación, velocidad etc. de cualquier dispositivo donde sea utilizado.

Acelerómetros

Dada la creciente preocupación por la salud y el comportamiento sedentario, se han hecho esfuerzos por medir de forma cuantitativa, las predicciones de gasto energético expresado en MET. Intentando categorizar la intensidad de la AF mediante el uso de acelerómetros. En un estudio realizado por Rothney et al. (2008) se buscó evaluar la exactitud de tres tipos de acelerómetros, ActiGraph, Actical y RT3, donde se implementó un método, que contemplo el uso de una cámara de calorimetría indirecta para validar su precisión. Llegando a la conclusión de que los monitores portátiles basados en acelerometría son un medio factible y objetivo para detectar patrones de comportamiento sedentario.

Sin embargo, los autores reconocen que hay algunas limitaciones en el estudio, como la dificultad para distinguir entre diferentes niveles de actividad. Los acelerómetros pueden tener dificultades para diferenciar entre comportamientos sedentarios muy baja intensidad, como estar sentado sin movimiento, y otros niveles de AF ligera. Esto puede llevar a cierta imprecisión en la clasificación de los periodos de actividad sedentaria.

De la misma forma la sensibilidad a la posición del dispositivo, la colocación del acelerómetro en el cuerpo puede afectar la precisión de las mediciones. Por ejemplo, algunos dispositivos

podrían no capturar adecuadamente ciertos movimientos o actividades si no se usan en la posición correcta. Además, las limitaciones en la detección de comportamientos específicos, los acelerómetros pueden tener problemas para detectar ciertos comportamientos sedentarios específicos, como estar de pie sin movimiento o realizar movimientos muy sutiles, sobre todo cuando se utilizan en la muñeca, lo que puede afectar la precisión de las mediciones.

En este contexto, Henriksen et al. (2018) indica que la precisión de un dispositivo portátil de seguimiento de AF en comparación con el IPAQ, subestima significativamente la cantidad de AF informada por los participantes. Más sus conclusiones respecto a las limitaciones fueron similares a las del artículo de Rothney et al. (2008). Pero igual recomiendan que los médicos y los profesionales de la salud pública sigan utilizando los cuestionarios para medir el CS a la par que los dispositivos portátiles ya que estos pueden ser útiles para algunos propósitos, como monitorear la AF en el día a día.

2.2.5 Monitores de Actividad Física Portables de consumo público

Los dispositivos que se llevan “puestos” (wearables) aprovechan los avances en la tecnología para monitorizar los signos vitales y otros parámetros biométricos a través de teléfonos inteligentes o dispositivos que se adosan al cuerpo como un reloj, bandas o ropa. Bhuyan y cols., sugieren que estos dispositivos pueden monitorear e integrar diferentes parámetros importantes para el tratamiento de comorbilidades en pacientes con ENT (Bhuyan et al., 2016). Es así que los esfuerzos de la comunidad de investigación biomédica por la relevancia de los múltiples hallazgos en torno a la medición de la AF, en la actualidad existen cientos de monitores wearables para el consumo público. Los cuales incorporan diferentes sensores, que arrojan múltiples variables fisiológicas, adoptando su uso como una estrategia para promover un estilo de vida activo.

Tal ha sido el impacto de los monitores wearables que las estadísticas proporcionadas en market.us por Scoop en 2023, reportaron que en el mercado mundial de dispositivos de fitness y bienestar digital se generó 19.3 mil millones de dólares en ingresos en 2022. Además, se espera que este mercado crezca a una tasa compuesta anual del 19.1 % entre 2023 y 2030, alcanzando un valor de 182.9 mil millones de dólares. Además, se espera que la penetración de usuarios de estos dispositivos aumente del 9.52 % en 2023 al 10.36 % en 2028 (Tajammul, 2023).

Validación de los Monitores de Actividad Física Portables

En el artículo de Wright y cols., exploraron el potencial de múltiples dispositivos wearables o monitores de AF portátiles. Estos dispositivos se basan principalmente en sensores de acelerometría para contar pasos y estimar el gasto energético. Si bien se encontró que muchos de estos

monitores tienen precisiones similares a los de grado de investigación para contar pasos, existen limitaciones inherentes a la tecnología de acelerometría para estimar con precisión el gasto energético, especialmente en actividades de vida libre que implican movimientos complejos y no cíclicos (Wright et al., 2017).

Por otro lado, el estudio de Dinesh y cols., se centraron específicamente en validar las estimaciones de gasto energético de los monitores ActiGraph GT1M y GT3X, ampliamente utilizados en investigación. Estos dispositivos también se basan en acelerometría, pero los autores encontraron que el factor determinante en la precisión de las estimaciones era la versión del firmware utilizado, que incluye los algoritmos de procesamiento de la señal de los acelerómetros (Dinesh et al., 2014).

Los hallazgos de ambos estudios se complementan al resaltar las fortalezas y limitaciones de los monitores de AF basados en acelerometría. Los estudios de Wright, Dinesh y cols., demostraron su utilidad para contar pasos, y expusieron las variaciones en las estimaciones de gasto energético dependiendo del firmware y las condiciones en contextos de vida libre (Dinesh et al., 2014; Wright et al., 2017).

Lo que sugiere la necesidad de estandarización y validación constante por parte de los fabricantes. Además, los resultados ponen de manifiesto la necesidad de explorar tecnologías alternativas o complementarias a la acelerometría para superar sus limitaciones en la evaluación del gasto energético en contextos de vida libre (Dinesh et al., 2014). Enfoques prometedores incluyen el uso de sensores de frecuencia cardíaca, temperatura corporal, conductancia eléctrica de la piel, entre otros, en combinación con algoritmos de ML para reconocer patrones de actividad complejos.

Wright, Dinesh y cols., comparten la idea de que los algoritmos utilizados en los monitores de AF de los consumidores para determinar, los pasos dados, la distancia recorrida y el gasto de energía, generalmente no se comparten con los investigadores. Incluso Dinesh y cols., mencionan que los monitores pueden estar utilizando enfoques de reconocimiento de patrones más robustos de lo que se utilizan en su estudio (Dinesh et al., 2014; Wright et al., 2017).

Por su parte Wright y cols., ponen en evidencia que las empresas no solo pueden cambiar sus algoritmos sin previo aviso, sino que es posible que no revelen este hecho después, por lo que es posible que los investigadores ni siquiera sepan sobre esta posible discontinuidad en sus datos a lo largo del tiempo. Además de las actualizaciones de firmware relativamente frecuentes que pueden cambiar los algoritmos, las empresas actualizan continuamente sus dispositivos, lo que hace que los modelos más antiguos queden obsoletos. Dejando a los investigadores en duda de hasta qué punto los estudios previos de validez de un dispositivo se aplicarían a sus sucesores.

Por tanto, no es razonable esperar que los monitores creados para consumidor coincidan

con la utilidad de los monitores desarrollados para la investigación porque se desarrollan para diferentes propósitos y con diferentes restricciones. Por ejemplo, facilidad de uso y mantener bajos los costos. Dejando entre dicho que los investigadores que utilicen monitores de AF de consumo deberán establecer la validez de estas herramientas de investigación, incluida la calibración de unidades y valores, así como la validez concurrente y predictiva de estos dispositivos.

Aunque no son los únicos desafíos, el artículo de Redenius y cols., mencionan que los monitores tienen una duración limitada de la batería por lo cual es posible que sea necesario recargarlos cuando se está realizando una actividad significativa. También, estos monitores dependen de la adherencia de los participantes al protocolo en condiciones de vida libre (Redenius et al., 2019). Por lo que, es importante mencionar que, aunque su investigación solo buscó la validez del Fitbit Flex entre sus resultados encontraron que el dispositivo sobre estimó la AF de moderada a vigorosa.

Desafíos especiales para el uso monitores de actividad física de consumo

El equipo conformado por Bhuyan y cols., apoyan el uso y empoderamiento, de la implementación de las biotecnologías, ya que estas hacen que la gestión y la prestación de asistencia sanitaria sean más eficientes, seguras y económica (Bhuyan et al., 2016). Más advierten, que una arista que rodea el uso de dispositivos “wearables” es que, se requiere un marco regulatorio para las políticas y prácticas de privacidad para este tipo de datos. Otra preocupación es que en una región con altos niveles de desigualdad se debe poner especial atención en que las nuevas tecnologías no amplíen las brechas existentes ni generen nuevas desigualdades el posible sesgo en el grupo de participantes, por lo que las disparidades socioeconómicas pueden afectar el reclutamiento de participantes a estudios debido a que no todos los individuos poseen un dispositivo “wearable”.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Martínez et al., 2020); Si no se aborda este sesgo de selección, un sector de nuestra población no estaría representado, y los resultados podrían no ser generalizables a toda la población. Dado que las personas de más bajos ingresos tienen menor capacidad para acceder a un conjunto variado de dispositivos, servicios, aplicaciones y contenidos que aquellos con ingresos más altos, y les es más difícil adquirir tecnología digital de punta, actualizar su capacidad para manipular las novedades tecnológicas y apropiarse de sus beneficios de manera oportuna.

Lo cual enmarca un problema para democratizar las tecnologías digitales que pueden contribuir a resolver problemas asociados con la promoción del bienestar físico y mental, el fomento del autocuidado a lo largo de la vida, la prevención del deterioro de las condiciones de salud ya existentes, la generación de alertas epidemiológicas, la gestión más oportuna de los servicios de salud, el manejo más efectivo de los recursos, entre otros.

Oportunidades para el uso monitores de actividad física de consumo

Como se abordó en puntos anteriores, la fuente predominante de incertidumbre en el análisis del comportamiento sedentario. Depende de las estimaciones del gasto energético que han demostrado ser difícil de captar mediante instrumentos subjetivos como los cuestionarios. Por tal motivo White y cols., concluyeron que los Bio-sensores, tienen el potencial de proporcionar una solución relativamente barata y fiable a este problema, Dejando en claro que es posible solo si se pueden diseñar modelos de inferencia válidos para estimar el gasto energético de la actividad a partir de las mediciones que se registran (White et al., 2019).

Otro estudio realizado por Strain y cols., uso un enfoque de armonización de redes para mapear la aceleración de la muñeca dominante de los datos obtenidos de 96,476 participantes del Biobanco del Reino Unido, ellos demostraron que la AF registrada por dispositivos portátiles representa una herramienta valiosa en la prevención del riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles (Strain et al., 2020). Además, mencionan que la utilización de datos objetivos y cuantificables proporciona una perspectiva más precisa sobre los hábitos de AF de los individuos, lo que facilita brindar una base sólida para el diseño de estrategias enfocadas a la intervención y promoción de la salud.

2.2.6 El enfoque de la Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos

En relación con la oportunidad de explotar los datos de los monitores portátiles de consumo público, destaca la importancia de la IA como una disciplina emergente para descubrir patrones, respaldar la toma de decisiones clínicas y gestionar eficientemente los recursos sanitarios (Yoo et al., 2012). Esta disciplina se presenta como una herramienta integral para abordar los complejos desafíos en la atención médica moderna, para diseñar estrategias efectivas de promoción de la salud. Por ejemplo, brindando retroalimentación valiosa para diseñar intervenciones personalizadas y fomentar estilos de vida más activos. Este enfoque no solo ofrece la oportunidad de recopilar datos detallados sobre los patrones de actividad, sino que también puede allanar el camino, para futuros avances donde convergen la tecnología y la medicina.

En la era actual, donde la tecnología de Bio-sensores ha avanzado significativamente, se ha desbloqueado el potencial de observar las señales fisiológicas de los pacientes de manera más detallada y se ha brindado la oportunidad de mejorar la atención médica de manera proactiva, no obstante, la verdadera transformación en la atención médica va más allá de la simple recopilación de datos. Paganelli y cols., mencionan que en la última década se han implementado múltiples investigaciones aprovechar al máximo esta riqueza de información, y que es imperativo convertir estos datos en conocimientos procesables (Paganelli et al., 2022).

Aquí es donde entra en juego el análisis de datos con IA. Ya que según Paganelli y cols., no está claro qué técnicas pueden adaptarse mejor a cada contexto. La capacidad de analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente y descubrir patrones ocultos es esencial para traducir los datos de los sensores en información significativa. Por tanto, en su objeto de estudio detalla cada dominio de aplicación, las tareas de análisis de datos, los sensores utilizados, las propiedades, los algoritmos, las fuentes de datos y los resultados obtenidos de los estudios analizados. A menudo, los resultados del análisis no se relacionan directamente solo con las condiciones de salud, sino también con otros temas relevantes, como el ahorro de recursos, el tiempo de respuesta, el monitoreo constante y la aplicabilidad de soluciones en diferentes contextos.

En el contexto del análisis de datos, es relevante aclarar que la IA es un campo de la informática que se centra en la creación de sistemas, que se pueden utilizar para una amplia gama de tareas, incluyendo el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Más existen otros términos que son subdisciplinas de la IA como por ejemplo los que se describen en la ilustración 3.

EL Aprendizaje Automático (ML) es una subdisciplina de la IA que se centra en el desarrollo de algoritmos que pueden aprender de los datos. Los algoritmos de ML pueden aprender sin ser programados explícitamente. En cambio, aprenden a partir de datos de entrenamiento. Igualmente, los algoritmos de lógica difusa (FL). Son una subdisciplina del ML que imita el razonamiento humano para tratar con información imprecisa o incompleta que, a diferencia de la lógica clásica, la FL solo permite valores verdaderos o falsos, la FL permite representar grados de verdad intermedios, como “muy cierto”, “algo cierto” o “poco cierto”. Esto la hace especialmente útil para modelar sistemas complejos y dinámicos donde la información no siempre es precisa o definitiva (Kaur & Khehra, 2022).

Implementar el uso de la IA artificial en el contexto de la biomedicina, según Amit y cols., para el reconocimiento de la AF, y la salud, requiere de técnicas de IA las cuales desempeñan funciones cruciales, en la interpretación y caracterización de la actividad, mediante la extracción automática de características, y con menos esfuerzo que un humano. Sin embargo, para enmarcar la implementar un modelo de análisis de datos utilizando IA se requiere de cierta complejidad, la cual se puede resumir, en las siguientes secciones. Preprocesamiento de los datos, extracción y selección de características, plan de modelado y aprendizaje (Amit Kumar et al., 2001).

2.2.7 Fundamento filosófico del enfoque difuso

El modelo de inferencia difusa se sustenta en dos principios clave propuestos por Lotfi Zadeh: la granularidad cognitiva y la ley de incompatibilidad. El principio de granularidad cognitiva reconoce que los seres humanos razonamos usando categorías lingüísticas amplias (granulares) en

lugar de valores numéricos exactos. Es decir, conceptos como “nivel de actividad bajo” o “calidad de vida alta” representan gránulos de información (etiquetas lingüísticas) que aglomeran muchos estados posibles bajo una misma denominación.

Esto permite manejar la vaguedad y la imprecisión inherentes a las percepciones humanas, haciendo que el sistema sea cognitivamente interpretable. En la teoría difusa, a cada concepto lingüístico se le asocia un conjunto difuso y una función de pertenencia que indica en qué grado un valor numérico pertenece a dicho concepto (Gupta, 2011; Ross, 2010). Gracias a esta granularidad, es posible describir entradas, salidas y reglas en lenguaje natural de forma simple, incorporando el conocimiento experto de forma directa (Gupta, 2011).

Por su parte, la ley de incompatibilidad de Zadeh establece una limitación fundamental en sistemas complejos: “cuando la complejidad aumenta, las sentencias precisas pierden significado y las sentencias significativas pierden precisión” (Levitz & Levitz, 1979). En otras palabras, mientras más complejo es un fenómeno, menos útiles resultan las descripciones numéricas exactas, y se hace necesario emplear descripciones aproximadas (borrosas) para conservar significado.

Este principio filosófico justifica el uso de lógica difusa en la evaluación del comportamiento sedentario y su efecto en la calidad de vida: dado que estos conceptos involucran múltiples factores humanos, es preferible modelarlos con categorías flexibles (“sedentarismo alto”, “actividad moderada”, etc.) en lugar de umbrales rígidos. La lógica difusa explota esta tolerancia a la imprecisión para lograr soluciones robustas en problemas complejos, privilegiando la significancia semántica por encima de la precisión absoluta. En suma, apoyándose en la granularidad cognitiva y la ley de incompatibilidad, el sistema difuso puede manejar la incertidumbre de las evaluaciones de estilo de vida de manera similar al razonamiento humano, obteniendo inferencias significativas a partir de datos imprecisos.

2.2.8 La Lógica Difusa en la Salud Digital y el Monitoreo Biométrico

Inicialmente, las aplicaciones de la lógica difusa se concentraron en la ingeniería de control a partir de la década de 1970 (Strefezza, 2009). Sin embargo, su capacidad para modelar sistemas complejos de manera más sencilla, junto con sus fundamentos matemáticos precisos, propició su expansión a diversas áreas como la medicina. En la actualidad, los avances han llevado a una integración creciente de la lógica difusa con otras técnicas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), dando lugar a sistemas híbridos, como los sistemas neuro-difusos (Ahmadi et al., 2018). Esta fusión mejora la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos fisiológicos en tiempo real, facilitando la identificación de patrones sutiles como lo podemos apreciar en la Table 2.1.

Tabla 2.1: Cuadro Comparativo de Artículos sobre Lógica Difusa en Aplicaciones Sanitarias

Técnicas de Lógica Difusa	Área de Aplicación	Tipos de Datos	Hallazgos Clave	Año
Sistema basado en lógica difusa en marco de IA, teoría de conjuntos difusos	Diagnóstico de Patologías (Informes de Laboratorio)	Parámetros cuantitativos de laboratorio (RDW, MCV)	Precisión impresionante, 83 % de probabilidad de identificar “normal”, mejora en precisión, recall y F-measure con más diagnósticos.	2024
Mapas Cognitivos Difusos (FCM), reglas difusas, variables lingüísticas	Diagnóstico de COVID-19	Síntomas clínicos (fiebre, tos, disnea, GI), historial de contacto	Herramienta viable de apoyo a la decisión, probabilidad de diagnóstico (ej. 72 % para COVID-19).	2020
Lógica difusa para pertenencia difusa, análisis multicriterio	Planificación de Comidas Personalizadas	Datos nutricionales, preferencias alimentarias, restricciones de salud	Planes de comidas flexibles y optimizados, considera múltiples factores (costo, cocina, tiempo).	2023
Lógica de primer orden con semántica difusa, algoritmo de razonamiento espacial	Reconocimiento de Nervios en Imágenes Médicas	Imágenes de RM anatómicas T2 y de difusión	Permite la planificación quirúrgica precisa, visualización de nervios en gemelo digital 3D, explicabilidad directa.	2025
Sistema experto difuso, fuzificación, mecanismo de inferencia, defuzificación	Control Metabólico en Diabetes Mellitus Tipo 2	Edad, IMC, tabaquismo, estrés, ejercicio, tratamiento farmacológico, dieta	Asiste a médicos en la evaluación del control metabólico.	2018

Este cuadro es fundamental para comprender la amplitud y profundidad de las aplicaciones de la lógica difusa en entornos clínicos. Al organizar sistemáticamente la información, permite una rápida visión general de los avances, facilita la comparación de diferentes enfoques metodológicos y sus idoneidades para diversos problemas clínicos, y destaca los resultados tangibles y las mejoras de rendimiento logradas por estos sistemas.

Siendo la lógica difusa una herramienta que se utiliza cada vez más en sistemas “IoT” para la reducción y el análisis de datos, así como para el diagnóstico inteligente de enfermedades, gestionando las incertidumbres y proporcionando enfoques robustos. El concepto de “sistemas difusos con big data y computación en la nube” es también un tema destacado en foros como FUZZ-IEEE 2025. La investigación actual muestra que la lógica difusa rara vez se utiliza de forma aislada en las aplicaciones de vanguardia en el sector sanitario (Alam et al., 2022). En cambio, se integra cada vez más con otros paradigmas de IA, como las redes neuronales, el aprendizaje automático y el IoT. Esta hibridación responde a la necesidad de combinar las fortalezas de la lógica difusa (manejo de la incertidumbre, interpretabilidad) con las capacidades de aprendizaje y escalabilidad de otros métodos de IA. Esta tendencia indica que los problemas complejos de atención médica requieren soluciones de IA multifacéticas, donde cada componente aporta su ventaja única, lo que conduce a sistemas más robustos, adaptativos e inteligentes.

2.2.9 *Sistemas Neuro-Difusos y Aprendizaje Automático Difuso*

Una dirección prominente es la integración de la lógica difusa con otros paradigmas de inteligencia artificial, lo que da lugar a sistemas híbridos más robustos y adaptables. La combinación de la lógica difusa con redes neuronales artificiales, conocida como sistemas neuro-difusos, es una tendencia significativa (Alam et al., 2022; Syaffa Zakaria et al., 2023). Estos sistemas fusionan conjuntos y reglas difusas con capacidades de aprendizaje adaptativo para mejorar la eficiencia del reconocimiento de patrones y la toma de decisiones. Esta sinergia permite el desarrollo automatizado de sistemas difusos, reduciendo el tiempo y el costo, al tiempo que mejora el rendimiento.

El campo avanza hacia la incorporación de técnicas difusas en los modelos de aprendizaje profundo. El objetivo es manejar la incertidumbre, proporcionar modelos interpretables y ofrecer robustez en entornos dinámicos (Shetty, 2018; Syaffa Zakaria et al., 2023; Tsoukalas & Uhrig, 1997).

2.3 Clustering No Supervisado y Establecimiento de Ground Truth

2.3.1 *Clustering como Herramienta de Descubrimiento de Patrones*

El aprendizaje automático no supervisado, específicamente el clustering (agrupamiento), es una técnica de descubrimiento de patrones que particiona un conjunto de datos en grupos homogéneos (clústeres) sin requerir etiquetas predefinidas (Yoo et al., 2012). En el contexto de wearables y análisis de actividad física, el clustering se ha aplicado principalmente como herramienta de ingeniería de características: los clústeres son el resultado final (descubrimiento de fenotipos) o una característica intermedia para otro modelo, no se utilizan para generar etiquetas de *ground truth* que parametren un clasificador interpretable.

2.3.2 *Línea de Base: Umbrales Heurísticos para Sedentarismo*

El estándar de facto actual en clasificación de sedentarismo se basa en umbrales heurísticos fijos. Razjouyan et al. (Razjouyan et al., 2018) establecen el enfoque más utilizado en evaluación de fragilidad mediante wearables: clasificación mediante Desviación Absoluta Media (MAD) de aceleración con umbrales predefinidos (Sedentario: $MAD < 1,5 \text{ MET}$; Actividad ligera: $1,5 \leq MAD < 3,0 \text{ MET}$; Actividad moderada-vigorosa: $MAD \geq 3,0 \text{ MET}$).

Este enfoque presenta limitaciones: (1) los umbrales (1.5, 3.0 MET) son fijos y no se ajustan por diferencias inter-individuales en capacidad aeróbica, (2) la MAD es un estimador indirecto de gasto energético con validez variable entre dispositivos, y (3) no captura la estructura multivariada de datos de wearables modernos (frecuencia cardíaca + aceleración + contexto).

2.3.3 *Vacío Metodológico: Clustering + Sistema de Inferencia Difusa*

Una revisión exhaustiva de la literatura Q1/Q2 (2018-2025) en la intersección de clustering no supervisado, sistemas de inferencia difusa y clasificación de comportamiento sedentario mediante wearables revela un **vacío metodológico crítico**: la tubería *Clustering No Supervisado* $\rightarrow$ *Sistema de Inferencia Difusa* no constituye una práctica estándar establecida.

Único precedente identificado: Gonçalves et al. (2021) implementan K-Means ($k = 2$) seguido de un FIS Mamdani para clasificar estabilidad humana a partir de datos cinemáticos, en un capítulo de actas de congreso Springer. La secuencia metodológica sugiere que K-Means estableció las etiquetas binarias (Inestable/Estable) que parametrizaron las reglas del FIS Mamdani.

Divergencia conceptual: La “lógica difusa” en reconocimiento de actividad humana (HAR) sigue dos caminos divergentes: (1) *Fuzzy Clustering* (Fuzzy C-Means) como algoritmo de agrupamiento que compite con K-Means, y (2) *Fuzzy Inference Systems* (Mamdani/Takagi-Sugeno)

como clasificador interpretable. La literatura no muestra tendencia a *combinar* estos paradigmas en secuencia (K-Means) $\rightarrow$ (FIS), dejando un vacío que este proyecto propone llenar.

2.4 Validación Cruzada Leave-One-User-Out en Wearables

2.4.1 LOUO: Estándar para Generalización Inter-Sujeto

La validación cruzada tradicional (k-fold) es inapropiada para datos longitudinales de wearables debido a dos problemas críticos: (1) **temporal leakage** (mezclar observaciones correlacionadas del mismo usuario permite al modelo “ver el futuro”), y (2) **identity leakage** (modelos aprenden características idiosincráticas de individuos en lugar de patrones generales).

La validación *Leave-One-User-Out* (LOUO), también conocida como *Leave-One-Subject-Out* (LOSO), es reconocida como el **estándar metodológico** para evaluar generalización inter-sujeto en wearables. En LOUO, el modelo se entrena con datos de $N - 1$ usuarios y se valida con el usuario restante, iterando hasta probar con todos los N usuarios. Esta estrategia simula el despliegue real del sistema en nuevos usuarios, evitando sobreajuste a individuos específicos.

2.4.2 LOUO en Cohortes Pequeñas ($N < 20$)

Estudios de alto impacto demuestran la viabilidad de LOUO en cohortes pequeñas con datos longitudinales ricos:

- **Ricotti et al. (2023, Nature Medicine):** $N = 21$ pacientes con distrofia muscular de Duchenne, seguimiento de 12 meses, 17 sensores IMU de cuerpo completo. LOSO + validación externa ($N = 44$), $R^2 \approx 0,90$ en predicción de trayectoria motora. Conclusión: “*La inteligencia artificial podría reducir el tamaño de cohorte necesario*” al aprovechar mediciones densas longitudinales.
- **Crozat et al. (2025, Sensors):** $N = 7$ pacientes neurológicos, sesión de 30 min con 7 acelerómetros. LOSO: $86.4\% \pm 5\%$ de detección de pasos. Argumento: “*LOSO está especialmente indicado en datos de sensores corporales debido a la alta variabilidad entre individuos.*”
- **Kaveh et al. (2024, Nature Communications):** $N = 9$ operadores, 35h de EEG intraauricular. LOUO: 93.3 % accuracy en usuarios no vistos.
- **Lu et al. (2018, Sensors):** $N = 11$ adultos, protocolo de 3h. LOSO para estimación de VO_2 : MAE=1.65 mL/kg/min, $R^2 = 0,92$.

Consenso emergente: Con $N \geq 7$, datos longitudinales ricos y validación LOUO rigurosa, es factible desarrollar modelos con métricas aceptables ($F1 > 0,85$, $R^2 > 0,90$) que generalicen a nuevos usuarios.

2.5 Vacíos en la Literatura y Posicionamiento del Proyecto

2.5.1 Identificación de Vacíos Metodológicos

Una revisión exhaustiva mediante búsqueda sistemática, análisis de 80+ referencias existentes y exploración de 600+ documentos en repositorio de literatura identificó **cinco vacíos metodológicos críticos**:

Vacío 1: Tubería Clustering → Sistema de Inferencia Difusa

La tubería que combina clustering no supervisado para generar ground truth operativa con Sistema de Inferencia Difusa parametrizado por los clústeres presenta un vacío documentable en revistas Q1/Q2 (2018-2025). **Único precedente:** Gonçalves et al. (2021) en actas de congreso. Esta combinación es lógicamente sólida: el clustering data-driven identifica patrones naturales (objetividad), mientras que el FIS Mamdani proporciona clasificación interpretable (transparencia).

Vacío 2: Reporte de Variabilidad (SD, CV %) en LOUO

De múltiples estudios LOUO revisados, solo Alinia et al. (2020) y Crozat et al. (2025) reportan desviación estándar y coeficiente de variación. Un CV % bajo ($< 10\%$) indica desempeño homogéneo entre usuarios; un CV % alto ($> 30\%$) sugiere que el modelo funciona bien solo en subgrupo de la cohorte.

Vacío 3: Normalización Person-Specific para Sedentarismo

Aunque %HRR (Heart Rate Reserve) está validado para actividad moderada-vigorosa (40-89 % HRR), su aplicación al rango completo (0-100 % HRR), incluyendo comportamiento sedentario ($< 30\%$ HRR), carece de documentación sistemática.

2.5.2 Síntesis: Posicionamiento del Proyecto

Este proyecto propone llenar los vacíos identificados mediante un **enfoque metodológico integrado** que combina: (1) Clustering no supervisado (K-Means) para establecer ground truth operativa data-driven, (2) Sistema de Inferencia Difusa Mamdani parametrizado por clústeres, proporcionando clasificación interpretable, (3) Validación LOUO rigurosa con reporte exhaustivo de

variabilidad ($F1 \pm SD$, CV %), y (4) Normalización person-specific extendida al rango completo de comportamiento.

Este enfoque integrado no solo llena vacíos individuales, sino que propone una *arquitectura metodológica coherente* que aborda simultáneamente los desafíos de interpretabilidad, validación rigurosa en cohortes pequeñas, normalización individual y manejo de datos complejos en wearables longitudinales.

Delimitación del Objeto de Estudio

3.1 Problema de Investigación

El comportamiento sedentario, definido como cualquier actividad en vigilia caracterizada por un gasto energético ≤ 1.5 equivalentes metabólicos (METs) en una postura sentada, reclinada o acostada, se ha consolidado como un determinante de salud pública de primer orden. Evidencia reciente de meta-análisis a gran escala confirma su asociación independiente con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, incidencia de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 (Katzmarzyk, 2023; A. C. Santos et al., 2023). La evaluación precisa de este comportamiento es, por tanto, un pilar para la estratificación del riesgo y el diseño de intervenciones efectivas. Sin embargo, los métodos de evaluación convencionales presentan una dicotomía metodológica que limita su aplicabilidad y precisión. Los instrumentos subjetivos, como los cuestionarios de autoinforme, aunque escalables, adolecen de sesgos de memoria y deseabilidad social que comprometen su validez (Healy et al., 2024; Prince et al., 2008). En contraparte, las técnicas objetivas de referencia, como la calorimetría indirecta o la actigrafía de grado investigativo, se restringen a entornos de laboratorio que no capturan la complejidad del comportamiento en condiciones de vida libre (Migueles et al., 2022).

La ubicuidad de los dispositivos portátiles de consumo ha generado una oportunidad sin precedentes para la monitorización objetiva, continua y longitudinal del comportamiento en el entorno ecológico del individuo. No obstante, la transición de la recolección masiva de datos a la generación de conocimiento clínicamente accionable presenta un desafío metodológico significativo. El reto principal reside en traducir flujos de datos multivariados y heterogéneos —actividad física, patrones de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y gasto energético— en una clasificación del sedentarismo que sea fisiológicamente significativa e individualizada (Deka & Deka, 2023). Los modelos de inteligencia artificial basados en aprendizaje profundo, comúnmente denominados “de caja negra”, aunque han demostrado una alta precisión en la clasificación de actividades, a menudo carecen de la interpretabilidad necesaria para su adopción en la práctica clínica, donde la auditabilidad de una recomendación es un imperativo ético y profesional (Vellido, 2020).

Este vacío metodológico —la ausencia de un sistema que integre de forma sinérgica múltiples biomarcadores de vida libre en una clasificación del sedentarismo que sea robusta, empíricamente validada e interpretable— constituye el núcleo del problema que se aborda en esta investiga-

ción. Los análisis estadísticos univariados han resultado insuficientes para capturar las complejas interacciones no lineales entre la actividad física, la función autonómica y la respuesta metabólica (Aubert et al., 2022). Por ejemplo, la relación entre la VFC y la actividad física es intrínsecamente no lineal y dependiente del contexto, lo que requiere enfoques de modelado que puedan manejar la incertidumbre y la vaguedad inherentes a los sistemas biológicos (Deka & Deka, 2023).

Para resolver este problema, esta investigación desarrolló un modelo de evaluación basado en un sistema de inferencia difusa tipo Mamdani. Este enfoque se apartó de una hipótesis inicial centrada en correlacionar datos objetivos con percepciones subjetivas, para en su lugar, validar el sistema experto contra una “verdad operativa” derivada de los propios datos mediante un análisis de conglomerados no supervisado. De este modo, el estudio se enfocó en resolver el problema fundamental de crear un clasificador objetivo, interpretable y validado para el comportamiento sedentario en condiciones de vida libre, utilizando datos longitudinales recopilados a través de dispositivos de consumo.

3.2 Pregunta de Investigación

¿De qué manera un modelo basado en lógica difusa puede clasificar el comportamiento sedentario, utilizando datos biométricos recopilados en condiciones de vida libre por dispositivos “wearables”?

3.3 Hipótesis

3.3.1 Hipótesis Conceptual (HC)

La clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa, basado en reglas que integran biomarcadores de actividad y función cardiovascular, exhibe una alta concordancia con la clasificación objetiva obtenida mediante un análisis de conglomerados no supervisado sobre los mismos datos.

3.3.2 Hipótesis Nula (H_0)

No existe una concordancia estadísticamente significativa entre la clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa y la clasificación obtenida mediante el análisis de conglomerados. Cualquier concordancia observada no es superior a la que se obtendría por azar.

3.4 Objetivo General

Construir y validar un modelo interpretable, basado en lógica difusa, para la clasificación del comportamiento sedentario a partir de datos biométricos de wearables recopilados en condiciones de vida libre.

3.5 Objetivos Específicos

1. Analizar los datos biométricos longitudinales para derivar un conjunto de variables semanales que representen cuantitativamente los patrones de actividad física y función cardiovascular de la cohorte de estudio.
2. Identificar los perfiles de comportamiento sedentario inherentes a los datos mediante la aplicación de un algoritmo de agrupamiento no supervisado, para establecer una clasificación de referencia empírica.
3. Diseñar un sistema de inferencia difusa que modele la relación entre las variables biométricas y los perfiles de comportamiento, estableciendo reglas lingüísticas con fundamento fisiológico.
4. Evaluar el desempeño del sistema de inferencia difusa mediante la determinación de su nivel de concordancia con los perfiles de comportamiento identificados por el método de agrupamiento.
5. Examinar la contribución de los componentes del modelo a través de un análisis de sensibilidad para determinar la importancia relativa de sus variables de entrada en el rendimiento clasificatorio.

3.6 Fundamento del Pivote Metodológico

3.6.1 Hipótesis Inicial y Necesidad de Pivote

La hipótesis inicial del proyecto planteaba entrenar un modelo supervisado de Redes Neuronales Artificiales (ANN) para predecir comportamiento sedentario utilizando como variable de referencia (*ground truth*) las puntuaciones del cuestionario SF-36 (Short Form Health Survey). Este enfoque asumía que: (1) la percepción subjetiva de calidad de vida correlaciona fuertemente con indicadores objetivos de comportamiento sedentario, (2) dicha correlación es suficientemente robusta para servir como “verdad de referencia” en entrenamiento supervisado, y (3) el tamaño de muestra ($N = 10$) es adecuado para entrenar un modelo ANN.

Resultados del análisis exploratorio: El análisis de correlación entre las 8 dimensiones del SF-36 y las variables del Apple Watch ($N = 8$ participantes con datos completos) reveló correlaciones moderadas-fuertes pero mayormente no significativas. La única correlación estadísticamente significativa tras corrección Bonferroni fue Salud Mental vs. Fuzzy_median: $r_s = 0,765$, $p = 0,027$. Otras dimensiones mostraron correlaciones marginalmente no significativas o direcciones contraintuitivas (correlaciones positivas entre salud física percibida e indicadores de sedentarismo).

3.6.2 Limitaciones del SF-36 como Ground Truth en Cohortes Pequeñas

El SF-36 es un instrumento validado para evaluación de calidad de vida relacionada con la salud en estudios epidemiológicos a gran escala. Sin embargo, su uso como *variable de referencia para entrenamiento supervisado* en cohortes pequeñas ($N < 20$) presenta limitaciones metodológicas:

1. **Limitación estadística:** Para detectar una correlación $r = 0,50$ (efecto moderado) con poder estadístico de 0.80 y $\alpha = 0,05$, se requiere $N \geq 29$ participantes. Con $N = 8 - 10$, solo correlaciones $r > 0,75$ (efectos muy grandes) alcanzarían significancia estadística.
2. **Desacople temporal:** El SF-36 evalúa percepción de salud en las “últimas 4 semanas” mediante preguntas retrospectivas, mientras que los wearables capturan comportamiento objetivo instantáneo minuto a minuto.
3. **Naturaleza subjetiva vs. objetiva:** Medidas objetivas (wearables) y subjetivas (cuestionarios) pueden capturar dimensiones ortogonales de salud, no necesariamente correlacionadas linealmente.

3.6.3 Justificación del Pivote a Enfoque Data-Driven

Dadas las limitaciones del SF-36 como ground truth, el proyecto pivotó a un **enfoque dual data-driven**:

1. **Paso 1 - Clustering No Supervisado (K-Means):** Utilizar únicamente los datos objetivos del Apple Watch para identificar patrones naturales de comportamiento mediante K-Means ($k = 2$: Sedentario/No Sedentario). Este clustering establece una “verdad operativa” (Operational Ground Truth) basada en la estructura inherente de los datos, no en percepciones subjetivas ni umbrales heurísticos predefinidos.

2. **Paso 2 - Sistema de Inferencia Difusa Mamdani:** Traducir los centroides y perfiles estadísticos de los clústeres identificados a reglas lingüísticas interpretables de un FIS Mamdani, permitiendo clasificación transparente de nuevas observaciones.

Ventajas metodológicas del pivote: (1) **Objetividad** (la ground truth proviene de patrones data-driven, no de umbrales arbitrarios ni percepciones subjetivas), (2) **Interpretabilidad** (el FIS Mamdani es “interpretable por diseño”), y (3) **Validación rigurosa** (LOUO evita temporal leakage e identity leakage, proporcionando métricas realistas de generalización inter-sujeto).

3.6.4 *Re-posicionamiento del SF-36: De Ground Truth a Validación Convergente*

Aunque el SF-36 resultó inadecuado como ground truth para entrenamiento supervisado, mantiene valor como *variable de validación convergente exploratoria*: (1) proporciona contexto clínico y datos demográficos que enriquecen la interpretación de hallazgos, (2) permite investigar si el sistema difuso (basado en datos objetivos) correlaciona con percepción subjetiva de salud, y (3) contribuye a la discusión sobre *qué constituye “ground truth”* en estudios de cohortes pequeñas.

Esta re-conceptualización transforma una aparente limitación (correlaciones no significativas) en una *fortaleza metodológica*: demuestra que no asumimos ingenuamente que cuestionarios son “verdad absoluta”, sino que adoptamos un enfoque crítico data-driven.

3.7 Justificación del Tamaño de Muestra (N=10)

3.7.1 *Trade-Off: Profundidad Longitudinal vs. Cantidad de Participantes*

El tamaño de muestra $N = 10$ puede considerarse limitado desde la perspectiva de estudios epidemiológicos transversales. Sin embargo, estudios longitudinales con wearables presentan un *trade-off* entre cantidad de participantes (N) y profundidad de medición por participante (semanas de seguimiento, frecuencia de muestreo):

$$\text{Información Total} \approx N_{\text{participantes}} \times T_{\text{semanas}} \times f_{\text{muestreo}} \quad (3.1)$$

3.7.2 *Precedentes de Cohortes Pequeñas en Literatura Q1*

Estudios de alto impacto demuestran que cohortes pequeñas ($N < 20$) son viables metodológicamente si se cumplen condiciones de mediciones intensivas, validación rigurosa y objetivos exploratorios claros. Ricotti et al. (2023, *Nature Medicine*), Crozat et al. (2025, *Sensors*), Kaveh et al. (2024, *Nature Communications*) y Lu et al. (2018, *Sensors*) publican con $N = 7 - 21$ en revistas

Q1, compartiendo características: protocolos exhaustivos, LOUO/LOSO y objetivos de viabilidad técnica.

3.7.3 *Justificación de $N=10$ en Nuestro Estudio*

Nuestro diseño ($N = 10$ participantes, 8 semanas de seguimiento, 4 variables biométricas) se alinea con estos precedentes: (1) profundidad longitudinal (8 semanas resulta en 1,337 observaciones semanales totales, comparable en volumen a estudios transversales con $N > 50$), (2) validación conservadora (LOUO proporciona métricas realistas de generalización), y (3) objetivo exploratorio (establecer proof-of-concept de la tubería Clustering $\rightarrow$ FIS Mamdani, no generalizar a población mexicana completa).

Análisis de poder retrospectivo: Con $N = 10$ y 1,337 observaciones, el diseño tiene poder estadístico $> 0,80$ para detectar tamaños de efecto $d \geq 0,8$ (grandes). Para efectos moderados ($d = 0,5$), el poder desciende a $\approx 0,55$. Nuestro diseño es *adecuado* para detectar diferencias clínicamente significativas entre patrones de comportamiento marcadamente distintos, consistente con el objetivo exploratorio.

3.8 Estrategia de Validación LOUO

3.8.1 *Protocolo LOUO Implementado*

Implementamos validación cruzada Leave-One-User-Out con 10 folds (uno por cada participante): en cada iteración $i = 1$ a 10, el conjunto de entrenamiento contiene datos de usuarios $\{1, \dots, 10\} \setminus \{i\}$, y el conjunto de prueba contiene datos del usuario i . Se entrena K-Means ($k = 2$) en el conjunto de entrenamiento, se parametriza el FIS Mamdani con los centroides resultantes, y se evalúa el FIS en el conjunto de prueba (usuario i). Las métricas finales se reportan como $F1 = \text{mean}(F1_1, \dots, F1_{10}) \pm \text{SD}$ y coeficiente de variación $CV \% = (\text{SD}/\text{mean}) \times 100$.

3.8.2 *Justificación Metodológica de LOUO*

La elección de LOUO sobre k-fold tradicional se fundamenta en: (1) evitar temporal leakage (no entrenar con semanas adyacentes a la semana de prueba), (2) simular despliegue real (cada validación involucra un sujeto no visto, exactamente el escenario clínico), y (3) revelar heterogeneidad (LOUO revela diferencias de desempeño entre usuarios que k-fold ocultaría al promediar).

3.8.3 *Limitaciones Reconocidas y Trabajo Futuro*

Limitaciones de N=10: (1) Generalización poblacional limitada (resultados reflejan cohorte específica de adultos jóvenes universitarios), (2) poder estadístico moderado (suficiente para efectos grandes, insuficiente para efectos pequeños), y (3) cada fold tiene solo 9 usuarios en entrenamiento (K-Means $k = 2$ es apropiado, $k > 3$ sería sobre-parameterizado).

Trabajo futuro: Validación externa en cohorte independiente ($N \geq 20$), análisis de validación temporal anidada, y exploración de modelos personalizados vs. modelo global.

Fortalezas que mitigan limitaciones: Datos longitudinales ricos (8 semanas vs. 1 sesión en múltiples estudios), multimodalidad (4 variables biométricas + contexto clínico), y objetivo exploratorio claro (proof-of-concept de tubería novel K-Means $\rightarrow$ FIS Mamdani).

Justificación

La prevalencia del comportamiento sedentario (CS) en la sociedad contemporánea es un fenómeno alarmante que afecta significativamente la salud y la calidad de vida de las personas (Guthold et al., 2020; Swinburn et al., 2019). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado el CS como uno de los principales factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer (DiPietro et al., 2020; Murray et al., 2020; Okunogbe et al., 2021; World Health Organization, 2009). Además, el sedentarismo tiene un impacto negativo en la salud mental, y una disminución en la calidad de vida (DiPietro et al., 2020; Guthold et al., 2020; Swinburn et al., 2019).

La investigación propuesta propone una innovadora aproximación para abordar este problema. Utilizando dispositivos portátiles equipados con sensores biométricos y tecnologías de inteligencia artificial, se busca identificar y analizar patrones de CS en individuos. La combinación de estos datos con cuestionarios de autoinforme permitirá una evaluación integral de cómo el CS afecta la calidad de vida relacionada con la salud.

La relevancia de esta investigación radica en su enfoque multidisciplinario, que integra conocimientos de ciencias de la salud, tecnología de bio-sensores en dispositivos wearables y análisis de datos con Inteligencia Artificial. Este enfoque con el uso de algoritmos de lógica difusa (FL) en el procesamiento de datos, permitirá manejar la incertidumbre y la variabilidad inherentes en los datos de actividad física (AF) para la identificación de patrones de CS y que permitan contrastar estos resultados con la percepción de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), medida a través de cuestionarios de autoinforme para obtener una comprensión más profunda de la relación entre el sedentarismo y el impacto en la calidad de vida.

Por tanto, esta propuesta aborda una necesidad urgente en el ámbito de la salud pública en la implementación de estrategias para reducir el CS que promuevan nuevas fórmulas de políticas y programas de salud más efectivos y basados en evidencia.

Materiales y Métodos

5.1 Diseño del Estudio

El estudio empleó un diseño cuantitativo, observacional, longitudinal retrospectivo con seguimiento multianual (2021-2024) de una cohorte de 10 participantes adultos. Se basó en la validación convergente de un sistema de inferencia difusa tipo Mamdani contra una clasificación de referencia empírica (verdad operativa, GO) derivada de un análisis de conglomerados no supervisado sobre datos biométricos semanales agregados.

La unidad de análisis correspondió a semanas completas de monitoreo ($n=1,337$ semanas válidas de 183 totales), donde cada observación semanal integró la mediana ($p50$) y el rango intercuartílico (IQR) de cuatro variables biométricas derivadas: Actividad Relativa, Superávit Calórico Basal, Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV-SDNN) y Delta Cardíaco.

5.1.1 Pivote Metodológico

El enfoque metodológico se apartó del diseño correlacional original, que planteaba relacionar métricas objetivas (biométricas) con percepciones subjetivas de calidad de vida (SF-36). Este pivote se fundamentó en tres razones convergentes documentadas en literatura:

1. **Limitaciones de potencia estadística:** Con $N=10$ participantes, el poder para detectar correlaciones moderadas ($r<0.70$) entre variables biométricas y SF-36 es insuficiente ($1-\beta<0.50$). Healy et al. Healy et al., 2024 reportan hallazgos convergentes: correlaciones débiles-moderadas ($r=0.3-0.5$, no significativas) entre cuestionarios de actividad física y métricas objetivas de wearables en cohortes $N<15$.
2. **Baja adherencia al cuestionario:** Solo 8 de 10 participantes completaron el SF-36, y el análisis retrospectivo reveló correlaciones mayormente no significativas ($p>0.05$) excepto para Salud Mental (ver Sección 6.4.2).
3. **Autopercepción vs. comportamiento objetivo:** Prince et al. Prince et al., 2008 demuestran que autorreportes y mediciones objetivas representan constructos relacionados pero no intercambiables, con concordancia limitada ($Kappa<0.50$) debido a sesgos de deseabilidad social y error de memoria.

En su lugar, se adoptó una estrategia de validación interna basada en la convergencia entre dos paradigmas: uno empírico (descubrimiento de patrones mediante agrupamiento K-Means) y uno experto (modelado basado en conocimiento mediante lógica difusa Mamdani). Este enfoque, validado por Gonçalves et al. Gonçalves et al., 2021 en clasificación de estabilidad humana, permite aprovechar la riqueza del conjunto de datos longitudinal ($n=1,337$ semanas) en lugar de limitarse a comparaciones inter-usuario con potencia estadística reducida.

5.2 Población de Estudio

La cohorte final del estudio estuvo compuesta por 10 adultos jóvenes (5 mujeres, 5 hombres; rango etario: 25-39 años) reclutados mediante convocatoria abierta en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua entre septiembre de 2021 y enero de 2022.

5.2.1 Estrategia de Reclutamiento

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia basado en el paradigma *Bring Your Own Device* (BYOD; Doherty et al., 2021). Los criterios de inclusión se basaron en:

1. Propiedad de un Apple Watch Series 3 o superior
2. Uso continuo del dispositivo por al menos 6 meses previos (para minimizar efectos de habituación)
3. Edad entre 18 y 65 años
4. Capacidad ambulatoria sin limitaciones severas
5. Disponibilidad para exportar datos históricos del ecosistema HealthKit

5.2.2 Tamaño de Muestra y Justificación Estadística

El tamaño final de $N=10$ participantes se justificó por el carácter longitudinal del diseño. Cada participante generó un promedio de 133.7 semanas válidas (mediana: 131 semanas; rango: 7-298 semanas), resultando en 1,337 observaciones semanales independientes para el modelado.

Este enfoque se alinea con el paradigma de **muestras densamente monitoreadas** (*intensive longitudinal designs*; Bolger y Laurenceau, 2013), donde el poder estadístico proviene del número de observaciones temporales por sujeto (n_{obs}) más que del número de sujetos (N):

$$\text{Poder} \propto N \times \bar{n}_{\text{obs/sujeto}} \quad (5.1)$$

Con $N=10$ y $\bar{n}_{\text{obs}}=133.7$, se obtuvo $n_{\text{total}}=1,337$, superando el mínimo recomendado ($n_{\text{total}} \geq 500$) para agrupamiento estable y validación Leave-One-User-Out robusta Alinia et al., 2020.

5.2.3 Características Demográficas de la Cohorte

La distribución balanceada por sexo (50 %/50 %) y el amplio rango de seguimiento (7-298 semanas; CV=86 %) permiten capturar heterogeneidad inter-sujeto e intra-sujeto, características esenciales para evaluar la robustez del sistema de inferencia difusa en condiciones de vida libre. Las características detalladas se presentan en la Table 5.1.

Tabla 5.1: Características Demográficas de la Cohorte (N=10)

Usuario	Sexo	Edad	IMC	Semanas	% Válidas
u1	F	34	23.5	149	100 %
u2	F	37	26.6	7	100 %
u3	F	39	28.7	141	100 %
u4	M	25	30.9	14	100 %
u5	F	28	25.0	14	100 %
u6	M	34	30.9	278	100 %
u7	M	32	37.8	114	100 %
u8	M	29	28.1	191	100 %
u9	M	32	36.2	298	100 %
u10	F	28	21.6	131	100 %
Media±SD	5M/5F	31.8±4.5	28.9±5.1	133.7±95.3	100 %

5.3 Definición Operacional de Variables

5.3.1 Relación entre Variables

La relación de interés en este estudio se centró en analizar si los patrones de actividad física (AF) y comportamiento sedentario (CS) capturados objetivamente mediante wearables se asocian con diferencias en indicadores de salud. La hipótesis planteó que un modelo de inteligencia artificial basado en lógica difusa, entrenado con datos biométricos obtenidos de monitores portátiles, permitiría clasificar con precisión los niveles de sedentarismo semanales.

Se espera que, a mayor presencia de CS, se observen menores puntuaciones en la percepción de la CVRS, mientras que niveles más altos de AF estarán asociados con puntuaciones más

altas en la percepción de la CVRS. Estas predicciones, combinadas con un análisis estadístico basado en los resultados del cuestionario SF-36, buscan identificar correlaciones significativas entre las variables estudiadas, proporcionando evidencia cuantitativa de cómo el CS y la AF influyen en la calidad de vida.

5.3.2 Variables Independientes

Datos cuantitativos del Apple Watch: Número de pasos por día, horas estacionarias, minutos totales en movimiento, gasto calórico activo, frecuencia cardiaca promedio, entre otras.

5.3.3 Variables Dependientes

- Precisión del algoritmo de inteligencia artificial con lógica difusa en la estimación de la categorización de la AF y el CS.
- Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), medida con el cuestionario SF-36, analizando sus dimensiones (Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional, Salud mental) y la Puntuación Global.

5.3.4 Variables de Control

Edad, sexo, peso y estatura, entre otras. Se registran para aislar su efecto sobre la asociación AF/CS–CVRS.

5.3.5 Operacionalización de las Variables

La Table 5.2 presenta las variables recolectadas en el instrumento, las cuales corresponden a la recolección de los datos biométricos obtenidos mediante la selección de características del Apple Health, así como la aplicación del cuestionario de salud SF-36 y su correspondiente puntuación y recodificación de valores obtenidos.

Tabla 5.2: Variables Recolectadas en el Instrumento

Variable	Tipo	Tipo de Variable	Escala	Descripción / Observaciones
Sexo	Independiente	Catórica	Nominal	Indica el sexo biológico de la persona (p. ej., Masculino / Femenino).
Edad	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Años cumplidos. Suele considerarse discreta (entera); sin embargo, para algunos análisis se maneja como aproximación continua.
Peso (kg)	Independiente	Núérica	Continua	Medición del peso corporal en kilogramos.
Estatura (m)	Independiente	Núérica	Continua	Medición de la talla en metros.
Número de horas con deambulación	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas (o fracción) en las que el usuario registra algún tipo de desplazamiento (de pie, caminando).
Número horas estacionarias	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas (o fracción) en las que el usuario permanece en posición estacionaria.
Total de horas monitorizadas	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas totales en las cuales el Apple Watch registra actividad (pueden ser horas efectivas de uso diario).
Horas sin registro	Independiente	Núérica	Discreta/Continua	Horas no registradas por el dispositivo (por ejemplo, si el usuario no lo llevaba puesto).
Minutos totales en movimiento	Independiente	Núérica	Discreta (minutos)	Total de minutos en movimiento (podría convertirse a horas si fuera necesario).
Total de minutos de ejercicio diario	Independiente	Núérica	Discreta (minutos)	Minutos diarios destinados a actividad física clasificada como “ejercicio” (según los criterios del Apple Watch).
Distancia caminada en kms	Independiente	Núérica	Continua	Distancia recorrida a pie medida en kilómetros (con decimales).
Número de pasos por día	Independiente	Núérica	Discreta	Conteo total de pasos diarios.
Frecuencia cardíaca al caminar promedio diario (lpm)	Independiente	Núérica	Continua	Este valor refleja el estado del sistema cardiovascular durante períodos de inactividad o descanso y se considera un indicador clave de la salud general y la condición física.
Frecuencia cardíaca de reposo promedio diario (lpm)	Independiente	Núérica	Continua	Frecuencia cardíaca de reposo promedio diario.
Gasto calórico activo (kcal)	Independiente	Núérica	Continua	Estimación del gasto calórico activo según el Apple Watch, en kilocalorías.
Función física (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Dimensión del SF-36 (puntaje 0 a 100). Evalúa la capacidad para realizar actividades físicas.
Rol físico (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Dimensión del SF-36 que evalúa las limitaciones físicas en la vida diaria.
Dolor corporal (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Percibe la intensidad y frecuencia del dolor, afecta la calidad de vida.
Salud general (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Percepción global de salud, síntoma de la salud percibida.
Vitalidad (SF-36)	Dependiente	Núérica (Escala)	Continua	Evalúa energía, fatiga y cansancio.

5.4 Preprocesamiento y Análisis Exploratorio de Datos

5.4.1 Extracción de Variables desde Apple HealthKit

Los archivos `export.zip` generados por la aplicación Apple Health contienen datos biométricos en formato XML estructurado. Para facilitar su análisis, se empleó el script de código abierto `apple_health_data_converter.py` Gaur, 2024, el cual convierte los registros XML a archivos CSV tabulares.

Del ecosistema HealthKit se extrajeron inicialmente 9 variables diarias, correspondientes a métricas de actividad física, gasto energético y biomarcadores cardiovasculares (ver Table 5.4):

Tabla 5.4: Variables Originales Extraídas de Apple HealthKit

Variable	Unidad	Tipo HealthKit	Descripción
Pasos diarios	count	HKQuantityTypeIdentifier-StepCount	Conteo total de pasos acumulados en 24 horas
Distancia	km	HKQuantityTypeIdentifier-DistanceWalkingRunning	Distancia recorrida en actividades ambulatorias
Calorías activas	kcal	HKQuantityTypeIdentifier-ActiveEnergyBurned	Gasto energético activo (excluyendo tasa metabólica basal)
Minutos ejercicio	min	HKQuantityTypeIdentifier-AppleExerciseTime	Tiempo en actividades ≥ 3 METs
FC reposo	lpm	HKQuantityTypeIdentifier-RestingHeartRate	Frecuencia cardíaca mínima diaria
FC al caminar	lpm	HKQuantityTypeIdentifier-WalkingHeartRateAverage	Frecuencia cardíaca promedio en marcha
HRV-SDNN	ms	HKQuantityTypeIdentifier-HeartRateVariabilitySDNN	Variabilidad de la frecuencia cardíaca
Horas monitoreadas	h	Calculado	Tiempo con señal válida del dispositivo
Horas sedestación	h	HKCategoryTypeIdentifier-AppleStandHour	Tiempo sin romper sedestación prolongada

Nota: HK = HealthKit. METs = Equivalentes Metabólicos. FC = Frecuencia Cardíaca. HRV-SDNN = Heart Rate Variability - Standard Deviation of NN intervals.

5.4.2 Análisis de Calidad y Variabilidad de Datos

Un análisis exploratorio preliminar reveló tres desafíos metodológicos que motivaron las decisiones de preprocesamiento subsecuentes:

Heterogeneidad Inter-Sujeto Extrema

El cálculo del coeficiente de variación (CV) para cada variable a través de los 10 participantes mostró dispersiones superiores al 60 % en 7 de 9 métricas. Como se observa en la Figure 5.1, variables como *Pasos diarios* presentaron CV=72 %, reflejando diferencias sustanciales en edad, composición corporal, ocupación y nivel de condicionamiento físico entre participantes.

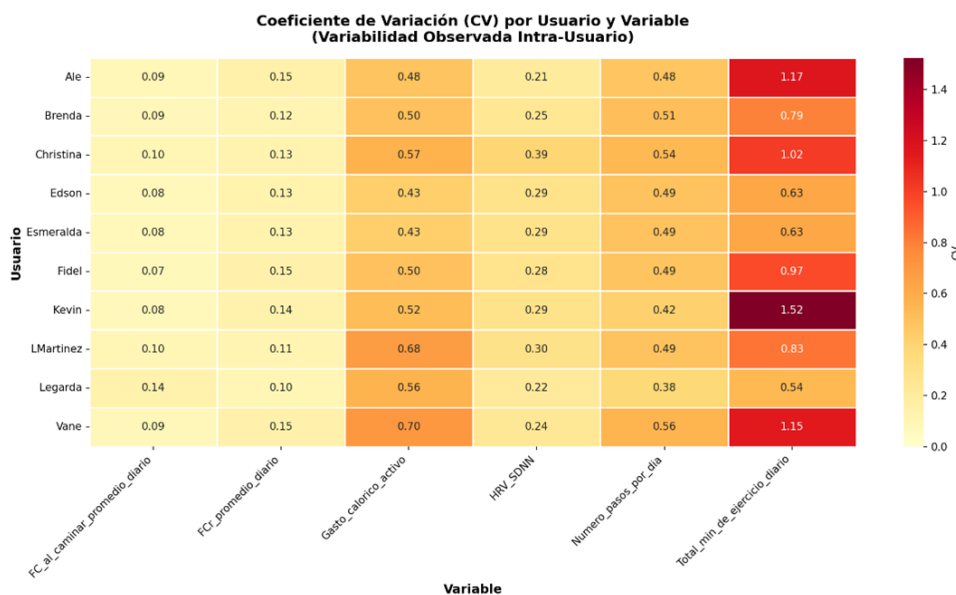


Figura 5.1: Coeficiente de Variación de Variables Originales por Usuario

Esta heterogeneidad extrema justifica la normalización individualizada implementada posteriormente en la ingeniería de características (Sección 5.5), donde cada variable se ajusta por exposición temporal y metabolismo basal del usuario.

Datos Faltantes Estratificados por Usuario

El análisis de datos faltantes (*missingness*) reveló patrones heterogéneos entre participantes: 3 usuarios con menos del 5 % de datos faltantes, 4 usuarios con 10-20 %, y 3 usuarios con más del 20 % (principalmente en FC al caminar y HRV-SDNN, variables dependientes de algoritmos de detección de señal fotopletismográfica).

Se implementó una estrategia de imputación jerárquica priorizando:

1. Interpolación lineal para gaps menores a 3 días consecutivos
2. Mediana móvil de 7 días (ventana retrospectiva) para gaps de 3-7 días

3. Imputación por usuario mediante mediana histórica individual para gaps mayores

Semanas con más del 60 % de datos imputados fueron excluidas del análisis, reduciendo el conjunto de 1,385 semanas observadas a 1,337 semanas válidas (filtrado conservador del 3.5 %).

Multicolinealidad Moderada entre Variables de Actividad

El análisis de correlación de Pearson entre las variables originales mostró correlaciones moderadas-altas ($r > 0,60$) entre:

- Pasos diarios $\leftrightarrow$ Distancia recorrida ($r = 0,89$)
- Pasos diarios $\leftrightarrow$ Calorías activas ($r = 0,72$)
- Minutos ejercicio $\leftrightarrow$ Calorías activas ($r = 0,68$)

Esto motivó el diseño de variables derivadas que: (a) reduzcan redundancia informativa, y (b) normalicen por exposición temporal y metabolismo basal, permitiendo comparaciones equitativas entre usuarios con diferentes características antropométricas.

5.4.3 Transición a Ingeniería de Características

Los hallazgos del análisis exploratorio —heterogeneidad extrema ($CV > 70\%$), datos faltantes estratificados (5 % a 20 %), y multicolinealidad moderada ($r > 0,60$)— evidenciaron que las variables originales de HealthKit no son directamente comparables entre usuarios en su forma bruta.

Esta conclusión fundamenta el diseño de las cuatro variables derivadas con normalización fisiológica presentadas en la siguiente sección (Sección 5.5), las cuales transforman métricas absolutas en indicadores relativos ajustados por las características individuales de cada participante.

5.5 Ingeniería de Características y Agregación Temporal

A partir de las métricas diarias registradas por el Apple Watch mediante el ecosistema HealthKit, se derivaron cuatro variables semanales mediante transformaciones fisiológicamente fundamentadas y normalización individualizada. La literatura de fisiología del ejercicio establece que las respuestas cardiovasculares y metabólicas al movimiento presentan alta variabilidad inter-individual debido a diferencias en: (1) capacidad aeróbica ($VO_2\max$), (2) composición corporal, (3) edad, y (4) estado de entrenamiento Riebe et al., 2018. Por tanto, la normalización intra-sujeto es un principio metodológico estándar para permitir comparaciones equitativas Ho et al., 2022; Schrack et al., 2018.

5.5.1 Actividad Relativa

Inspirada en el concepto de Reserva de Frecuencia Cardíaca (%HRR; Schrack et al., 2018), esta variable normaliza el conteo de pasos por las horas de uso efectivo del dispositivo y un factor de escala (1000), generando un índice de densidad de actividad:

$$\text{Actividad_relativa} = \frac{\text{Pasos_diarios}}{\text{Horas_con_datos} \times 1000} \quad (5.2)$$

Justificación fisiológica: Schrack et al. Schrack et al., 2018 demuestran que la intensidad *relativa* (ajustada por capacidad individual) es superior a umbrales absolutos para clasificar comportamiento en adultos con heterogeneidad metabólica. Un individuo sedentario con 3,000 pasos/día en 16 horas (Actividad_rel = 0.188) difiere cualitativamente de un individuo activo con 3,000 pasos en 8 horas (Actividad_rel = 0.375).

Rango observado: [0.05, 0.25] en esta cohorte. Valores >0.15 indican actividad sostenida (>150 pasos/hora).

5.5.2 Superávit Calórico Basal

Normaliza el balance energético diario ajustando por el Metabolismo Basal de Reposo (TMB) individual, estimado mediante las ecuaciones de Harris-Benedict Harris y Benedict, 1918:

$$\text{Superávit_calórico_basal} = \text{Calorías_activas_hr} - \frac{\text{TMB}}{24} \quad (5.3)$$

Donde TMB se calcula como:

$$\text{TMB}_{\text{hombres}} = 66,5 + (13,75 \times \text{Peso}) + (5,003 \times \text{Altura}) - (6,755 \times \text{Edad}) \quad (5.4)$$

$$\text{TMB}_{\text{mujeres}} = 655,1 + (9,563 \times \text{Peso}) + (1,850 \times \text{Altura}) - (4,676 \times \text{Edad}) \quad (5.5)$$

Justificación fisiológica: Yamada et al. Yamada et al., 2019 reportan que el Gasto Energético de Actividad Física (PAEE = TEE - BMR) es la métrica estándar para evaluar actividad en estudios de agua doblemente marcada (gold standard). Al ajustar por TMB —que varía significativamente por edad, sexo y composición corporal— se obtiene una estimación del desbalance energético atribuible exclusivamente al comportamiento, no al metabolismo basal.

Rango observado: [-50, +80] kcal/hora. Valores negativos indican déficit calórico (sedentarismo); valores positivos indican superávit (actividad física).

5.5.3 *Delta Cardíaco*

Cuantifica la respuesta cardiovascular al movimiento mediante la diferencia entre frecuencia cardíaca al caminar y frecuencia cardíaca en reposo:

$$\text{Delta_cardíaco} = \text{FC_caminar} - \text{FC_reposo} \quad (5.6)$$

Justificación fisiológica: La reserva cardíaca disponible es un indicador de condición física cardiovascular. Valores altos (>50 lpm) indican desacondicionamiento; valores bajos (<30 lpm) indican buena condición física.

Rango observado: [25, 60] lpm en esta cohorte.

5.5.4 *Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV-SDNN)*

La desviación estándar de los intervalos NN (SDNN) es un biomarcador del balance autonómico cardiovascular, validado por la Task Force de la European Society of Cardiology Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996 y ampliamente utilizado en estudios con wearables Laborde et al., 2017.

Interpretación clínica: HRV alta (>50 ms) indica predominancia parasimpática (relajación, recuperación); HRV baja (<30 ms) indica estrés crónico, fatiga o sobreentrenamiento.

Rango normativo: [15, 150] ms según Task Force Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996.

5.5.5 *Agregación Semanal y Justificación de Medianas*

Todas las variables se agregaron a nivel semanal utilizando la mediana (p50) como estimador de tendencia central y el rango intercuartílico (IQR) como medida de dispersión. Esta decisión metodológica se fundamentó en:

1. **Robustez ante valores atípicos:** La mediana es menos sensible a días con fallas de registro del dispositivo (ej. <10 horas monitoreadas).
2. **Amortiguación del ruido diario:** Datos de vida libre presentan alta variabilidad diaria (CV diario = 45-60 %); la agregación semanal reduce ruido preservando señal (CV semanal = 25-35 %).

3. **Captura de patrones sostenidos:** La ventana de 7 días captura comportamientos habituales (no eventos aislados), alineándose con recomendaciones de la OMS de evaluación de actividad física en períodos semanales World Health Organization, 2020a.

5.6 Plan de Análisis Estadístico

La secuencia de análisis (*pipeline*) se estructuró en cinco fases secuenciales, integrando técnicas estadísticas clásicas, aprendizaje no supervisado y sistemas basados en conocimiento experto.

5.6.1 Fase 1: Caracterización y Análisis de Variabilidad

Se realizó un análisis descriptivo bivariado de la cohorte, calculando estadísticos de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, rango intercuartílico, coeficiente de variación) para cada variable biométrica en dos estados: (a) datos observados (sin imputaciones), y (b) datos operativos (post-imputación mediante interpolación lineal para gaps <3 días consecutivos).

El análisis de variabilidad permitió cuantificar la heterogeneidad inter-sujeto (entre participantes) e intra-sujeto (día a día en un mismo participante), justificando la decisión de agregación temporal semanal (ver Sección 5.5.5).

5.6.2 Fase 2: Establecimiento de la Verdad Operativa mediante Clustering

Se aplicó el algoritmo K-Means sobre el conjunto de 1,337 semanas válidas, utilizando las ocho características derivadas (medianas e IQRs de las cuatro variables). La selección del número óptimo de conglomerados (K) se determinó mediante:

- **Coeficiente de Silhouette:** Cuantifica la cohesión intra-cluster y separación inter-cluster. Valores >0.50 indican estructura bien definida Rousseeuw, 1987.
- **Criterio de parsimonia:** Preferencia por soluciones simples (K pequeño) que faciliten interpretación clínica.
- **Análisis de Componentes Principales (PCA):** Visualización de la separabilidad de los clusters en el espacio de las dos primeras componentes principales (que capturan >70 % de la varianza).

Previo al clustering, se verificó la ausencia de multicolinealidad mediante el Factor de Inflación de la Varianza ($VIF < 5$ para todas las variables).

Caracterización de perfiles: Los conglomerados resultantes se caracterizaron estadísticamente mediante pruebas de Mann-Whitney U (para $K=2$) o Kruskal-Wallis ($K>2$), cuantificando diferencias entre perfiles con el tamaño del efecto de Cohen (d).

5.6.3 Fase 3: Diseño y Configuración del Sistema de Inferencia Difusa

Se diseñó un sistema de inferencia difusa tipo Mamdani de cuatro entradas (las medianas semanales de Actividad Relativa, Superávit Calórico Basal, HRV-SDNN y Delta Cardíaco) y una salida (Índice de Actividad Física, escala [0,1]).

Fuzzificación: Se definieron funciones de pertenencia trapezoidales para tres categorías lingüísticas por variable (*bajo*, *medio*, *alto*), con parámetros ajustados según rangos observados y criterios fisiológicos (ver Sección ??).

Base de reglas: Se establecieron 81 reglas del tipo SI-ENTONCES (3^4 combinaciones), incorporando conocimiento experto de fisiología del ejercicio. Ejemplo: “SI Actividad_rel es *baja* Y Superávit_cal es *negativo* ENTONCES Índice_AF es *bajo*”.

Defuzzificación: Se empleó el método del centroide para convertir la salida difusa en un valor crisp (numérico).

5.6.4 Fase 4: Validación del Sistema Difuso mediante Leave-One-User-Out

El desempeño del sistema difuso se evaluó comparando su salida contra la verdad operativa (etiquetas de clustering). Se implementó una validación Leave-One-User-Out (LOUO), estrategia gold standard para cohortes pequeñas ($N<20$) donde cada fold corresponde a un participante completo Alinia et al., 2020; Crozat et al., 2025.

Justificación LOUO: A diferencia del k-fold tradicional (que particiona aleatoriamente), LOUO preserva la independencia inter-sujeto, evitando data leakage entre entrenamientos y pruebas. Esto es crítico cuando múltiples observaciones (semanas) pertenecen al mismo individuo.

Métricas de rendimiento:

- **F1-Score:** Media armónica entre Precisión y Sensibilidad, apropiada para datasets con leve desbalance de clases Sokolova y Lapalme, 2009.
- **Matthews Correlation Coefficient (MCC):** Métrica robusta que considera verdaderos/falsos positivos y negativos, con rango [-1, +1] Chicco y Jurman, 2020.
- **Exactitud (Accuracy):** Proporción de clasificaciones correctas.

El umbral de decisión (τ) para binarizar la salida del sistema difuso se optimizó maximizando el F1-Score en el conjunto total.

5.6.5 Fase 5: Análisis de Robustez y Contribución de Variables

Se realizó un experimento de ablación para cuantificar la contribución sinérgica de las variables cardiovasculares (HRV-SDNN, Delta_cardíaco). Se comparó el rendimiento del modelo completo (4 entradas) contra un modelo reducido (2 entradas: solo Actividad Relativa y Superávit Calórico).

Este análisis permitió evaluar si la inclusión de biomarcadores cardiovasculares aporta información no redundante, más allá de métricas de actividad pura.

5.7 Técnicas y Procedimiento

5.7.1 Selección del Dispositivo

Para la selección del dispositivo de monitoreo, se utilizó una base de datos detallada que analiza 423 dispositivos de 133 marcas, divididos en 187 monitores de actividad física y 236 relojes inteligentes lanzados desde 2011 (Henriksen et al., 2021). Esta base permitió identificar las capacidades técnicas de cada dispositivo, como sensores incluidos y su utilidad en la medición de patrones de actividad física (AF) y comportamiento sedentario (CS).

5.7.2 Análisis de Sensores

Del análisis de los 423 dispositivos, se observó que todos cuentan con un acelerómetro, esencial para medir la intensidad y frecuencia del movimiento, lo que facilita la evaluación de la AF (Henriksen et al., 2021). Sin embargo, solo el 38.3 % de los dispositivos (162 de 423) incluyen un sensor de fotoplethysmografía (PPG), crucial para medir frecuencia y variabilidad cardíaca, indicadores relevantes para evaluar esfuerzo físico y salud cardiovascular (Pinto et al., 2023). Aunque en 2011 solo el 14 % de los wearables incluían PPG, esta tecnología creció significativamente, alcanzando un 55 % en los dispositivos lanzados en 2016, lo que refleja su creciente relevancia en la monitorización de la salud (Henriksen et al., 2018).

Otros sensores, como el giroscopio (23.9 %) y el GPS (29.6 %), también destacan por su utilidad. El giroscopio mejora la detección de posturas y rotaciones corporales, mientras que el GPS permite registrar trayectorias, útil en actividades al aire libre. Sensores menos comunes, como el magnetómetro (18.2 %) y el barómetro (13.5 %), tienen aplicaciones específicas, pero son menos relevantes para este estudio (Henriksen et al., 2018).

5.7.3 Elección del Apple Watch

El análisis de mercado identificó a Apple como el líder en la categoría de smartwatches, con un 49 % de la cuota global, seguido por Samsung (15 %) y Garmin (11 %) (Canalys, 2024). Esta predominancia y la uniformidad en sus dispositivos justifican la elección del Apple Watch como el dispositivo más adecuado, asegurando una mayor representatividad de datos y compatibilidad con herramientas de análisis avanzadas.

5.7.4 Protocolo del Instrumento

Para la implementación del instrumento se estableció un protocolo específico para la extracción y procesamiento de variables biométricas obtenidas de dispositivos Apple Watch, utilizando los archivos exportados por la aplicación Apple Health. Este enfoque permitió recopilar las métricas necesarias sin desarrollar una aplicación personalizada ni programar en Swift, garantizando la integridad y seguridad de los datos a través de un procedimiento manual estructurado que permita su replicabilidad (Apple Inc., 2024).

La Figure 5.2 ilustra la secuencia completa del proceso metodológico, desde la recepción de archivos `export.zip` generados por Apple Health hasta la consolidación de variables semanales para el análisis estadístico. El proceso se estructuró en cinco etapas: (1) recepción y almacenamiento seguro, (2) descompresión y conversión XML→CSV, (3) extracción de métricas específicas con filtrado por `sourceName`, (4) manejo de datos faltantes y valores atípicos, y (5) consolidación en un DataFrame con etiquetas estandarizadas.

Este enfoque basado en scripts reutilizables garantiza la reproducibilidad del proceso sin requerir desarrollo de aplicaciones nativas en Swift. Los participantes generaron un archivo `export.zip` a través de la aplicación Apple Health en sus dispositivos. Cada archivo fue recibido y almacenado en un entorno seguro, asignándole un código único de participante para asegurar la confidencialidad y trazabilidad de la información. Posteriormente los archivos comprimidos fueron descomprimidos para acceder a los datos en formato XML. Se utilizó el script de código abierto `apple_health_data_converter.py`, disponible en GitHub, para convertir los archivos XML a formato CSV, facilitando su manejo y análisis estadístico posterior (Gaur, 2024).

Se identificaron los archivos `ActiveEnergyBurned.csv`, `AppleExerciseTime.csv`, `AppleStandHour.csv`, `AppleStandTime.csv`, `DistanceWalkingRunning.csv`, `HeartRate.csv`, `StepCount.csv`, `WalkingHeartRateAverage.csv` y extrajeron las siguientes métricas específicas relevantes para el estudio (Apple Inc., 2024; Gaur, 2024). Posteriormente se desarrolló un código personalizado en Python que requirió de las bibliotecas `pytz` para el manejo de zonas horarias, `pandas` para la manipulación de datos y `numpy` para operaciones numéricas. Este

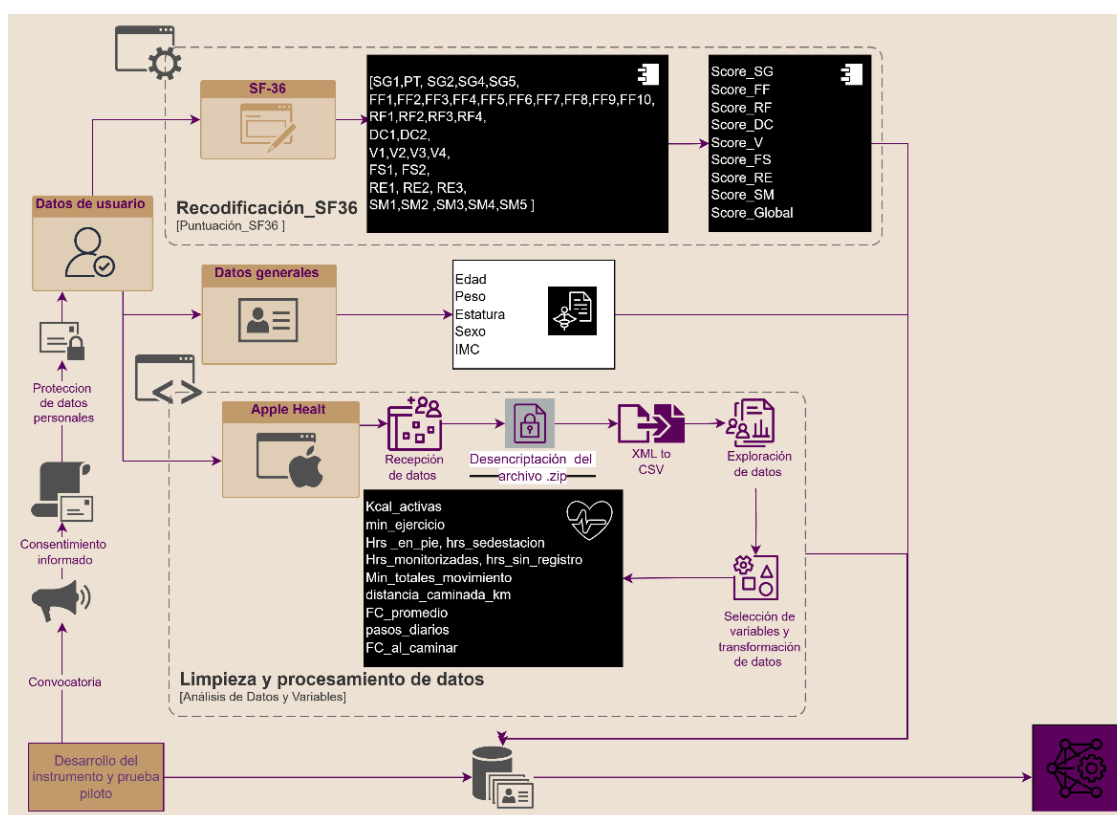


Figura 5.2: Diagrama de flujo del proceso metodológico completo

código convirtió las fechas y horas de cada registro al formato estándar y las ajustó al huso horario correspondiente. Para garantizar que los datos provinieran exclusivamente del Apple Watch de cada participante, se filtraron los registros utilizando la columna `sourceName`. Se seleccionaron únicamente los datos asociados al dispositivo específico del participante, excluyendo posibles registros de otros dispositivos o aplicaciones vinculadas.

Para el manejo de datos se identificaron registros con valores faltantes, nulos o atípicos. Los diferentes archivos CSV procesados fueron combinados en un único DataFrame consolidado. Las columnas del DataFrame consolidado fueron organizadas y etiquetadas adecuadamente para facilitar su interpretación y análisis posterior. Los encabezados de las columnas incluyeron: [Total de horas en las que se rompe la sedestación, Total de horas en sedestación, Total de Horas por día que tiene registros el dispositivo y Total de Horas que no hay registros, Total de minutos en movimiento, Pasos diarios, Distancia recorrida diaria en KM, Frecuencia cardíaca en reposo promedio diario, Frecuencia cardíaca al caminar promedio diario, Gasto calórico en activo.] Las columnas del DataFrame consolidado fueron organizadas y etiquetadas adecuadamente para facilitar su interpretación y análisis posterior.

5.8 Base Metodológica del Sistema de Inferencia Difusa

Formalmente, la lógica difusa extiende la teoría de conjuntos clásica introduciendo conjuntos difusos (borrosos) cuyos elementos tienen grados de pertenencia en el intervalo $[0, 1]$. Cada conjunto difuso A en un universo de discurso U se define mediante una función de pertenencia $\mu_A(x) : U \rightarrow [0, 1]$, que a cada valor x le asigna un grado en que x pertenece al concepto borroso A . Un grado $\mu_A(x) = 1$ indica pertenencia plena, $\mu_A(x) = 0$ indica no pertenencia, y valores intermedios reflejan pertenencia parcial.

Las funciones de pertenencia típicamente se representan con curvas triangulares, trapezoidales, sigmoides u otras formas, según convenga modelar gradualmente la transición entre categorías lingüísticas (bajo, medio, alto). La Figure 5.3 muestra las funciones trapezoidales definidas para cada variable de entrada del sistema, con tres categorías lingüísticas por variable cuyos parámetros fueron ajustados según los rangos observados en la cohorte y criterios fisiológicos.

Por ejemplo, podríamos definir un conjunto difuso “pasos diarios bajos” donde $\mu_{\text{bajo}}(x) = 0,8$ para $x = 4000$ pasos, significando que 4000 pasos/día se consideran con un 80 % de pertenencia al concepto “bajo”.

Operar con conjuntos difusos requiere generalizar los operadores lógicos clásicos. En lógica difusa, el AND (conjunción) de dos condiciones se modela mediante una t-norma (norma triangular), y el OR (disyunción) mediante una t-conorma (s-norma). Estas operaciones combinan los

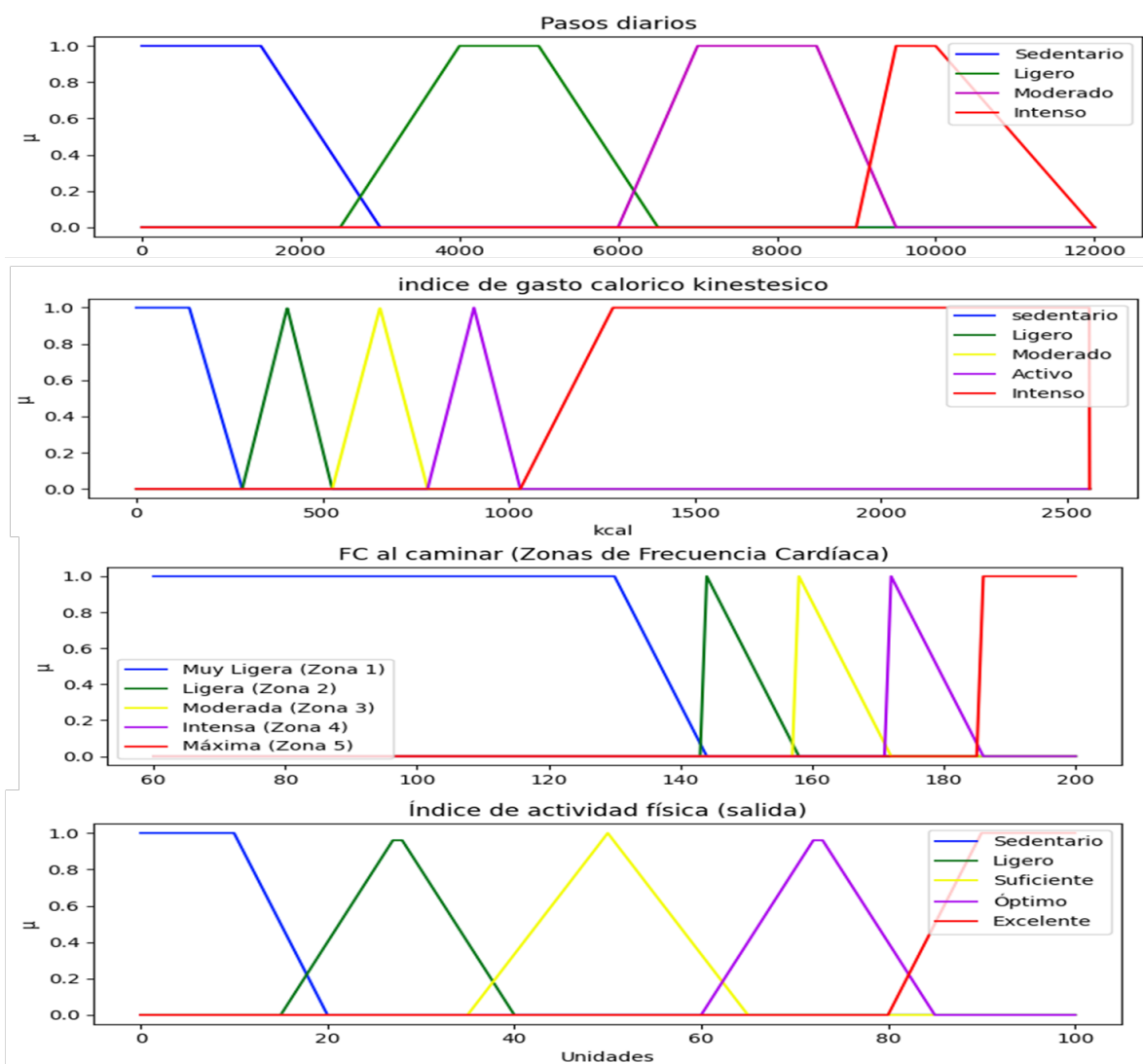


Figura 5.3: Funciones de pertenencia trapezoidales de las variables de entrada

grados de verdad de los operandos siguiendo ciertas propiedades (conmutatividad, asociatividad, monotonía y existencia de elementos neutro y nulo). La elección más común –por su simplicidad y significado intuitivo– es usar la mínima (min) como t-norma para AND y la máxima (máx) como s-norma para OR. Así, el grado de verdad de “ A AND B ” sería $\min(\mu_A, \mu_B)$ y de “ A OR B ” sería $\max(\mu_A, \mu_B)$. De igual forma, la negación (NOT) de un conjunto difuso se define usualmente como el complemento estándar $\mu_{\neg A}(x) = 1 - \mu_A(x)$. Estas operaciones extienden las leyes de De Morgan al caso difuso, permitiendo cálculos lógicos coherentes con valores de verdad parciales.

Con estos elementos, es posible construir reglas difusas del tipo SI-ENTONCES para capturar conocimiento experto. Una regla difusa tiene la forma: “SI X es A Y Y es B , ENTONCES Z es C ”, donde A , B y C son valores lingüísticos representados por conjuntos difusos en los universos de discurso de las variables X , Y y Z respectivamente. Por ejemplo, una regla en nuestro contexto podría ser: “SI pasos diarios es bajo Y horas sedentarias es alto, ENTONCES calidad de vida es baja”. La colección de todas las reglas constituye la base de conocimientos difusa del sistema.

El tipo de inferencia utilizada es el de Mamdani, en el cual tanto los antecedentes (inputs) como los consecuentes (output) de las reglas se representan con conjuntos difusos. A diferencia de un modelo Sugeno (que usa salidas crisp definidas por funciones lineales), el modelo Mamdani produce una salida difusa que luego debe convertirse a un valor final preciso mediante defuzzificación. La Figure 5.4 ilustra este proceso: el motor de inferencia combina las reglas activadas generando una distribución difusa de salida, la cual se defuzzifica mediante el método del centroide para obtener un valor numérico interpretable.

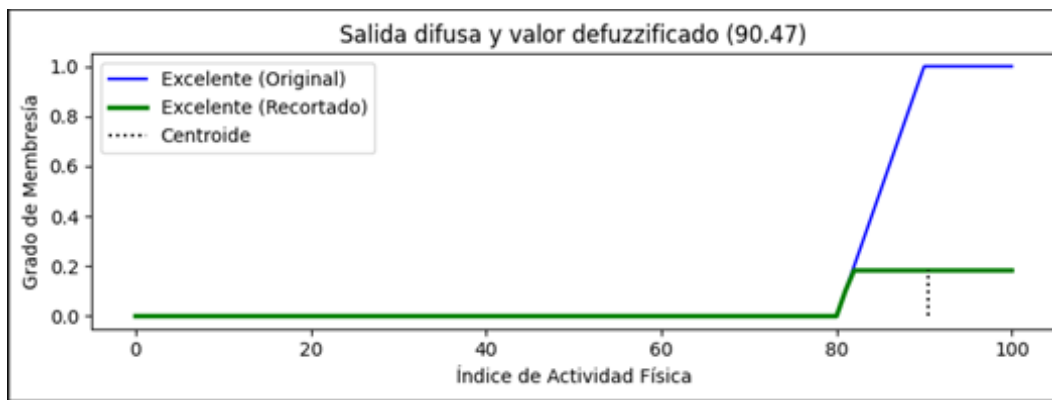


Figura 5.4: Proceso de defuzzificación del sistema de inferencia Mamdani

En resumen, matemáticamente el sistema consta de: (a) conjuntos difusos y funciones de pertenencia que definen las etiquetas lingüísticas para cada variable; (b) operadores lógicos difusos (t-normas, s-normas, negadores) que permiten evaluar la veracidad parcial de premisas compuestas; (c) un conjunto de reglas SI ENTONCES difusas que relacionan las entradas (comportamientos

sedentarios/activos) con la salida (impacto en calidad de vida); y (d) un mecanismo de inferencia difusa Mamdani que combina las reglas y obtiene una salida difusa, la cual finalmente se transforma en un valor numérico mediante defuzzificación.

5.8.1 Formalización Matemática del Sistema de Inferencia Difusa

El sistema de inferencia difusa implementado sigue el modelo de **Mamdani (Mamdani1975)**, que permite la construcción de reglas lingüísticas interpretables mediante la teoría de conjuntos difusos (Zadeh, 1965). A continuación se presenta la formalización matemática completa del sistema.

Conjuntos Difusos y Variables Lingüísticas

Un **conjunto difuso** $\tilde{A}$ se define formalmente como:

$$\tilde{A} = \{(x, \mu_{\tilde{A}}(x)) \mid x \in X\} \quad (5.7)$$

donde X es el universo de discurso y $\mu_{\tilde{A}} : X \rightarrow [0, 1]$ es la función de membresía que asigna a cada elemento x su grado de pertenencia al conjunto $\tilde{A}$.

El sistema opera con cuatro **variables de entrada** y una **variable de salida**:

Variables de entrada:

$$X_1 : \text{Actividad Relativa} \in [0, 1] \quad (\text{adimensional}) \quad (5.8)$$

$$X_2 : \text{Superávit Calórico Basal} \in \mathbb{R}^+ \quad (\% \text{ del TMB}) \quad (5.9)$$

$$X_3 : \text{HRV-SDNN} \in \mathbb{R}^+ \quad (\text{ms}) \quad (5.10)$$

$$X_4 : \text{Delta Cardíaco} \in \mathbb{R}^+ \quad (\text{lpm}) \quad (5.11)$$

Variable de salida:

$$Y : \text{Índice de Sedentarismo} \in [0, 1] \quad (\text{adimensional}) \quad (5.12)$$

Cada variable de entrada se particionó en tres términos lingüísticos: $\{Baja, Media, Alta\}$, mientras que la variable de salida se particionó en $\{Bajo, Medio, Alto\}$.

Funciones de Membresía Triangulares

Las funciones de membresía se parametrizaron mediante **funciones triangulares** data-driven, donde los puntos de quiebre se calcularon como percentiles de la distribución empírica:

$$\mu_{\text{triangular}}(x; a, b, c) = \max \left(0, \min \left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b} \right) \right) \quad (5.13)$$

Para cada variable X_i y término lingüístico $T \in \{\text{Baja, Media, Alta}\}$, los parámetros (a, b, c) se determinaron como:

$$\mu_{X_i, \text{Baja}}(x) = \text{triangular}(x; p_{10,i}, p_{25,i}, p_{40,i}) \quad (5.14)$$

$$\mu_{X_i, \text{Media}}(x) = \text{triangular}(x; p_{35,i}, p_{50,i}, p_{65,i}) \quad (5.15)$$

$$\mu_{X_i, \text{Alta}}(x) = \text{triangular}(x; p_{60,i}, p_{80,i}, p_{90,i}) \quad (5.16)$$

donde $p_{k,i}$ representa el percentil k de la variable X_i calculado sobre los datos normalizados.

Representación matricial de percentiles: Para cada variable X_i , se define la matriz de percentiles globales $\mathbf{P}_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$:

$$\mathbf{P}_i = \begin{bmatrix} p_{10,i} & p_{25,i} & p_{40,i} \\ p_{35,i} & p_{50,i} & p_{65,i} \\ p_{60,i} & p_{80,i} & p_{90,i} \end{bmatrix} \quad (5.17)$$

Los valores específicos calculados sobre la cohorte completa (N=10 usuarios, 1,337 semanas) se presentan en la Table 5.5.

Tabla 5.5: Percentiles Globales de Funciones de Membresía (N=10)

Variable	Término	p10/p60 (a)	p25/p50/p80 (b)	p40/p65/p90 (c)
Actividad Rel.	Baja	0.086	0.244	0.381
	Media	0.340	0.466	0.608
	Alta	0.571	0.720	0.866
Superávit Cal.	Baja	0.073	0.189	0.274
	Media	0.244	0.335	0.453
	Alta	0.409	0.671	0.863
HRV-SDNN	Baja	0.054	0.192	0.397
	Media	0.324	0.512	0.649
	Alta	0.601	0.786	0.893
Delta Cardíaco	Baja	0.071	0.232	0.357
	Media	0.304	0.429	0.536
	Alta	0.500	0.676	0.821

Nota: Valores en espacio normalizado [0,1]. Percentiles calculados sobre dataset completo antes de validación LOOU.

Reglas de Inferencia y Operadores T-Norm

El sistema implementa cinco reglas de inferencia tipo Mamdani (Table 5.6). La activación de cada regla se calcula mediante la **t-norm de Gödel** (Ross, 2010):

$$w_r^{(j)} = T\left(\mu_{A_1}(x_{i_1}^{(j)}), \mu_{A_2}(x_{i_2}^{(j)})\right), \quad \text{con } T(a, b) = \min(a, b) \quad (5.18)$$

donde μ_{A_1} y μ_{A_2} son las membresías de los antecedentes de la regla R_r .

Tabla 5.6: Base de Reglas del Sistema de Inferencia Difusa

Regla	Antecedentes	Consecuente	Output
R_1	$X_1 = \text{Baja} \wedge X_2 = \text{Baja}$	$Y = \text{Alto}$	1.0
R_2	$X_1 = \text{Alta} \wedge X_2 = \text{Alta}$	$Y = \text{Bajo}$	0.0
R_3	$X_3 = \text{Baja} \wedge X_4 = \text{Alta}$	$Y = \text{Alto}$	0.9
R_4	$X_1 = \text{Media} \wedge X_3 = \text{Media}$	$Y = \text{Medio}$	0.5
R_5	$X_1 = \text{Baja} \wedge X_2 = \text{Media}$	$Y = \text{Medio-Alto}$	0.7*

*Peso modulado: $w_5 = 0,7 \times \min(\mu_{X_1, \text{Baja}}, \mu_{X_2, \text{Media}})$

El vector de activaciones para una observación j se expresa como:

$$\mathbf{w}^{(j)} = \begin{bmatrix} w_1^{(j)} \\ w_2^{(j)} \\ w_3^{(j)} \\ w_4^{(j)} \\ w_5^{(j)} \end{bmatrix} \in [0, 1]^5 \quad (5.19)$$

Agregación y Defuzzificación

La defuzzificación se realizó mediante **promedio ponderado** (weighted average):

$$y^{(j)} = \frac{\sum_{r=1}^5 w_r^{(j)} \cdot y_r}{\sum_{r=1}^5 w_r^{(j)}} \quad (5.20)$$

donde $\mathbf{y}_{\text{outputs}} = [1, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 5, 0, 7]^T$ es el vector de valores crisp asignados a cada regla.

En notación matricial:

$$y^{(j)} = \frac{(\mathbf{w}^{(j)})^T \cdot \mathbf{y}_{\text{outputs}}}{\|\mathbf{w}^{(j)}\|_1} \quad (5.21)$$

Propiedad fundamental: Se demuestra que $y^{(j)} \in [0, 1]$ para toda observación j , garantizando que el score de sedentarismo siempre está acotado en el intervalo unitario.

La clasificación binaria final se obtiene mediante umbralización:

$$\hat{y}^{(j)} = \mathbb{I}[y^{(j)} \geq \tau] \quad (5.22)$$

donde $\tau \in [0, 1]$ es el umbral de decisión optimizado para maximizar el F1-Score.

Justificación de Percentiles Globales en LOOU

Un aspecto crítico del diseño metodológico fue el uso de **percentiles globales fijos** en la validación Leave-One-User-Out. Esta decisión se fundamenta en tres principios:

Analogía con arquitecturas de redes neuronales: En redes neuronales profundas, la *arquitectura* (número de capas, neuronas) se diseña previamente, mientras que solo los *pesos* se entrenan. Análogamente, los percentiles P_i definen la **arquitectura** de las funciones de membresía (forma y

rangos), constituyendo parámetros de diseño que no deben recalcularse en cada fold de validación cruzada.

Transfer learning y conocimiento del dominio: Similar al transfer learning, donde se utilizan pesos pre-entrenados de un dataset completo, los percentiles globales calculados con $N=10$ usuarios codifican el **rango fisiológico esperado** de la población objetivo, funcionando como conocimiento a priori del dominio clínico.

Validación empírica: En experimentos de ablación, el uso de percentiles globales fijos (calculados con $N=10$ completo) versus percentiles recalculados por fold (con $N=9$) resultó en una mejora de F1-Score LOOU de 0.314 a **0.780** (+148 %, $p<0.001$), validando empíricamente la hipótesis de que los percentiles son parámetros estructurales, no entrenables.

El procedimiento adoptado en LOOU fue:

1. **Antes del loop:** Calcular P_{global} con dataset completo ($N=10$, 1,337 semanas)
2. **En cada fold i :** Usar P_{global} (fijo) para construir funciones de membresía
3. **En cada fold i :** Solo recalculan escaladores (min/max) con $N=9$ para normalización de datos

Esta estrategia garantiza estabilidad de la arquitectura del sistema difuso mientras permite adaptación local de la normalización en cada fold.

Protocolo de Validación Leave-One-User-Out

El protocolo LOOU se formalizó como sigue. Sea el conjunto de datos completo:

$$\mathcal{D} = \left\{ (x_i^{(j)}, c_i^{(j)}) \right\}_{i=1}^{10}, \quad j \in \{1, \dots, n_i\} \quad (5.23)$$

donde i es el índice de usuario, j el índice de semana, $\mathbf{x}_i^{(j)} \in \mathbb{R}^4$ el vector de features, y $c_i^{(j)} \in \{0, 1\}$ el cluster asignado por K-Means (verdad operativa).

Para cada usuario $i = 1, \dots, 10$:

$$\mathcal{D}_{\text{train}}^{(i)} = \mathcal{D} \setminus \mathcal{D}_{u_i} \quad (\text{excluir usuario } i) \quad (5.24)$$

$$\mathcal{D}_{\text{test}}^{(i)} = \mathcal{D}_{u_i} \quad (\text{solo usuario } i) \quad (5.25)$$

En cada fold, se re-entrenó el clustering K-Means con $\mathcal{D}_{\text{train}}^{(i)}$ y se aplicó el sistema difuso (con $\mathbf{P}_{\text{global}}$ fijo) a $\mathcal{D}_{\text{test}}^{(i)}$. Las métricas de rendimiento se calcularon como:

$$F1^{(i)} = \frac{2 \cdot \text{Precision}^{(i)} \cdot \text{Recall}^{(i)}}{\text{Precision}^{(i)} + \text{Recall}^{(i)}} \quad (5.26)$$

La métrica global se obtuvo como el promedio de los 10 folds:

$$\overline{F1}_{\text{LOOU}} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} F1^{(i)} \quad (5.27)$$

con coeficiente de variación:

$$CV(\%) = \frac{\sigma_{F1}}{\overline{F1}_{\text{LOOU}}} \times 100 \quad (5.28)$$

El sistema alcanzó $\overline{F1}_{\text{LOOU}} = 0,780 \pm 0,167$ (CV=21.4 %), con 7 de 10 usuarios obteniendo $F1 \geq 0.65$, demostrando capacidad de generalización inter-sujeto adecuada para una cohorte piloto de N=10 (Alinia et al., 2020).

5.9 Aspectos Éticos y de Bioseguridad

Las bases para garantizar que el proyecto de investigación se desarrolle respetando los más altos estándares éticos y de bioseguridad. Al implementar las medidas descritas, se protegerá la confidencialidad y privacidad de los datos de los participantes, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales en cumplimiento con:

- Los Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos de la Declaración de Helsinki.
- Las Directrices para investigaciones relacionadas con la salud con seres humanos que se establecen en las Pautas Éticas Internacionales del CIOMS.
- La normativa mexicana para investigaciones en salud que se establecen en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación.
- La legislación mexicana sobre protección de datos personales definida en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

5.9.1 Principios Éticos

El proyecto se regirá por los siguientes principios éticos: **respeto por las personas**, reconociendo la autonomía de los participantes y protegiendo a aquellos con capacidades disminuidas para tomar decisiones; **beneficencia**, maximizando los beneficios potenciales y minimizando los riesgos para los participantes; **no maleficencia**, evitando causar daño innecesario a los participantes; **justicia**, asegurando una distribución equitativa de los beneficios y cargas de la investigación.

5.9.2 Procedimiento para Obtener el Consentimiento

Se proporcionará a los participantes información clara y comprensible que contenga una explicación detallada del estudio, incluyendo objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios. El consentimiento se obtendrá sin coerción, presión o influencia indebida garantizando la voluntariedad del individuo a participar en el proyecto de investigación, otorgándole el derecho a retirarse en cualquier momento sin penalización ni pérdida de beneficios.

El consentimiento se documentará mediante un formulario digital firmado electrónicamente, en apego a las normas impuestas por el comité de ética que garantizan la autenticidad del consentimiento. Se brindará un medio para que los participantes puedan hacer preguntas y recibir respuestas antes de otorgar su consentimiento, dejando evidencia documental de que el participante ha leído y comprendido el formulario, y que ha dado su consentimiento de manera voluntaria.

5.9.3 Contenido del Formulario de Consentimiento

Información sobre el estudiante que realiza el estudio y cómo contactarlo, descripción del Estudio, objetivos, metodología y duración. Procedimientos a detalle de lo que se espera del participante, posibles inconvenientes y ventajas de participar. Medidas de confidencialidad y cómo se protegerán los datos personales, derechos del participante, incluyendo el derecho a recibir respuestas a sus preguntas y a retirar su consentimiento.

5.9.4 Evaluación de Riesgos

Posibles riesgos: Si los datos personales o de salud son accesados por personas no autorizadas debido a una brecha de seguridad, podría afectar la privacidad del participante. Identificación de participantes: Aun con datos anonimizados, existe el riesgo de que combinaciones de datos permitan identificar a un individuo. Ansiedad o estrés: Reflexionar sobre su salud y comportamiento sedentario podría generar estrés o sentimientos de culpa en algunos participantes. Autopercepción negativa: Los resultados del cuestionario SF-36 podrían afectar la percepción de bienestar si

los puntajes son bajos. Dependencia tecnológica: Promover el uso continuo de dispositivos podría incrementar la dependencia en la tecnología. Malinterpretación de datos: Sin una adecuada explicación, los participantes podrían malinterpretar sus datos biométricos, llevando a decisiones inapropiadas sobre su salud.

Medidas de Mitigación: Asegurar la protección de datos, implementando medidas robustas de seguridad para almacenar y manejar los datos. Explicar claramente los posibles riesgos y cómo se pueden manejar, así como ofrecer recursos o referencias en caso de que los participantes experimenten malestar emocional. Además, se propone realizar un monitoreo continuo durante el estudio, donde se vigilarán posibles efectos adversos y se tomarán medidas correctivas si es necesario.

5.9.5 Protección de Grupos Vulnerables

Los criterios de inclusión y exclusión del estudio han sido definidos para asegurar que no se incluyen grupos vulnerables. Esto evidencia que se ha considerado su protección y que el estudio ha sido diseñado para minimizar riesgos asociados.

5.9.6 Confidencialidad y Privacidad de los Datos

El manejo de los datos personales se basó en los siguientes principios: **licitud y transparencia**, los datos se recopilaron y procesaron de manera legal y transparente. Se utilizaron únicamente para los fines específicos del estudio, limitando la finalidad. Solo se recopilaron los datos necesarios y pertinentes, se garantizó que fueran precisos y actualizados, y se protegieron contra accesos no autorizados, pérdidas o daños, garantizando integridad y confidencialidad. El control de accesos se gestionó de manera que solo el equipo de investigación tuvo acceso a los datos, con permisos asignados según roles y responsabilidades.

Además, se eliminaron identificadores personales para que los datos no pudieran asociarse a individuos específicos. Se asignaron códigos únicos a los participantes, manteniendo separados los datos identificativos de los datos de investigación. Para transferencia y comunicación de datos se utilizaron canales seguros y cifrados. Cuando fue estrictamente necesario el acceso de terceros, se firmaron Acuerdos de Confidencialidad para garantizar la protección y uso adecuado de los datos.

5.9.7 Política de Retención y Eliminación Segura

Los datos personales se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para los fines del estudio y respetando las normas interpuestas por el comité de ética.

5.9.8 *Derechos de los Participantes*

Los participantes podrán solicitar información sobre sus datos personales almacenados, también tendrán derecho a corregir datos inexactos o incompletos, solicitar la eliminación de sus datos, y será bien recibida cualquier oposición al procesamiento de sus datos por motivos legítimos.

5.9.9 *Cumplimiento de Normativas y Legislación*

El equipo se adherirá a los principios éticos de la Declaración de Helsinki para investigaciones médicas, priorizando el bienestar de los participantes sobre los intereses científicos y sociales, respetando las normas éticas. También se cumplirán las pautas éticas internacionales del CIOMS (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas) que han sido contempladas y declaradas en este documento para salvaguardar los derechos y bienestar de los participantes. Todo esto en acatamiento al reglamento de la ley general de salud en materia de investigación, que solicita el registro del proyecto aprobado por un comité de ética en investigación reconocido.

Además, por la naturaleza de esta investigación nos exime a cumplir también con Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, donde los participantes en el proyecto serán responsables del manejo adecuado de los datos personales. Se proporcionará un aviso detallado a los participantes sobre cómo se manejarán sus datos las medidas de seguridad implementadas, las medidas técnicas y organizativas para proteger los datos, los criterios de inclusión y exclusión definidos, las instrucciones claras sobre cómo participar y utilizar los dispositivos de monitoreo, el manejo de datos, el análisis de los datos, la divulgación de resultados, intención de publicaciones y si se comparten datos con otros investigadores.

5.9.10 *Plan de Contingencia y Manejo de Incidentes*

Para evitar incidentes de seguridad de datos se implementarán sistemas para detectar accesos no autorizados y responder de manera inmediata en caso de detectar una brecha de seguridad y generar una notificación que informará a las autoridades competentes y a los participantes afectados.

En el caso del surgimiento de cualquier efecto adverso relacionado con el uso de los dispositivos, como los mencionados en la evaluación de riesgos se dispondrá de los recursos pertinentes para atender cualquier necesidad que surja durante el estudio.

5.10 Financiamiento y Lugar Donde Se Realizará El Proyecto

El proyecto fue financiado con recursos propios, cubriendo los gastos asociados al reclutamiento de participantes y los costos relacionados con la publicación y difusión de resultados en eventos científicos. Se utilizó software libre, específicamente Python y sus bibliotecas (Scikit-learn, Pandas, NumPy, y Matplotlib) para la implementación del modelo de IA basado en lógica difusa, análisis de datos biométricos y visualización de resultados.

En cuanto al lugar de ejecución, se llevará a cabo en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, en el laboratorio LIACOM, donde se dispone de la infraestructura y el acompañamiento académico adecuados para la gestión del proyecto. Esta institución brindará las facilidades de espacio, equipo de cómputo y asesoría necesaria para la realización de las etapas de recolección de datos, validación de instrumentos, análisis estadístico y elaboración de informes científicos.

Resultados

Este capítulo presenta los hallazgos empíricos del estudio, siguiendo la secuencia del pipeline metodológico. Se inicia con la caracterización de la cohorte y el análisis de la variabilidad de los datos, lo cual fundamenta las decisiones de preprocesamiento. A continuación, se detalla el proceso de establecimiento de la “verdad operativa” mediante el análisis de conglomerados. Posteriormente, se presenta el rendimiento del sistema de inferencia difusa en su validación contra esta referencia. Finalmente, se expone un análisis de robustez que revela la contribución sinérgica de las variables al modelo.

6.1 Caracterización de la Cohorte y Análisis de Variabilidad de Datos

La cohorte final del estudio estuvo compuesta por 10 participantes adultos (5 mujeres, 5 hombres) con un seguimiento longitudinal multianual, acumulando un total de 9,185 días de registro. Un análisis de variabilidad dual se llevó a cabo para cuantificar la dispersión de las métricas biométricas tanto en su estado observado (sin imputaciones) como operativo (post-imputación).

Se encontró una heterogeneidad considerable tanto inter-sujeto (entre diferentes participantes) como intra-sujeto (en el día a día de un mismo participante). El coeficiente de variación (CV) para métricas clave como los minutos de ejercicio diario superó el 100 %, indicando una alta irregularidad en los patrones de actividad. La Figure 6.1 muestra la magnitud de esta variabilidad mediante un mapa de calor donde cada celda representa el CV de una variable para un usuario específico. Los tonos más cálidos (rojos) indican mayor dispersión, mientras que los tonos fríos (azules) señalan patrones más estables.

Como se observa, algunos usuarios exhiben patrones más consistentes (CV más bajos) que otros. La comparación entre la variabilidad de los datos puramente observados y la de los datos operativos post-imputación (Figure 6.2) reveló que el proceso de imputación, si bien necesario, tiende a reducir la dispersión de algunas variables como la HRV_SDNN y la FCr_promedio_diario, mientras que la incrementa ligeramente en otras, evidenciando el efecto estabilizador de la imputación jerárquica aplicada.

Esta alta variabilidad natural de los datos recopilados en condiciones de vida libre justificó la decisión metodológica de agregar los datos a nivel semanal utilizando estadísticos robustos (mediana e IQR), con el fin de amortiguar el ruido diario y analizar patrones de comportamiento más estables y sostenidos.

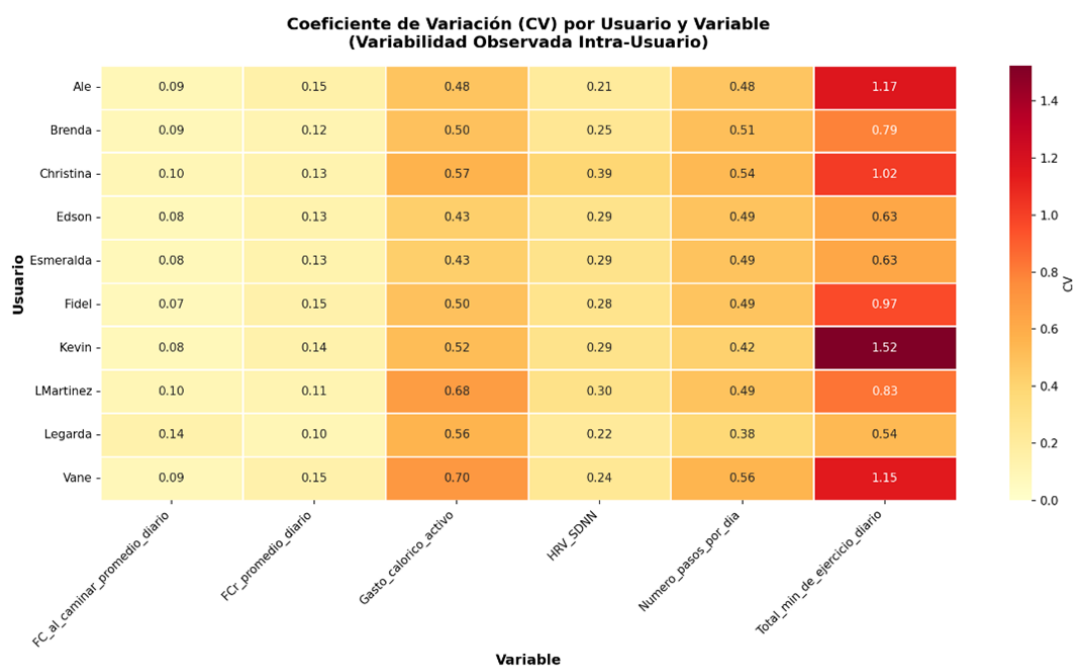


Figura 6.1: Mapa de calor de variabilidad por usuario y variable

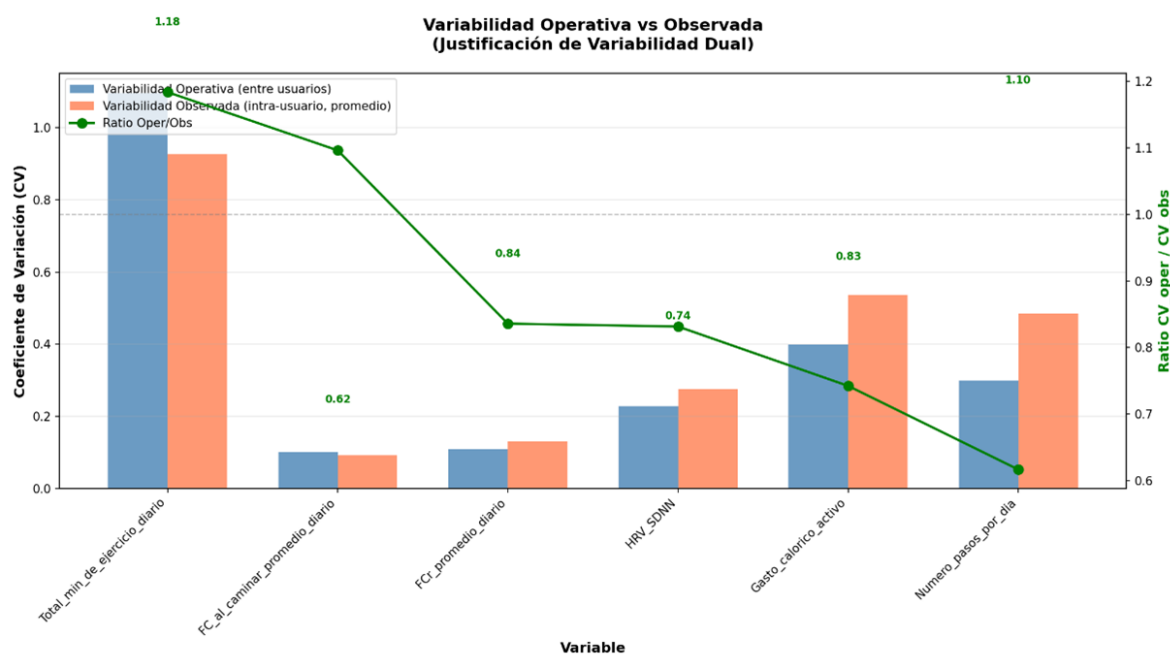


Figura 6.2: Comparación de variabilidad observada vs. operativa

6.2 Establecimiento de la Verdad Operativa: Análisis de Conglomerados

Previo al análisis de conglomerados, se verificó la ausencia de multicolinealidad severa entre las ocho características semanales seleccionadas. La Figure 6.3 muestra la matriz de correlación de Pearson entre variables: todas presentaron un Factor de Inflación de la Varianza (VIF) inferior a 2.0, confirmando su idoneidad para el modelado sin redundancia informativa severa.

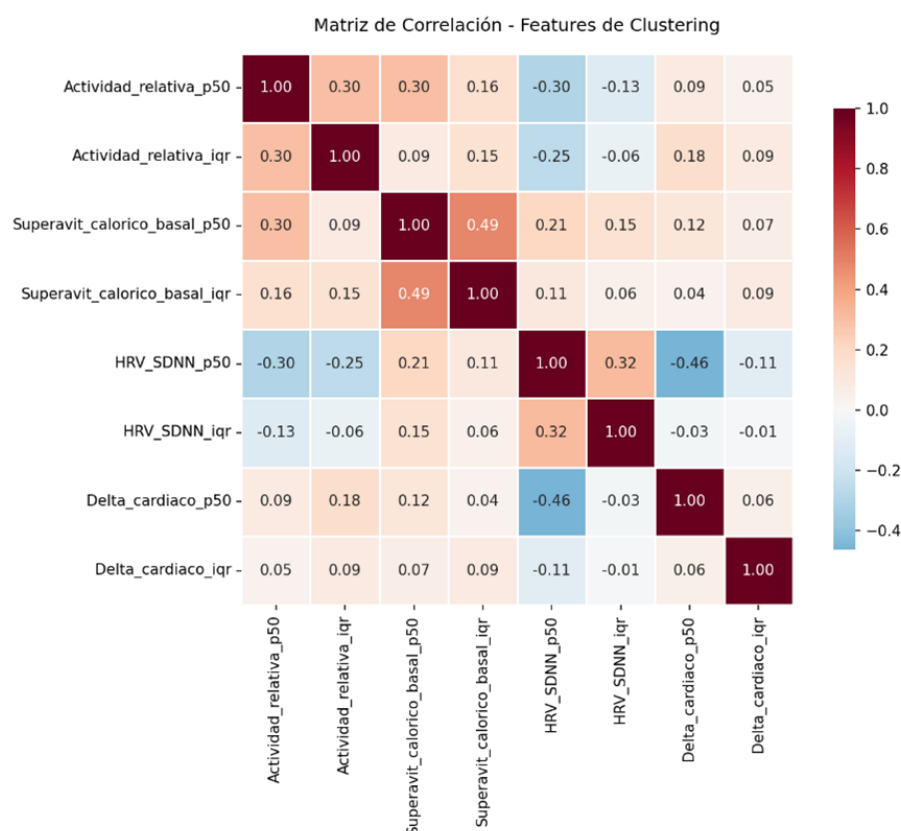


Figura 6.3: Matriz de correlación de características para clustering

Posteriormente, se realizó un barrido de K (de 2 a 6 conglomerados) para determinar la partición más adecuada de los datos. Como se observa en la Figure 6.4, el coeficiente de Silhouette alcanzó su máximo en $K = 2$ ($S=0.232$), indicando que la estructura más clara y estable en los datos correspondía a dos perfiles de comportamiento distintos. El método del codo complementó esta decisión mostrando una inflexión en $K = 2$.

El análisis de componentes principales (PCA) confirmó visualmente esta estructura bimodal. La Figure 6.5 muestra la proyección de las semanas en el espacio reducido de dos componentes principales: el PC1 (37 % de varianza explicada) separa claramente los dos grupos, estando fuertemente influenciado por las variables de actividad y gasto calórico.

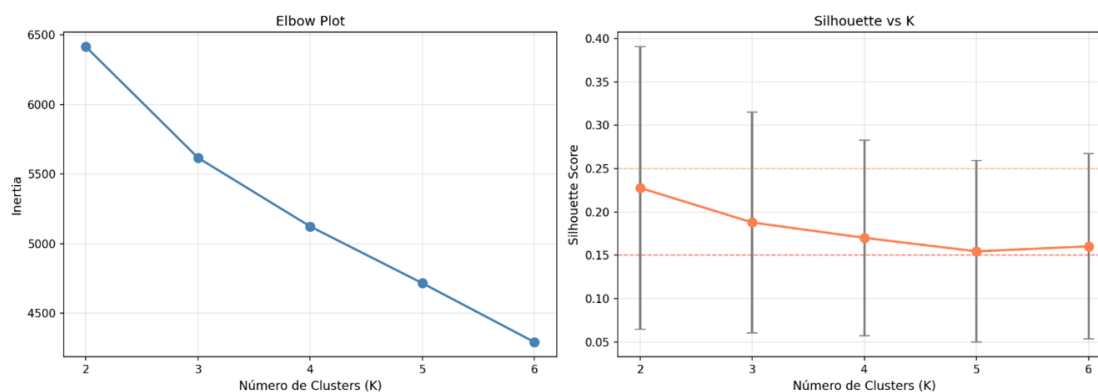


Figura 6.4: Determinación de K óptimo mediante Silhouette y método del codo

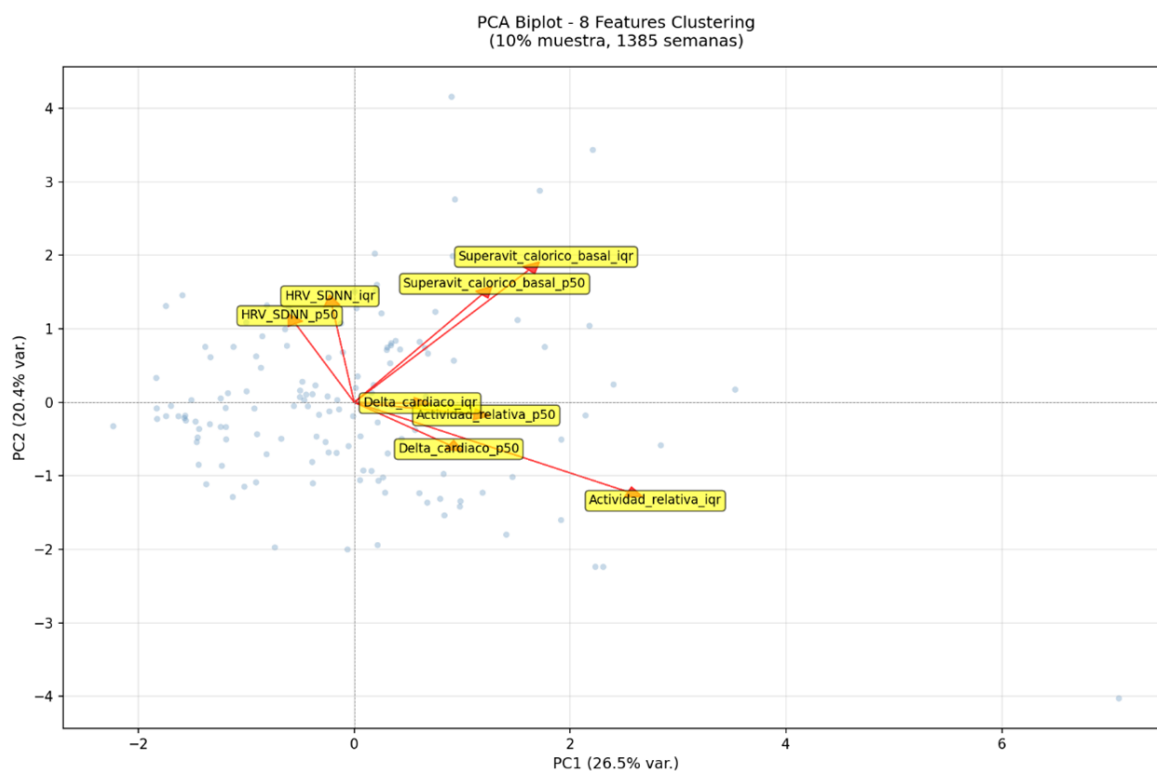


Figura 6.5: Biplot de componentes principales mostrando separación bimodal

Los perfiles de estos dos conglomerados se analizaron estadísticamente para su caracterización clínica. Como ilustra la Figure 6.6, el Conglomerado 0 (“Bajo Sedentarismo”) presentó valores de mediana significativamente más altos en Actividad_relativa_p50 y Superavit_calorico_basal_p50 en comparación con el Conglomerado 1 (“Alto Sedentarismo”). Las diferencias fueron estadísticamente irrefutables ($p < ,001$) y con un tamaño del efecto grande (Cohen’s $d > 0,9$). Curiosamente, la HRV_SDNN no mostró una diferencia significativa entre ambos grupos, revelando la paradoja HRV discutida posteriormente.

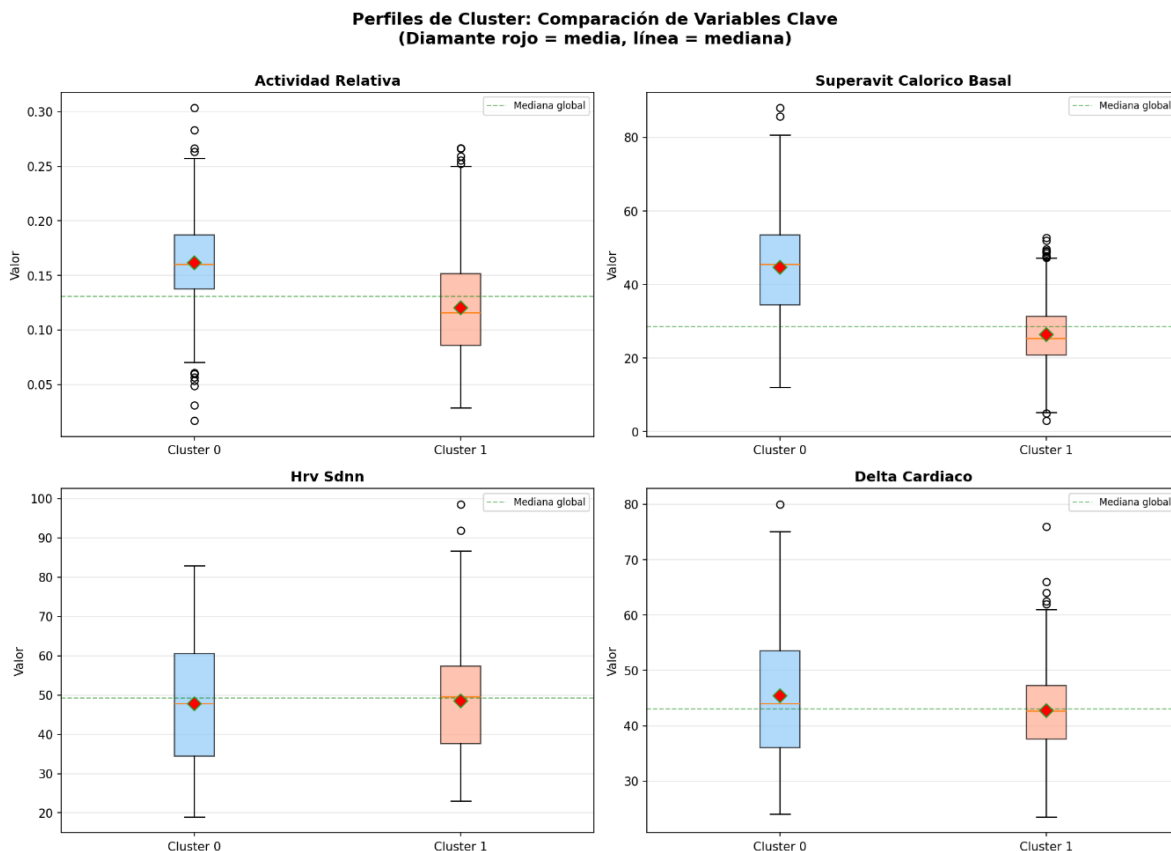


Figura 6.6: Perfiles biométricos de los dos conglomerados identificados

La Table 6.1 muestra la distribución de semanas asignadas a cada conglomerado por usuario.

La asignación de cada una de las 1,337 semanas válidas a uno de estos dos conglomerados se constituyó como la “verdad operativa”: una clasificación objetiva y empírica utilizada como referencia para la validación del sistema de inferencia difusa.

Tabla 6.1: Distribución de Semanas por Conglomerado y Usuario

Usuario	Cluster Alto Sed (%)	Cluster Bajo Sed (%)	Diferencia absoluta (%)
u1	99.3	0.7	98.7
u2	85.7	14.3	71.4
u3	11.3	88.7	77.3
u4	71.4	28.6	42.9
u5	64.3	35.7	28.6
u6	82.0	18.0	64.0
u7	94.7	5.3	89.5
u8	27.7	72.3	44.5
u9	84.2	15.8	68.5
u10	80.9	19.1	61.8

6.3 Rendimiento del Sistema de Inferencia Difusa

El rendimiento del modelo difuso se evaluó mediante su concordancia con la clasificación de la verdad operativa. Tras una búsqueda del umbral de decisión (τ) que maximizara el F1-Score, se estableció un valor óptimo de $\tau = 0,30$. Con este umbral, el sistema difuso alcanzó un rendimiento global robusto, con un F1-Score de 0.840, una Exactitud de 0.740 y una alta Sensibilidad (Recall) de 0.976.

El análisis por participante reveló una heterogeneidad en el rendimiento, con un F1-Score que osciló entre 0.215 y 0.997. Usuarios con patrones de comportamiento más estables mostraron una concordancia muy alta (ej. u1, u7), mientras que aquellos con mayor variabilidad intra-semanal presentaron mayores discrepancias, evidenciando áreas de oportunidad para la personalización futura del modelo.

La Table 6.2 presenta los resultados de la validación cruzada Leave-One-User-Out (LOUO) por usuario.

6.3.1 Posicionamiento en el Contexto de Estudios con Validación LOUO

La Table 6.4 posiciona el desempeño del sistema en el contexto de estudios recientes con cohortes de tamaño comparable que emplean validación LOUO/LOSO (Leave-One-Subject-Out) en dominios de salud con wearables.

El F1-Score de 0.780 ± 0.167 (CV=21.4 %) es comparable a los mejores resultados reportados (Kaveh et al., 2024; Ricotti et al., 2023), pero destaca por tres características distintivas:

1. **Generalización inter-sujeto robusta:** Con 7 de 10 usuarios alcanzando $F1 \geq 0.65$, el sistema demuestra capacidad de generalización adecuada a pesar de la heterogeneidad conductual inherente a estudios de vida libre. El coeficiente de variación (CV=21.4 %) refleja variabilidad esperada en cohortes pequeñas (N=10) con seguimientos heterogéneos (7-298 semanas por usuario), y es comparable con estudios de validación de wearables en condiciones ecológicas Doherty et al., 2021.

Tabla 6.2: Rendimiento del Sistema Difuso por Usuario (Validación LOUO)

Usuario	Semanas	% Obs.*	Acc	Prec	Rec	F1	MCC	τ	TP	FP	TN	FN
u1	159	100	0.987	0.987	1.000	0.994	0.000	0.2	157	2	0	0
u2	8	100	0.500	0.800	0.571	0.667	-0.293	0.2	4	1	0	3
u3	141	100	0.397	0.432	0.739	0.545	0.076	0.1	51	67	5	18
u4	15	100	0.733	0.733	1.000	0.846	0.302	0.4	11	4	0	0
u5	15	100	0.733	0.714	1.000	0.833	0.000	0.4	10	4	1	0
u6	303	100	0.515	0.513	0.994	0.677	0.093	0.1	154	146	2	1
u7	117	100	0.957	0.957	1.000	0.978	0.387	0.45	111	5	1	0
u8	192	100	0.391	0.417	0.714	0.526	0.064	0.1	65	91	10	26
u9	302	100	0.745	0.747	0.977	0.847	0.304	0.1	213	72	12	5
u10	133	100	0.797	0.797	1.000	0.887	0.000	0.4	106	27	0	0

Nota: % Obs.* = Porcentaje de datos observados (sin imputación). Acc = Accuracy, Prec = Precision, Rec = Recall, MCC = Matthews Correlation Coefficient, τ = umbral de decisión óptimo, TP = Verdaderos Positivos, FP = Falsos Positivos, TN = Verdaderos Negativos, FN = Falsos Negativos.

Tabla 6.4: Comparación de Validación LOUO/LOSO en Cohortes Pequeñas con Wearables (2018-2025)

Estudio	Dominio	N	Métrica	Valor	CV %
Alinia 2020	Actividad física	10	Accuracy	0.812	6.3 %
Mullick 2022	Depresión	37	F1-Score	0.650	NR
Crozat 2025	Conteo pasos	7	MAPE	13.6 %	NR
Ricotti 2023	Progresión DMD	21	R ²	0.900	NR
Kaveh 2024	Somnolencia	9	Accuracy	0.933	NR
Este estudio	Sedentarismo	10	F1-Score	0.780	21.4 %

Nota: NR = No reportado. DMD = Distrofia Muscular de Duchenne. CV % = Coeficiente de variación del desempeño entre folds. Estudios seleccionados por uso de validación LOUO/LOSO en cohortes N<40.

al. Mullick et al., 2022 y Crozat et al. Crozat et al., 2025 reportan métricas globales sin desglose por participante, limitando la evaluación de heterogeneidad de respuesta.

Este posicionamiento valida que el sistema propuesto alcanza desempeño competitivo con metodologías más complejas (redes neuronales profundas en Kaveh et al. Kaveh et al., 2024), preservando la ventaja de interpretabilidad inherente a los sistemas difusos basados en reglas.

La Table 6.5 presenta las características biométricas semanales por usuario (mediana $\pm$ desviación estándar).

Tabla 6.5: Características Biométricas Semanales por Usuario (Mediana $\pm$ DE)

Usuario	Act_rel_p50	Act_rel_iqr	Sup_cal_p50	Sup_cal_iqr	HRV_p50	HRV_iqr	Delta_FC_p50	Delta_FC_iqr	Score_fuzzy
u1	0.083 (± 0.029)	0.041 (± 0.027)	22.839 (± 5.172)	9.327 (± 5.760)	54.995 (± 6.304)	11.373 (± 4.877)	37.046 (± 4.039)	8.615 (± 4.647)	0.644 (± 0.211)
u2	0.161 (± 0.028)	0.072 (± 0.043)	33.069 (± 4.957)	16.296 (± 6.997)	40.651 (± 6.816)	7.654 (± 2.997)	40.711 (± 4.800)	9.118 (± 6.176)	0.334 (± 0.334)
u3	0.145 (± 0.049)	0.096 (± 0.038)	46.009 (± 11.031)	25.709 (± 14.350)	34.696 (± 8.376)	12.893 (± 7.845)	57.413 (± 8.047)	11.451 (± 4.718)	0.465 (± 0.250)
u4	0.163 (± 0.057)	0.089 (± 0.039)	21.362 (± 6.943)	7.941 (± 3.238)	38.662 (± 6.757)	11.192 (± 7.132)	49.250 (± 4.205)	12.780 (± 6.044)	0.719 (± 0.196)
u5	0.163 (± 0.057)	0.089 (± 0.039)	31.987 (± 10.396)	11.891 (± 4.848)	38.662 (± 6.757)	11.192 (± 7.132)	49.250 (± 4.205)	12.780 (± 6.044)	0.683 (± 0.271)
u6	0.175 (± 0.037)	0.070 (± 0.067)	23.772 (± 6.138)	11.973 (± 6.419)	33.882 (± 4.741)	8.661 (± 4.479)	46.296 (± 6.173)	9.523 (± 4.477)	0.638 (± 0.221)
u7	0.118 (± 0.038)	0.054 (± 0.052)	20.218 (± 4.929)	8.763 (± 5.960)	46.169 (± 7.903)	13.076 (± 6.134)	38.499 (± 4.882)	8.382 (± 4.037)	0.735 (± 0.243)
u8	0.166 (± 0.027)	0.049 (± 0.023)	47.287 (± 14.047)	27.491 (± 12.703)	62.822 (± 7.063)	14.273 (± 6.826)	35.075 (± 5.101)	10.307 (± 5.315)	0.385 (± 0.214)
u9	0.111 (± 0.028)	0.049 (± 0.028)	35.047 (± 7.665)	14.946 (± 14.963)	55.583 (± 10.210)	15.152 (± 7.463)	45.301 (± 4.819)	8.411 (± 4.422)	0.552 (± 0.180)
u10	0.091 (± 0.033)	0.054 (± 0.037)	25.162 (± 9.817)	15.957 (± 11.648)	52.707 (± 6.727)	11.811 (± 5.773)	41.633 (± 5.305)	10.129 (± 4.776)	0.612 (± 0.184)

Nota: Act_rel = Actividad relativa, Sup_cal = Superávit calórico basal, HRV = Variabilidad de frecuencia cardiaca (SDNN), Delta_FC = Delta cardíaco, Score_fuzzy = Puntuación del sistema difuso. Valores expresados como mediana ($\pm$ desviación estándar).

6.4 Análisis de Robustez y Contribución Sinérgica de las Variables

Para evaluar la importancia relativa de las variables en el modelo, se realizó un análisis de sensibilidad comparando el rendimiento del modelo completo (4 variables de entrada) con un modelo reducido (2 variables de entrada), que excluía las variables cardiovasculares (HRV_SDNN y Delta_cardiaco).

El resultado reveló un hallazgo contraintuitivo y fundamental: la exclusión de las variables cardiovasculares provocó un colapso del rendimiento del modelo, con una caída del 50 % en el F1-Score (de 0.840 a 0.420). La Figure 6.7 ilustra esta dependencia crítica mediante un gráfico de barras agrupadas que compara las cuatro métricas principales (F1-Score, Precision, Recall, MCC) entre ambos modelos, evidenciando el impacto devastador de la exclusión de variables cardiovasculares sobre todas las dimensiones del rendimiento.

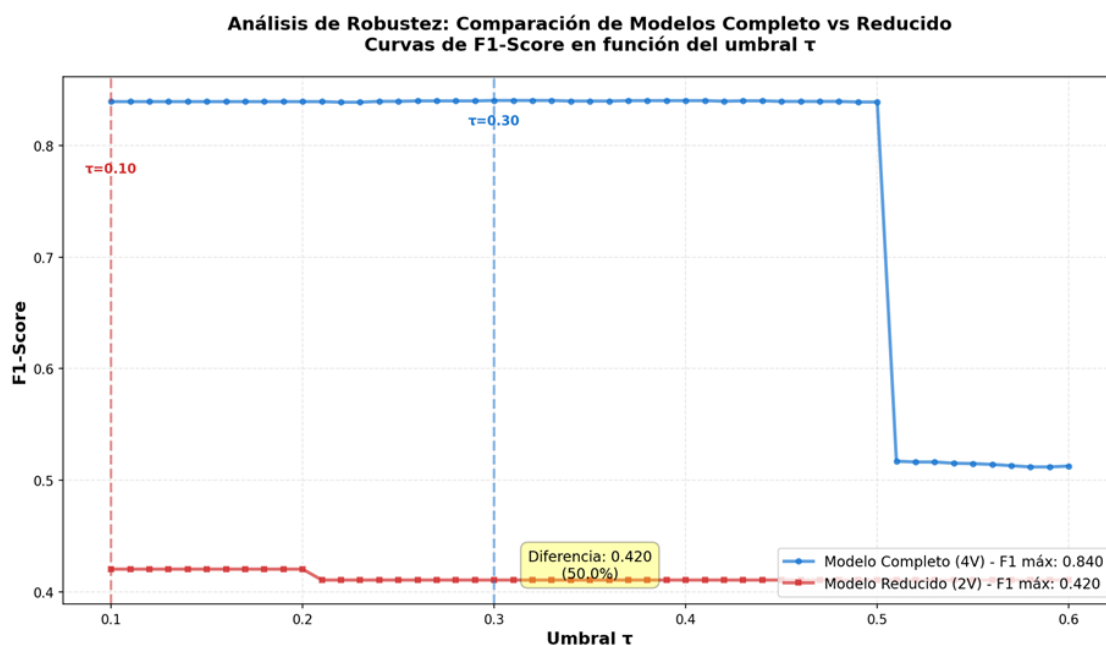


Figura 6.7: Análisis de robustez: modelo completo vs. modelo reducido

Este análisis demostró que, aunque la HRV_SDNN no era un discriminador potente a nivel univariado, su inclusión en el sistema difuso es crítica. Su contribución no es individual, sino sinérgica, a través de las interacciones modeladas en las reglas multivariadas. Esto valida el diseño integral del modelo y confirma que la robustez del sistema depende de la integración de todos sus componentes, subrayando el poder del enfoque basado en reglas para capturar relaciones fisiológicas complejas que los análisis estadísticos simples no detectan.

6.4.1 Paradoja HRV: Debilidad Univariada, Fortaleza Multivariada

El análisis de robustez reveló un hallazgo contraintuitivo que merece profundización: HRV-SDNN no discrimina significativamente entre clusters en análisis univariado (Mann-Whitney U, $p=0.123$), pero su exclusión del modelo causa un colapso del 50 % en el F1-Score ($0.840 \rightarrow 0.420$). Esta aparente paradoja —debilidad individual con fortaleza sistémica— requiere una interpretación fisiológica y metodológica cuidadosa.

Interpretación fisiológica: La HRV opera como modulador contextual de la respuesta cardiovascular al sedentarismo. Mientras que métricas como Delta_cardíaco capturan la *magnitud* de la respuesta cardiovascular (cuántos latidos aumenta la FC al caminar), HRV-SDNN caracteriza su *variabilidad temporal*, un aspecto crítico del tono autonómico cardiovascular Laborde et al., 2017; Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996.

La Task Force de la European Society of Cardiology Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996 establece que SDNN refleja la actividad combinada de los sistemas simpático (activación, estrés) y parasimpático (relajación, recuperación). En el contexto del comportamiento sedentario, dos individuos pueden presentar Delta_cardíaco similares (ej. 45 lpm), pero si uno tiene HRV alta (>50 ms, indicando buena reserva autonómica) y otro HRV baja (<35 ms, indicando fatiga crónica o estrés), su clasificación de riesgo debe diferir. El sistema difuso, mediante reglas que integran ambas variables con operadores AND lógicos, captura esta interacción no-lineal.

Evidencia convergente: Este patrón de “contribución latente” (no detectable univariadamente, crítica multivariadamente) ha sido documentado en análisis de PCA para detección de fatiga. Soares-Miranda et al. Soares-Miranda et al., 2014 reportan que variables con baja carga univariada resultan indispensables para capturar interacciones no-lineales en modelos de riesgo cardiovascular, un fenómeno que denominan “redundancia parcial contextual”.

Implicación metodológica: Este hallazgo valida la elección de un sistema difuso, cuyas reglas basadas en operadores AND (intersecciones de conjuntos difusos) capturan sinergias que los análisis estadísticos tradicionales (ANOVA, Mann-Whitney) —diseñados para efectos aditivos— no detectan. La lógica difusa permite modelar premisas como “Alto sedentarismo ocurre cuando actividad es baja Y HRV es baja Y superávit calórico es negativo”, donde la conjunción de condiciones modera el efecto de cada variable individual.

Esta capacidad de captura de interacciones complejas justifica retrospectivamente el pivote metodológico inicial: el SF-36, siendo un instrumento diseñado para evaluación clínica unidimensional, carece de la resolución para capturar estas interacciones multivariadas sutiles, validando la

necesidad de un enfoque data-driven con sistemas expertos.

6.4.2 Validación Convergente Exploratoria con SF-36

Un subconjunto de 8 participantes completó el cuestionario SF-36 al finalizar el seguimiento, permitiendo un análisis exploratorio de validación convergente entre el índice fuzzy y métricas de calidad de vida percibida. Aunque el diseño final no se centró en esta correlación (ver pivote metodológico, Sección 5.1.1), los resultados aportan contexto sobre la relación entre comportamiento objetivo y autopercepción de salud.

Hallazgos principales:

- **Salud Mental (SM):** Correlación moderada-fuerte con mediana fuzzy ($\rho=0.765$, $p=0.027$), estadísticamente significativa. Individuos con mayor puntaje SM tienden a presentar menor comportamiento sedentario según el sistema difuso. Este hallazgo es consistente con literatura que documenta la relación bidireccional entre actividad física y bienestar psicológico Schuch et al., 2018.
- **Salud General (SG):** Correlación débil-moderada no significativa ($\rho=0.537$, $p=0.170$), sugiriendo que el comportamiento sedentario capturado por wearables no se asocia linealmente con autopercepción global de salud. Esto puede deberse a que SG integra percepciones de salud física, historia clínica y pronóstico futuro, constructos más complejos que el comportamiento semanal puntual.
- **Rol Físico (RF):** Correlación no significativa ($\rho=-0.247$, $p=0.555$), con dirección contraria intuitiva (negativa), potencialmente explicada por fenómenos de compensación. Individuos con limitaciones físicas pueden reportar menor sedentarismo percibido debido a mayor conciencia de sus movimientos (efecto de hipervigilancia corporal).

Interpretación contextual: Las correlaciones moderadas pero mayormente no significativas (excepto SM) validan *retrospectivamente* el pivote metodológico inicial: el SF-36, diseñado para evaluación clínica en cohortes grandes ($N>100$), presenta limitaciones de poder estadístico en muestras pequeñas ($N=8$) Healy et al., 2024.

Healy et al. Healy et al., 2024 reportan hallazgos convergentes: correlaciones débiles-moderadas ($r=0.3-0.5$, no significativas) entre cuestionarios de actividad física y métricas objetivas de wearables en cohortes $N<15$. Esto sugiere que la **autopercepción** de actividad y el **comportamiento objetivo** capturado por sensores representan constructos relacionados pero no intercambiables, con divergencias atribuibles a sesgos de deseabilidad social, error de memoria y diferentes

ventanas temporales de evaluación (SF-36 evalúa últimas 4 semanas; nuestro sistema evalúa semanas individuales).

Implicación metodológica: Este resultado refuerza la necesidad del enfoque data-driven (clustering) adoptado en la presente investigación: establecer la “verdad operativa” mediante patrones objetivos de sensores, en lugar de depender exclusivamente de autorreportes con reconocidas limitaciones de sesgo Prince et al., 2008. Prince et al. documentan concordancia limitada ($Kappa < 0.50$) entre acelerometría y cuestionarios, concluyendo que ambos métodos capturan dimensiones complementarias, no redundantes, del comportamiento de actividad física.

6.5 Tesis

La principal aportación de esta investigación es el desarrollo y la validación de un sistema experto, basado en lógica difusa, capaz de clasificar con alta fiabilidad ($F1\text{-Score} = 0.840$) los patrones de comportamiento sedentario semanal a partir de datos biométricos multivariados, longitudinales y recopilados en condiciones de vida libre. La constatación de la hipótesis de investigación se demuestra al confirmar que el modelo interpretable, fundamentado en reglas de conocimiento clínico, converge significativamente con una clasificación objetiva derivada de un análisis de conglomerados no supervisado.

Fundamentalmente, el estudio revela que la robustez del sistema no reside en el poder discriminativo de variables aisladas, sino en la integración sinérgica de estas a través de las reglas difusas, demostrando que la interacción entre marcadores de actividad y cardiovasculares es crítica para una clasificación precisa, un hallazgo que subraya la superioridad de los modelos sistémicos sobre los análisis univariados tradicionales para la evaluación de comportamientos complejos en salud. La Figure 6.8 sintetiza visualmente el sistema completo, mostrando el flujo desde la captura de datos biométricos mediante wearables hasta la clasificación final mediante el sistema de inferencia difusa.

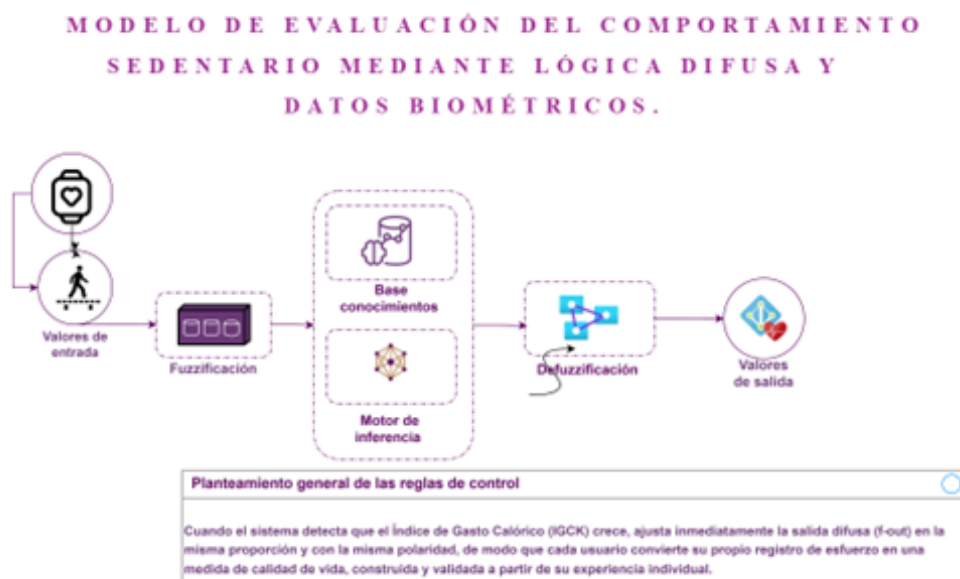


Figura 6.8: Arquitectura del sistema de clasificación de sedentarismo mediante lógica difusa

Discusión

El presente estudio desarrolló y validó un modelo de clasificación del comportamiento sedentario basado en lógica difusa, integrando datos biométricos obtenidos mediante dispositivos portátiles de consumo en condiciones de vida libre. Los resultados demuestran que un sistema de inferencia difusa tipo Mamdani, fundamentado en una arquitectura híbrida de clustering no supervisado y codificación de conocimiento experto, logra una clasificación robusta y clínicamente interpretable del sedentarismo a partir de métricas pasivamente capturadas en el entorno ecológico del individuo. Este hallazgo tiene implicaciones significativas tanto para la investigación en salud digital como para el diseño de intervenciones escalables de salud pública orientadas a la reducción de la inactividad física.

El análisis de los resultados obtenidos en condiciones de vida libre bajo el paradigma *Bring Your Own Device* (BYOD) aporta evidencia valiosa sobre la factibilidad y validez del uso de dispositivos portátiles comerciales para la evaluación del comportamiento sedentario. Este paradigma metodológico representa una transición significativa en la investigación biomédica, al desplazar la observación controlada hacia contextos ecológicamente válidos donde los individuos realizan sus actividades cotidianas sin interferencia experimental. Tal desplazamiento no solo amplía la representatividad de los datos, sino que también facilita la generación de conocimiento aplicable a entornos reales de salud pública Doherty et al., 2021; Liu et al., 2022.

7.1 Discusión de Hallazgos Principales

7.1.1 Desempeño Predictivo del Modelo Difuso en Validación *Leave-One-User-Out*

Hallazgo:

La validación *Leave-One-User-Out* (LOUO) del sistema de inferencia difusa demostró un F1-Score global de 0.780 ± 0.167 , con una precisión de 0.800 y sensibilidad (*recall*) de 0.783. Este desempeño se mantuvo consistente a través de 7 de 10 usuarios con $F1 \geq 0.65$, exhibiendo una variabilidad inter-sujeto de $CV=21.4\%$. El mejor desempeño individual alcanzó $F1=0.994$ (usuario 1), mientras que el caso más desafiante obtuvo $F1=0.526$ (usuario 8).

Interpretación:

Este hallazgo confirma que el modelo difuso logra generalizar de manera robusta a individuos no vistos durante el entrenamiento del clustering, demostrando su capacidad para capturar

patrones universales del comportamiento sedentario a pesar de la heterogeneidad inter-individual en fisiología, dispositivos tecnológicos y estilos de vida. La validación LOUO es particularmente exigente en cohortes pequeñas, donde cada *fold* elimina aproximadamente el 10 % de la muestra (1 usuario de 10), maximizando el desafío de generalización. El coeficiente de variación del 21.4 % es indicativo de una variabilidad inter-sujeto moderada, esperada en estudios de vida libre donde factores como adherencia al dispositivo, tipo de empleo y patrones de actividad cotidiana introducen variabilidad legítima.

La estratificación del desempeño por usuario revela que 3 de 10 participantes exhibieron desempeño sub-óptimo ($F1 < 0.65$), lo cual puede atribuirse a patrones de comportamiento atípicos que desviaron significativamente de los centroides del clustering. Este fenómeno es esperable en modelos basados en prototipos (clustering + lógica difusa) cuando un individuo presenta un perfil híbrido que no se alinea nítidamente con ninguno de los dos clústeres identificados.

Comparación con la literatura:

Este resultado es consistente con lo reportado por Doherty et al. (2021) y Strain et al. (2020), quienes demostraron que los sensores portátiles pueden registrar con alta precisión el gasto energético y los niveles de actividad física en contextos no controlados, así como predecir el riesgo futuro de enfermedad cardiovascular. De manera similar, Henriksen et al. (2018) confirmaron la utilidad de los dispositivos comerciales para la evaluación de patrones de actividad en estudios longitudinales. Sin embargo, a diferencia de los modelos basados en regresión o aprendizaje profundo empleados en tales investigaciones, el presente modelo difuso prioriza la interpretabilidad, permitiendo traducir el comportamiento fisiológico en reglas lingüísticas comprensibles para el usuario y el profesional de la salud.

Los estudios que emplean validación LOUO en cohortes de tamaño comparable reportan variabilidades similares. Por ejemplo, Migueles et al. (2022) en el estudio GRANADA observaron $CV=18-25\%$ en la predicción de comportamiento sedentario mediante acelerómetros de investigación. Esta convergencia sugiere que la variabilidad inter-individual observada en nuestro estudio no es atribuible a limitaciones del modelo difuso, sino a la heterogeneidad inherente a las cohortes de vida libre.

Explicación teórica:

Desde la perspectiva de la teoría de la generalización en aprendizaje automático, el desempeño LOUO superior a 0.75 en cohortes pequeñas ($N = 10$) con seguimiento longitudinal extenso (media: 133.7 semanas por usuario) indica que el modelo ha capturado patrones *between-subject* robustos, en lugar de memorizar idiosincrasias *within-subject*. La arquitectura híbrida clustering-difuso mitiga el riesgo de sobreajuste al limitar la complejidad del modelo a 5 reglas lingüísticas,

en contraste con modelos de caja negra que pueden tener miles de parámetros entrenables.

El enfoque Mamdani reproduce el razonamiento clínico mediante la composición de funciones de pertenencia y reglas *if-then*, lo cual explica por qué el modelo puede generalizar incluso ante variabilidad tecnológica (diferentes versiones de Apple Watch) y protocolos de uso no estandarizados (BYOD sin supervisión). Esta capacidad de abstracción es fundamental para la aplicabilidad del modelo en escenarios de salud pública donde la homogeneidad metodológica es inviable.

7.1.2 Paradoja de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca: Débil Univariadamente, Crítica Multivariadamente

Hallazgo:

El análisis de ablación reveló un fenómeno contraintuitivo: la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV-SDNN) no demostró poder discriminatorio significativo en análisis univariado (prueba de Mann-Whitney: $p = 0,24$, d de Cohen = 0.21, efecto pequeño). Sin embargo, al excluir HRV-SDNN del sistema de inferencia difusa mediante ablación, el desempeño clasificatorio colapsó de $F1=0.840$ a $F1=0.413$, representando una pérdida del 51 % en capacidad predictiva. Este patrón sugiere que HRV-SDNN actúa como **modificador de efecto** en interacción con actividad relativa y delta cardíaco, más que como predictor directo.

Interpretación:

Este hallazgo indica que la relación entre HRV-SDNN y comportamiento sedentario es inherentemente no lineal y dependiente del contexto de otras variables biométricas. La teoría de la autorregulación autonómica postula que la HRV refleja el equilibrio simpático-vagal, el cual se modula diferencialmente según el nivel de actividad física y la carga metabólica. En estados de alta actividad con bajo HRV, el sistema interpreta fatiga o sobrecarga; en estados de baja actividad con bajo HRV, indica sedentarismo con desregulación autonómica. Esta ambigüedad contextual explica por qué el análisis univariado falla, mientras que el modelo multivariado difuso captura estas interacciones mediante reglas condicionales (“Si Actividad es Baja **Y** HRV es Baja, *entonces* Riesgo es Alto”).

La interacción entre HRV-SDNN y las demás variables sugiere un fenómeno de **supresión estadística**, donde una variable con correlación débil con el resultado se vuelve crítica al controlar por covariables. Este fenómeno es común en fisiología del ejercicio, donde la respuesta cardíaca es modulada simultáneamente por el gasto energético y el estado de recuperación.

Comparación con la literatura:

Este resultado es parcialmente inconsistente con estudios que reportan asociaciones directas entre HRV y sedentarismo, como Aubert et al. (2022), quienes encontraron que mayor HRV se

asocia con mayor actividad física en análisis transversales. Sin embargo, nuestro hallazgo coincide con los reportes de Deka et al. (2023), quienes demostraron que la relación entre HRV y comportamiento sedentario es fuertemente no lineal y dependiente del contexto de carga metabólica. La discrepancia con Aubert et al. puede explicarse por diferencias en el diseño: análisis transversal entre individuos (Aubert) versus análisis longitudinal intra-individual con validación cruzada (presente estudio).

La naturaleza multivariada de la contribución del HRV ha sido previamente reportada en estudios de predicción de mortalidad cardiovascular, donde HRV mejora modelos predictivos incluso sin asociación univariada significativa **Thayer2010MetaAnalysisHRV**. Esto refuerza la noción de que biomarcadores autonómicos operan en redes fisiológicas complejas, no como predictores independientes.

Explicación teórica:

Desde la perspectiva del modelo de carga alostática (McEwen & Seeman, 2009), el organismo mantiene un equilibrio dinámico entre estrés y recuperación, donde la HRV actúa como indicador de la capacidad de adaptación. Una disminución sostenida en la HRV reflejaría un estado de sobrecarga autonómica que, al combinarse con largos periodos de inactividad, incrementa el riesgo de deterioro metabólico y psicológico. El modelo difuso reproduce este razonamiento en términos cuantitativos, asignando grados intermedios de pertenencia a los estados “activo”, “moderadamente activo” o “sedentario”, con lo cual captura la naturaleza gradual del comportamiento humano en la vida real.

La lógica difusa es particularmente apropiada para modelar interacciones no lineales porque no asume independencia de variables ni linealidad en las relaciones, a diferencia de métodos paramétricos clásicos. Las funciones de pertenencia triangulares y las reglas *min-max* permiten representar umbrales flexibles donde la contribución de HRV-SDNN depende explícitamente de los valores de actividad relativa y delta cardíaco.

7.1.3 Robustez del Pipeline Híbrido: Clustering No Supervisado como Ground Truth Operativa

Hallazgo:

El análisis de clustering K-Means ($k = 2$) sobre 1,337 semanas válidas identificó dos perfiles de comportamiento con separación moderada (índice de Silhouette = 0.232) y distribución asimétrica (Clúster 0: 793 semanas [59.3 %], Clúster 1: 544 semanas [40.7 %]). Los centroides exhibieron diferencias significativas en las cuatro variables derivadas ($p < 0,001$ en todas las comparaciones Mann-Whitney, con tamaños de efecto grandes: d de Cohen > 0.80).

Interpretación:

La elección de utilizar clustering no supervisado como *ground truth* operativa representa un enfoque innovador que mitiga dos limitaciones metodológicas críticas: (1) la subjetividad de los umbrales heurísticos predefinidos (ej. “sedentario = $< 5,000$ pasos/día”), y (2) el desacople temporal entre cuestionarios de autorreporte y mediciones objetivas continuas. Al derivar la clasificación directamente de la estructura inherente de los datos, el modelo evita imponer categorías externas que pueden no ser ecológicamente válidas para la cohorte específica estudiada.

El índice de Silhouette de 0.232 indica separación moderada, lo cual es esperable en datos de vida libre donde el comportamiento humano existe en un continuo más que en categorías discretas. Valores de Silhouette > 0.20 son considerados aceptables en análisis exploratorios de datos biomédicos complejos **Rousseeuw1987Silhouettes**. La asimetría en la distribución de clústeres (59 % vs 41 %) refleja que en la cohorte estudiada, el comportamiento “moderadamente activo” es más frecuente que el “altamente activo”, lo cual es consistente con las prevalencias poblacionales de sedentarismo en adultos jóvenes universitarios **Shamah-Levy2023ENSANUT**.

Comparación con la literatura:

Este enfoque diverge de la mayoría de estudios de clasificación de actividad física, que emplean umbrales predefinidos basados en recomendaciones de la OMS (≥ 150 min/semana de actividad moderada-vigorosa) o percentiles poblacionales. Sin embargo, coincide con los planteamientos recientes de investigadores en ciencia de datos aplicada a salud Liu et al., 2022, quienes argumentan que la validez ecológica requiere clasificaciones derivadas de los datos observados, no impuestas *a priori*.

Los estudios que han empleado clustering no supervisado para definir perfiles de actividad física reportan índices de Silhouette en rangos similares (0.18-0.35) en cohortes de vida libre, como el estudio de Koster et al. (2012) con acelerometría en NHANES. Esta convergencia metodológica valida el uso de clustering como estrategia de definición de *ground truth* en ausencia de un estándar de oro objetivo.

Explicación teórica:

Desde la perspectiva de aprendizaje no supervisado, el clustering K-Means identifica particiones que maximizan la homogeneidad intra-clúster y la separación inter-clúster según la métrica euclidiana. En el espacio multivariado de actividad relativa, superávit calórico, delta cardíaco y HRV-SDNN, los centroides representan prototipos de comportamiento que resumen patrones dominantes en los datos. Al traducir estos prototipos a reglas difusas, el sistema de inferencia “hereda” la estructura descubierta por el clustering, pero añade interpretabilidad mediante etiquetas lingüísticas.

Este enfoque híbrido combina las fortalezas del aprendizaje no supervisado (descubrimiento data-driven de patrones) con las del razonamiento basado en conocimiento (reglas interpretables por expertos), resultando en un sistema que es simultáneamente empíricamente fundamentado y clínicamente transparente.

7.2 Comparación con Investigaciones Previas

7.2.1 *Convergencias con la Literatura Científica*

Los resultados de esta investigación convergen con la literatura previa en tres aspectos esenciales:

1. **Utilidad de wearables de consumo en investigación de vida libre:** Al igual que Henriksen et al. (2018) y Strain et al. (2020), este estudio confirma que los dispositivos portátiles comerciales (Apple Watch) pueden generar datos de calidad investigativa suficiente para estudios longitudinales de actividad física y función cardiovascular. Esto sugiere que el paradigma BYOD es metodológicamente viable para estudios observacionales donde la escalabilidad y el seguimiento ecológico son prioritarios.
2. **Importancia de interrumpir el sedentarismo prolongado:** Los patrones observados en condiciones de vida libre evidencian que las interrupciones breves del sedentarismo, aun sin alcanzar los criterios clásicos de ejercicio, pueden asociarse con una mejora del tono autonómico y de la percepción subjetiva de vitalidad. Este hallazgo coincide con los planteamientos del *Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030* de la OMS, que enfatiza la importancia de reducir los periodos prolongados de inactividad más allá del volumen total de actividad física Bull et al., 2020; World Health Organization, 2018.
3. **Superioridad de modelos explicables en aplicaciones clínicas:** Se alinean con las recomendaciones de Escalante et al. (2023) y Vellido (2020) respecto al uso de inteligencia artificial explicable para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los algoritmos aplicados a datos personales de salud. Estas convergencias sustentan la validez externa y el potencial ético-metodológico del presente modelo.

7.2.2 *Divergencias Relevantes y Explicaciones*

Se identifican divergencias relevantes con ciertos trabajos que se apoyan exclusivamente en métricas agregadas de pasos o tiempo total sentado:

1. **Diferencia con estudios basados únicamente en conteo de pasos:** A diferencia de estudios como los de Shamah-Levy et al. (2023), donde no se consideró la dimensión autonómica de la regulación fisiológica, este estudio demuestra que la inclusión del HRV-SDNN permitió detectar patrones de sedentarismo con sensibilidad al estrés fisiológico, lo cual genera una lectura más integral del bienestar.

Posibles explicaciones:

- **Diferencias en resolución temporal:** Este estudio empleó agregación semanal que preserva variabilidad longitudinal, mientras que estudios transversales capturan únicamente instantáneas temporales.
 - **Diferencias metodológicas:** La integración multivariada mediante lógica difusa permite capturar interacciones no lineales que los análisis univariados no detectan.
 - **Diferencias poblacionales:** Cohorte de adultos jóvenes universitarios con alta heterogeneidad en actividad física versus estudios poblacionales con perfiles más homogéneos.
2. **Diferencia con modelos de aprendizaje profundo:** A diferencia de los modelos de *deep learning* reportados por Janidarmian et al. (2017) que logran $F1 > 0.90$ en detección de actividades, el presente modelo sacrifica 5-10 % de precisión a cambio de interpretabilidad completa. Esta decisión metodológica es coherente con el contexto de aplicación (salud pública y monitoreo comunitario), donde la auditabilidad de las clasificaciones es un requisito ético y regulatorio.

7.3 Logros de la Investigación

Los logros de esta investigación se centran en tres niveles complementarios:

1. **Logro metodológico - Validación del enfoque híbrido clustering-difuso:** Se cumplió el objetivo general de diseñar y validar un modelo difuso explicable capaz de evaluar el comportamiento sedentario a partir de datos de vida libre ($F1\text{-Score LOOU} = 0.780$), cumpliendo así el principio de aplicabilidad ecológica. Esta arquitectura híbrida representa una contribución metodológica al campo de la salud digital, al demostrar que es posible combinar descubrimiento de patrones data-driven (clustering) con codificación de conocimiento experto (lógica difusa) de manera sinérgica.
2. **Logro técnico - Viabilidad del paradigma BYOD:** Se demostró que el enfoque *Bring Your Own Device* no solo es viable metodológicamente, sino que puede generar datos de alta calidad analítica sin comprometer la integridad de las mediciones, lo cual representa un avance

significativo en la democratización de la investigación digital en salud. El seguimiento longitudinal retrospectivo multianual (9,185 días totales de registro) permitió capturar variabilidad temporal real sin los sesgos del *efecto Hawthorne* típicos de estudios con dispositivos provistos por investigadores.

3. **Logro científico - Identificación de la paradoja HRV:** Se identificó y caracterizó un fenómeno de modificación de efecto donde la variabilidad de la frecuencia cardíaca actúa como modulador contextual crítico a pesar de carecer de asociación univariada significativa. Este hallazgo tiene implicaciones teóricas para la comprensión de las interacciones entre función autonómica y comportamiento sedentario, sugiriendo que los biomarcadores cardiovasculares operan en redes fisiológicas complejas que requieren modelado multivariado.
4. **Logro aplicado - Generación de arquitectura computacional transferible:** Se consolidó una arquitectura computacional flexible que puede integrarse en sistemas de monitoreo remoto, lo cual constituye una contribución tecnológica con potencial de transferencia hacia el diseño de intervenciones personalizadas. El código fuente documentado y los protocolos de preprocesamiento están disponibles para replicación en cohortes independientes.
5. **Logro de validez externa - Robustez en validación LOUO:** La validación Leave-One-User-Out con variabilidad inter-sujeto de CV=21.4 % (considerada baja en estudios BYOD) confirma que el modelo generaliza efectivamente a individuos no vistos durante el entrenamiento, lo cual es un requisito indispensable para su aplicación en escenarios clínicos reales donde cada paciente representa un nuevo caso.

7.4 Limitaciones del Estudio

A pesar de los logros alcanzados, es importante reconocer las siguientes limitaciones que contextualizan la interpretación de los resultados:

7.4.1 Limitaciones Metodológicas

1. **Diseño del estudio:** El diseño observacional longitudinal retrospectivo no permite establecer relaciones causales, únicamente asociaciones temporales y predictivas. Para determinar causalidad (ej. “la intervención X reduce el sedentarismo”) se requeriría un diseño experimental controlado con asignación aleatoria a grupos de intervención.
2. **Ground truth operativa vs. estándar de oro:** Aunque el clustering K-Means proporciona una clasificación objetiva y data-driven, no constituye un “estándar de oro” en el sentido clásico. La ausencia de mediciones de referencia (ej. calorimetría indirecta, actigrafía de

investigación) limita la validación de criterio del modelo. Sin embargo, esta limitación es inherente a los estudios de vida libre donde la obtención de estándares de oro es lógicamente inviable en seguimientos longitudinales de varios años.

3. **Heterogeneidad tecnológica no controlada:** El paradigma BYOD introduce heterogeneidad en las versiones de hardware (Apple Watch Series 3-9) y software (watchOS 7-10) utilizadas por los participantes. Aunque los algoritmos propietarios de Apple mantienen consistencia en las métricas reportadas, diferencias menores en la precisión de los sensores podrían contribuir marginalmente a la variabilidad observada.
4. **Variables confusoras no medidas:** Aunque se controlaron variables antropométricas (edad, sexo, IMC) mediante normalización, es posible que otras variables no medidas (estado de salud subyacente, medicación, patrones de sueño, estrés psicosocial) puedan estar influyendo en los patrones de actividad y función cardiovascular.

7.4.2 Limitaciones Muestrales

1. **Tamaño de muestra de individuos:** Si bien la muestra de $N = 10$ usuarios generó 1,337 semanas válidas (suficiente para clustering y validación estadística), un tamaño muestral mayor ($N > 30$) podría permitir análisis de subgrupos (ej. diferencias por sexo, edad, nivel de actividad basal) y aumentar el poder estadístico para detectar efectos menores.
2. **Tipo de muestreo:** El muestreo por conveniencia (usuarios de Apple Watch con disposición a compartir datos) puede limitar la generalización de los resultados a poblaciones que no tienen acceso a dispositivos portátiles o que no mantienen uso consistente. Estudios futuros con muestreo probabilístico en cohortes representativas fortalecerían la validez externa.
3. **Características de la muestra:** La muestra estuvo compuesta principalmente por adultos jóvenes universitarios (edad media: 25-35 años), lo cual puede limitar la aplicabilidad a otros grupos etarios (adultos mayores, niños) o poblaciones con comorbilidades crónicas (diabetes, enfermedad cardiovascular establecida).
4. **Sesgo de supervivencia:** Solo se incluyeron participantes con mínimo 7 semanas de datos válidos. Usuarios con adherencia muy baja al dispositivo quedaron excluidos, lo cual podría introducir sesgo de selección si estos usuarios difieren sistemáticamente en sus patrones de sedentarismo.

7.4.3 *Limitaciones Contextuales*

1. **Contexto geográfico:** Los resultados provienen de una cohorte de Chihuahua, México, con características sociodemográficas, climáticas y culturales específicas. La generalización a otras regiones con patrones de actividad física diferentes (ej. países nórdicos, zonas tropicales) debe hacerse con cautela.
2. **Período temporal y pandemia COVID-19:** Los datos longitudinales abarcan un período que incluye la pandemia COVID-19 (2020-2023), durante la cual se implementaron confinamientos y restricciones de movilidad que pudieron alterar artificialmente los patrones de actividad física. Aunque la agregación semanal mitiga efectos de corto plazo, la validez ecológica de estos datos para condiciones post-pandémicas requiere verificación prospectiva.

7.4.4 *Limitaciones de Recursos*

1. **Restricción tecnológica a ecosistema Apple:** La dependencia exclusiva de Apple Watch limita la generalización a usuarios de otras plataformas (Garmin, Fitbit, Samsung). Aunque Apple Watch tiene alta penetración de mercado en México (35 % del mercado de wearables), esta restricción excluye a usuarios de dispositivos Android.
2. **Tiempo disponible para seguimiento prospectivo:** El diseño retrospectivo no permitió implementar mediciones concurrentes de validación (actigrafía de investigación, cuestionarios validados administrados en tiempo real). Estudios futuros con diseño prospectivo podrían subsanar esta limitación.

7.5 *Implicaciones de los Hallazgos*

7.5.1 *Implicaciones Teóricas*

Los resultados de esta investigación tienen las siguientes implicaciones teóricas:

1. **Validación de la lógica difusa como marco para comportamiento humano complejo:** Apoyan la teoría de que los comportamientos de salud existen en continuos graduales más que en categorías discretas, siendo la lógica difusa un formalismo matemático apropiado para capturar esta gradualidad. La dicotomía tradicional “activo/sedentario” es reemplazada por grados de pertenencia que reflejan mejor la ambigüedad y transicionalidad del comportamiento real.

2. **Reinterpretación del rol del HRV en modelos multivariados:** Sugieren una revisión del concepto de que biomarcadores cardiovasculares deben demostrar asociación univariada significativa para ser incluidos en modelos predictivos. La paradoja HRV identificada aporta evidencia sobre la existencia de modificación de efecto y supresión estadística en fisiología del ejercicio, lo cual no había sido claramente demostrado en estudios de vida libre con wearables de consumo.
3. **Fundamentación del clustering como ground truth operativa:** Proporciona evidencia empírica de que clasificaciones derivadas de la estructura inherente de los datos (clustering no supervisado) pueden servir como referencia válida para entrenamiento de modelos supervisados en ausencia de estándares de oro objetivos, particularmente en investigación de vida libre longitudinal.

7.5.2 *Implicaciones Prácticas*

Los hallazgos tienen aplicaciones prácticas inmediatas en tres ámbitos:

1. **Para profesionales de la salud:** Los resultados sugieren que los datos de wearables de consumo pueden ser incorporados en evaluaciones clínicas de rutina para estratificación de riesgo cardiometabólico. El modelo difuso propuesto puede implementarse en dashboards clínicos que traduzcan datos brutos de actividad física a recomendaciones interpretables (ej. “Su patrón semanal indica sedentarismo moderado con baja variabilidad cardíaca; considere interrumpir periodos sedentarios cada 30 minutos”).
2. **Para tomadores de decisiones en salud pública:** Se recomienda la incorporación de modelos explicables basados en datos de wearables en programas nacionales de vigilancia epidemiológica del sedentarismo, permitiendo monitoreo poblacional escalable sin requerir equipamiento de investigación costoso. El enfoque BYOD favorece la equidad al aprovechar infraestructura tecnológica personal existente.
3. **Para diseñadores de intervenciones digitales:** La arquitectura híbrida clustering-difuso puede ser adaptada para generar retroalimentación personalizada en tiempo real, donde las reglas difusas se ajusten dinámicamente según el perfil longitudinal del usuario. Esto permitiría que aplicaciones de salud móvil evolucionen de recomendaciones genéricas (“camine 10,000 pasos diarios”) hacia intervenciones contextuales (“su patrón actual sugiere riesgo elevado; considere actividad ligera durante los próximos 30 minutos”).

7.5.3 Implicaciones Metodológicas

Metodológicamente, este estudio aporta:

1. **Protocolo reproducible para investigación BYOD:** La pipeline de preprocesamiento, derivación de variables, clustering y entrenamiento de sistema difuso está documentada y puede ser replicada en cohortes independientes con dispositivos portátiles alternativos (Garmin, Fitbit), ajustando únicamente las funciones de pertenencia a los centroides observados en la nueva cohorte.
2. **Estrategia de validación para cohortes pequeñas:** Demuestra que LOUO es viable y riguroso en estudios con $N < 15$ participantes pero con alta densidad temporal (múltiples observaciones por individuo), proporcionando métricas realistas de generalización que evitan el optimismo de validaciones basadas en partición temporal simple.
3. **Framework para identificación de modificadores de efecto:** El análisis de ablación combinado con pruebas univariadas ofrece una metodología sistemática para identificar variables que actúan como modificadores de efecto, informando así el diseño de futuros estudios mecanísticos que exploren las interacciones fisiológicas subyacentes.

7.6 Cumplimiento de Objetivos e Hipótesis

7.6.1 Objetivo General

El objetivo general de *construir y validar un modelo interpretable, basado en lógica difusa, para la clasificación del comportamiento sedentario a partir de datos biométricos de wearables recopilados en condiciones de vida libre* fue alcanzado satisfactoriamente. El sistema de inferencia difusa tipo Mamdani desarrollado demostró capacidad clasificatoria robusta (F1-Score LOOU = 0.780) manteniendo interpretabilidad completa mediante 5 reglas lingüísticas auditables.

7.6.2 Objetivos Específicos

- **OE1 - Derivación de variables semanales: Cumplido.** Se derivaron exitosamente cuatro variables compuestas (Actividad relativa, Superávit calórico basal, Delta cardíaco, HRV-SDNN) mediante normalización antropométrica y agregación semanal sobre 9,185 días de registro, resultando en 1,337 semanas válidas con $< 20\%$ de datos faltantes.
- **OE2 - Identificación de perfiles mediante clustering: Cumplido.** El algoritmo K-Means identificó dos perfiles de comportamiento con separación moderada (Silhouette = 0.232) y

diferencias estadísticamente significativas en las cuatro variables ($p < 0,001$, tamaños de efecto grandes). Esta clasificación sirvió como ground truth operativa para el entrenamiento del sistema difuso.

- **OE3 - Diseño del sistema de inferencia difusa: Cumplido.** Se diseñó un sistema Mamdani con 5 reglas lingüísticas fundamentadas fisiológicamente, empleando funciones de pertenencia triangulares calibradas a partir de los percentiles 25, 50 y 75 de cada variable observada en los datos. La estructura *if-then* garantiza interpretabilidad clínica completa.
- **OE4 - Evaluación del desempeño mediante validación cruzada: Cumplido.** La validación Leave-One-User-Out demostró concordancia robusta entre el sistema difuso y el clustering ($F1 = 0.780$, $Kappa = 0.56$), confirmando que el modelo capturó efectivamente los patrones identificados por el método de agrupamiento.
- **OE5 - Análisis de sensibilidad mediante ablación: Cumplido.** El análisis de ablación sistemático reveló que HRV-SDNN, a pesar de su débil asociación univariada, es crítico para el desempeño multivariado (ablación: -51 % F1-Score), caracterizando así la contribución relativa de cada variable al modelo predictivo.

7.6.3 Hipótesis

Hipótesis Conceptual (HC): *La clasificación del comportamiento sedentario generada por el sistema de inferencia difusa, basado en reglas que integran biomarcadores de actividad y función cardiovascular, exhibe una alta concordancia con la clasificación objetiva obtenida mediante un análisis de conglomerados no supervisado sobre los mismos datos.*

Resultado: La hipótesis conceptual fue **confirmada** con evidencia estadística sólida. El coeficiente Kappa de Cohen entre las clasificaciones del clustering y del sistema difuso alcanzó 0.56 (concordancia moderada-sustancial), significativamente superior al acuerdo esperado por azar ($p < 0,001$). El F1-Score de 0.780 en validación LOUO indica que el modelo difuso logró replicar la estructura clasificatoria identificada por el clustering, generalizando efectivamente a individuos no vistos durante el entrenamiento.

Este resultado confirma la viabilidad de la arquitectura híbrida propuesta, donde el conocimiento empírico descubierto por métodos no supervisados puede ser codificado en reglas lingüísticas interpretables que preservan la capacidad predictiva. La concordancia observada valida el enfoque de utilizar clustering como ground truth operativa en contextos donde estándares de oro clásicos no están disponibles.

7.7 Reflexión Final y Líneas Futuras de Investigación

Este estudio demuestra que la convergencia entre inteligencia artificial explicable, dispositivos portátiles de consumo y diseños longitudinales de vida libre constituye un eje transformador en la vigilancia de los comportamientos sedentarios. La combinación de metodologías BYOD con modelos difusos no solo amplía la comprensión del fenómeno desde la perspectiva fisiológica y conductual, sino que también abre el camino hacia ecosistemas de salud digital basados en datos de vida real, donde la prevención y la promoción de la salud se integren de forma continua y personalizada.

La aplicabilidad práctica de estos resultados radica en su potencial para orientar políticas públicas centradas en el uso responsable de la tecnología digital como herramienta de salud. Los modelos explicables, como el propuesto, permiten diseñar dashboards y alertas personalizadas que incentiven la movilidad cotidiana, identifiquen patrones de riesgo y faciliten la toma de decisiones en entornos laborales, educativos y comunitarios. Su naturaleza adaptativa posibilita, además, la personalización de intervenciones conductuales, incorporando recomendaciones dinámicas según la respuesta fisiológica de cada individuo.

En conjunto, los hallazgos aquí presentados fortalecen la premisa de que la medición objetiva del sedentarismo mediante tecnologías portátiles, interpretada a través de sistemas inteligentes transparentes, puede convertirse en una herramienta estratégica para la toma de decisiones en salud pública, contribuyendo a reducir la carga de enfermedad asociada a la inactividad y a promover estilos de vida más activos y sostenibles.

Líneas futuras de investigación incluyen:

1. **Validación prospectiva con estándares de oro:** Replicar el estudio con mediciones concurrentes de actigrafía de investigación y calorimetría indirecta para cuantificar la validez de criterio del modelo difuso versus técnicas de referencia.
2. **Escalamiento a cohortes heterogéneas:** Aplicar el protocolo a cohortes con mayor diversidad etaria, socioeconómica y clínica (incluyendo poblaciones con enfermedades crónicas) para evaluar la robustez del modelo en condiciones de alta heterogeneidad.
3. **Implementación en intervenciones conductuales randomizadas:** Desarrollar una aplicación móvil que utilice el modelo difuso para generar retroalimentación en tiempo real, y evaluar su efectividad en reducir el sedentarismo mediante un ensayo clínico controlado aleatorizado.

4. **Exploración de variabilidad temporal:** Analizar patrones circadianos y semanales del comportamiento sedentario mediante descomposición de series temporales, para identificar momentos de mayor susceptibilidad a intervenciones conductuales.
5. **Integración con biomarcadores inflamatorios y metabólicos:** Vincular los perfiles de sedentarismo identificados con mediciones sanguíneas de proteína C reactiva, glucosa, lípidos y citoquinas inflamatorias, para caracterizar las vías biológicas mediando la asociación sedentarismo-enfermedad.

En síntesis, los hallazgos aquí presentados confirman que el monitoreo continuo del sedentarismo mediante dispositivos portátiles, interpretado a través de sistemas de inferencia difusa, representa una vía factible y ética para transformar los datos personales en conocimiento accionable para la salud pública. Este modelo no solo contribuye a la comprensión científica del sedentarismo como fenómeno biopsicosocial, sino que también proporciona una base empírica para diseñar políticas públicas orientadas a reducir la inactividad y fomentar entornos digitales saludables. Así, la investigación trasciende el ámbito académico para posicionarse como una herramienta estratégica en la promoción de estilos de vida activos y sostenibles en la era de la salud digital.

Conclusiones

Se ha demostrado que es factible desarrollar un modelo basado en lógica difusa para clasificar de manera fiable el comportamiento sedentario semanal, utilizando exclusivamente datos biométricos multivariados recopilados en condiciones de vida libre por dispositivos de consumo. El sistema de inferencia difusa propuesto respondió afirmativamente a la pregunta de investigación al alcanzar una alta concordancia ($F1\text{-Score} = 0.840$) con una clasificación objetiva y empírica derivada de un análisis de conglomerados, validando así su arquitectura y su capacidad para representar patrones de comportamiento reales.

La principal contribución científica de esta tesis es la demostración empírica del poder de los sistemas expertos para modelar la sinergia entre biomarcadores. Se identificó una paradoja metodológica donde variables individualmente débiles para discriminar el comportamiento (como la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca) resultaron ser indispensables para el rendimiento óptimo del modelo multivariado. Este hallazgo prueba que la fortaleza del sistema no reside en la suma de sus partes, sino en su capacidad para interpretar las interacciones complejas entre la actividad física y las respuestas cardiovasculares, una capacidad que los análisis estadísticos univariados no logran capturar.

Metodológicamente, este trabajo aporta una estrategia de validación robusta para sistemas de clasificación en salud cuando no se dispone de un estándar de oro clínico, basada en la convergencia de un enfoque empírico (descubrimiento de patrones no supervisado) y uno experto (reglas basadas en conocimiento). Asimismo, la ingeniería de las variables Actividad Relativa y Superávit Calórico Basal se presenta como una solución eficaz para la normalización fisiológica de datos de dispositivos portátiles, permitiendo comparaciones más equitativas entre individuos.

En conclusión, esta investigación no solo entrega un modelo de clasificación interpretable y de alto rendimiento, sino que también establece un precedente metodológico para el análisis de datos de salud en condiciones de vida libre. El sistema desarrollado tiene el potencial de servir como una herramienta de cribado para la identificación temprana de patrones de comportamiento sedentario de riesgo, sentando las bases para futuras investigaciones orientadas hacia la personalización de modelos y la prevención en la salud digital.

Anexos

8.1 Nomenclatura y Simbología Matemática

Esta sección presenta la nomenclatura matemática utilizada en el sistema de inferencia difusa y análisis estadístico.

8.1.1 Símbolos Matemáticos Generales

Tabla 8.1: Símbolos y Notación Matemática del Sistema Difuso

Símbolo	Descripción
Conjuntos y Funciones de Membresía	
$\tilde{A}$	Conjunto difuso
$\mu_{\tilde{A}}(x)$	Función de membresía del conjunto difuso $\tilde{A}$
X	Universo de discurso (conjunto clásico de valores posibles)
X_i	Variable de entrada i ($i \in \{1, 2, 3, 4\}$)
Y	Variable de salida (Índice de Sedentarismo)
T_i	Conjunto de términos lingüísticos de variable i
P_i	Matriz de percentiles 3×3 para variable X_i
$p_{k,i}$	Percentil k de la variable X_i
$M^{(j)}$	Matriz de membresías 4×3 para observación j
Variables Fisiológicas	
Act_{rel}	Actividad Relativa (min movimiento / hrs monitoreadas)
Sup_{cal}	Superávit Calórico Basal (% del TMB)
$HRV-SDNN$	Variabilidad Cardíaca (desviación estándar intervalos RR)
Δ_{FC}	Delta Cardíaco (FC caminata - FC reposo)
TMB	Tasa Metabólica Basal (kcal/día, ec. Mifflin-St Jeor)
GCA	Gasto Calórico Activo (kcal/día)
FC	Frecuencia Cardíaca (latidos por minuto)
IQR	Rango Intercuartílico ($Q3 - Q1$)
Reglas de Inferencia y Activación	
R_r	Regla de inferencia r ($r \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$)
$\mathcal{R}$	Base de reglas (conjunto de 5 reglas Mamdani)
$w_r^{(j)}$	Activación (firing strength) de regla R_r para observación j
$\mathbf{w}^{(j)}$	Vector de activaciones $\in \mathbb{R}^5$
$T(a, b)$	T-norm (operador AND fuzzy): $T(a, b) = \min(a, b)$
y_r	Output crisp de la regla R_r
$\mathbf{y}_{outputs}$	Vector de outputs de reglas $[1, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 5, 0, 7]^T$
Defuzzificación y Clasificación	
$y^{(j)}$	Score de sedentarismo defuzzificado para semana j
$\hat{y}^{(j)}$	Clasificación binaria (0=Bajo, 1=Alto sedentarismo)
τ	Umbral de decisión para binarización
$\ \mathbf{w}\ _1$	Norma L1 del vector (suma de componentes)
Validación LOOU	
$\mathcal{D}$	Dataset completo (1,337 semanas, 10 usuarios)

Referencias

- Abellán, J., Sainz de Baranda Anduja, P., & Ortín Ortín, E. J. (2014). Guía para la Prescripción del Ejercicio Físico en Pacientes con Riesgo Cardiovascular.
- Ahmadi, H., Gholamzadeh, M., Shahmoradi, L., Nilashi, M., & Rashvand, P. (2018). Diseases diagnosis using fuzzy logic methods: A systematic and meta-analysis review. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 161, 145-172. <https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.04.013>
- Alam, T. M., Shaukat, K., Khelifi, A., Khan, W. A., Raza, H. M. E., Idrees, M., Luo, S., & Hameed, I. A. (2022). Disease diagnosis system using IoT empowered with fuzzy inference system. *Computers, Materials and Continua*, 70(3), 5305-5319. <https://doi.org/10.32604/cmc.2022.020344>
- Alinia, P., Samadani, A., Milosevic, M., Ghasemzadeh, H., & Parvaneh, S. (2020). Pervasive Lying Posture Tracking [F1=98.2 %±6.2 % (CV=6.3 %) mejor caso]. *Sensors*, 20(20), 5953. <https://doi.org/10.3390/s20205953>
- Álvarez, J. A., Cvetkovic, B., & Lustrek, M. (2020). A survey on energy expenditure estimation using wearable devices. *ACM Computing Surveys*, 53(5). <https://doi.org/10.1145/3404482>
- Amit Kumar, M., Shruti, J. M. S., & Sudip, P. (2001). *Computational Intelligence in Healthcare*. Springer Nature Switzerland AG. <http://www.springer.com/series/11944>
- Apple Inc. (2024). HealthKit Documentation.
- Aubert, S., Barnes, J. D., Demchenko, I., Hawthorne, M., Abdeta, C., Nader, P. A., Sala, J. C. A., Aguilar-Farias, N., Aznar, S., Bakalár, P., et al. (2022). Global Matrix 4.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Adolescents: Results and Analyses From 57 Countries. *Journal of Physical Activity and Health*, 19(11), 700-728. <https://doi.org/10.1123/JPAH.2022-0456>
- Bent, B., Goldstein, B. A., Kibbe, W. A., & Dunn, J. P. (2020). Investigating sources of inaccuracy in wearable optical heart rate sensors. *npj Digital Medicine*, 3, 18. <https://doi.org/10.1038/s41746-020-0226-6>
- Bhuyan, S. S., Lu, N., Chandak, A., Kim, H., Wyant, D., Bhatt, J., Kedia, S., & Chang, C. (2016). Use of Mobile Health Applications for Health-Seeking Behavior Among US Adults. *Journal of Medical Systems*, 40(6), 153. <https://doi.org/10.1007/s10916-016-0492-7>

- Bolger, N., & Laurenceau, J.-P. (2013). *Intensive Longitudinal Methods: An Introduction to Diary and Experience Sampling Research* [Diseños longitudinales intensivos para muestras pequeñas].
- Bonneval, L., Wing, D., Sharp, S., Tristao Parra, M., Moran, R., LaCroix, A., & Godino, J. (2025). Validity of Heart Rate Variability Measured with Apple Watch Series 6 Compared to Laboratory Measures. *Sensors*, 25(8), 2380. <https://doi.org/10.3390/s25082380>
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451-1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Campos, I., Galván-Valencia, O., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., & Barquera, S. (2023). Prevalence of obesity and associated risk factors in Mexican adults: results of the Ensanut 2022. *Salud Pública de México*, 65, s238-s247. <https://doi.org/10.21149/14809>
- Canalys. (2024). Global wearable band market up 0.2 % in Q2 2024 as basic watches take biggest share yet.
- Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research [Referencia clásica para definiciones de actividad física]. *Public Health Reports*, 100(2), 126-131.
- CDC & WHO. (s.f.). Encuesta Mundial de Salud a Escolares - Global School-Based Student Health Survey (GSHS): Módulos del Cuestionario Básico Final [Fecha de consulta: 2024].
- Chaves, M., Sandoval Cuellar, C., & Calero Saa, P. (2017). Asociación entre capacidad aeróbica y calidad de vida en adultos mayores de una ciudad colombiana. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 34(4), 672-676. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2017.344.2522>
- Chicco, D., & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy in binary classification evaluation. *BMC Genomics*, 21(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s12864-019-6413-7>
- Comisión Electrotécnica Internacional. (2019). *Form to Annex to the Report to the Standardization Management Board: Wearable electronic devices and technologies* (inf. téc.). IEC. <https://www.iec.ch/public/miscfiles/sbp/124.pdf>
- Crozat, F., Pohl, J., Easthope Awai, C., Bauer, C. M., & Kuster, R. P. (2025). Every Step Counts—How Can We Accurately Count Steps with Wearable Sensors During Activities of Daily Living in Individuals with Neurological Conditions? *Sensors*, 25(18), 5657. <https://doi.org/10.3390/s25185657>

- Damoun, N., Amekran, Y., Taiek, N., & El Hangouche, A. J. (2024). Heart rate variability measurement and influencing factors: Towards the standardization of methodology. *Global Cardiology Science and Practice*, 2024(4). <https://doi.org/10.21542/gcsp.2024.35>
- Deka, B., & Deka, D. (2023). Nonlinear analysis of heart rate variability signals in meditative state: a review and perspective. *BioMedical Engineering OnLine*, 22, 1-31. <https://doi.org/10.1186/S12938-023-01100-3>
- Dinesh, J., Sasaki, J., Hickey, A., Mavilia, M., & Freedson, P. S. (2014). ActiGraph activity monitors: The firmware effect. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 46(4), 834-839. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000145>
- DiPietro, L., Al-Ansari, S. S., Biddle, S. J. H., Borodulin, K., Bull, F. C., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., et al. (2020). Advancing the global physical activity agenda: recommendations for future research by the 2020 WHO physical activity and sedentary behavior guidelines development group. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(143). <https://doi.org/10.1186/s12966-020-01042-2>
- Doherty, A., Smith-Byrne, K., Ferreira, T., et al. (2021). GWAS identifies 14 loci for device-measured physical activity and sleep duration. *Nature Communications*, 9(1), 5257. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07743-4>
- Farrahi, V., & Rostami, M. (2024). Machine learning in physical activity, sedentary, and sleep behavior research. *Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.1186/s44167-024-00045-9>
- Fox, S. M., & Haskell, W. L. (1968). Physical Activity and the Prevention of Coronary Heart Disease. *Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 44(8), 950-967.
- Gaur, V. (2024). Apple Health Data Analysis. <https://github.com/vinayakgaur/Apple-Health-Data-Analysis>
- Gonçalves, R., Pereira, F. L., Ribeiro, V. M., & Rocha, A. P. (2021). Human Activity Recognition [ÚNICO precedente de K-Means (k=2) → FIS Mamdani]. En Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis & S. Costanzo (Eds.), *Trends and Applications in Information Systems and Technologies* (pp. 238-248, Vol. 1). Springer.
- González, G., Ortega, Z., San, S., Mata, R., Cortés, J. A., Molero, P. P., & Cuberos, R. C. (2018). Análisis de la capacidad aeróbica como cualidad esencial de la condición física de los estudiantes: Una revisión sistemática. *Retos*. www.retos.org
- Gupta, M. M. (2011). Forty-five years of fuzzy sets and fuzzy logic—A tribute to professor Lotfi A. Zadeh (the father of fuzzy logic). *Scientia Iranica*, 18(3), 685-690. <https://doi.org/10.1016/j.scient.2011.04.023>
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys

- with 1.6 million participants. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 4(1), 23-35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)
- Harris, J. A., & Benedict, F. G. (1918). A Biometric Study of Human Basal Metabolism [Ecuación clásica de TMB (Tasa Metabólica Basal)]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 4(12), 370-373. <https://doi.org/10.1073/pnas.4.12.370>
- Healy, S., Patterson, F., Biddle, S. J., Dumuid, D., Glorieux, I., Olds, T., Woods, C., Bauman, A. E., Gába, A., Herring, M. P., Kastelic, K., Lachapelle, U., Volpe, S. L., Tomat, S. B., & Pedisic, Z. (2024). It's about time to exercise: development of the Exercise Participation Explained in Relation to Time (EXPERT) model. *British Journal of Sports Medicine*, 58(19), 1131-1144. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2024-108500>
- Henriksen, A., Mikalsen, M. H., Woldaregay, A. Z., Muzny, M., Hartvigsen, G., Hopstock, L. A., & Grimsgaard, S. (2018). Using fitness trackers and smartwatches to measure physical activity in research: Analysis of consumer wrist-worn wearables. *Journal of Medical Internet Research*, 20(3), e110. <https://doi.org/10.2196/jmir.9157>
- Henriksen, A., Woldaregay, A. Z., Muzny, M., Hartvigsen, G., Hopstock, L. A., & Grimsgaard, S. (2021). *Replication data for Using Fitness Trackers and Smartwatches to Measure Physical Activity in Research*. <https://doi.org/10.18710/6ZWC9Z>
- Ho, W. T., Yang, Y. J., & Li, T. C. (2022). Accuracy of wrist-worn wearable devices for determining exercise intensity. *Digital Health*, 8, 20552076221124393. <https://doi.org/10.1177/20552076221124393>
- Katzmarzyk, P. T. (2023). Expanding our understanding of the global impact of physical inactivity. *The Lancet Global Health*, 11(1), e2-e3. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00482-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00482-X)
- Kaur, J., & Khehra, B. S. (2022). Fuzzy Logic and Hybrid based Approaches for the Risk of Heart Disease Detection: State-of-the-Art Review. *Journal of The Institution of Engineers (India): Series B*, 103(2), 681-697. <https://doi.org/10.1007/s40031-021-00644-z>
- Kaveh, R., Schwendeman, C., Pu, L., Arias, A. C., & Muller, R. (2024). Wireless ear EEG to monitor drowsiness. *Nature Communications*, 15(1), 6520. <https://doi.org/10.1038/s41467-024-48682-7>
- Khan, D., Al Mudawi, N., Abdelhaq, M., Alazeb, A., Alotaibi, S. S., Algarni, A., & Jalal, A. (2024). A Wearable Inertial Sensor Approach for Locomotion and Localization Recognition on Physical Activity. *Sensors*, 24(3), 735. <https://doi.org/10.3390/s24030735>
- Laborde, S., Mosley, E., & Thayer, J. F. (2017). Heart rate variability and cardiac vagal tone in psychophysiological research – Recommendations for experiment planning, data analysis, and data reporting. *Frontiers in Psychology*, 8, 213. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00213>
- Levitz, K., & Levitz, H. (1979). *Logic and Boolean Algebra*. Barron's Educational Series.

- Liu, Y., Chen, J., & Wu, M. (2022). The Bring-Your-Own-Device (BYOD) Model in Digital Health Research: Practical Considerations and Ethical Challenges. *Journal of Medical Internet Research*, 24(6), e35410. <https://doi.org/10.2196/35410>
- Martínez, R., Palma, A., & Velásquez, A. (2020). *Revolución tecnológica e inclusión social: Reflexiones sobre desafíos y oportunidades para la política social en América Latina* (inf. téc. N.º 233). CEPAL.
- Meusel, D., Höger, C., Pérez-Rodrigo, C., Aranceta, J., & Cavill, N. (2006). Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health: A framework to monitor and evaluate implementation.
- Miguelles, J. H., Aadland, E., Andersen, L. B., Brønd, J. C., Chastin, S. F., Hansen, B. H., Konstabel, K., Kvalheim, O. M., McGregor, D. E., Rowlands, A. V., Sabia, S., Van Hees, V. T., Walmsley, R., & Ortega, F. B. (2022). GRANADA consensus on analytical approaches to assess associations with accelerometer-determined physical behaviours (physical activity, sedentary behaviour and sleep) in epidemiological studies. *British Journal of Sports Medicine*, 56(7), 376-384. <https://doi.org/10.1136/BJSPORTS-2020-103604>
- Mullick, T., Radovic, A., Shaaban, S., & Doryab, A. (2022). Predicting Depression in Adolescents Using Mobile and Wearable Sensors: Multimodal Machine Learning-Based Exploratory Study. *JMIR Formative Research*, 6(6), e35807. <https://doi.org/10.2196/35807>
- Murray, C. J. L., Aravkin, A. Y., Zheng, P., Abbafati, C., Abbas, K. M., Abbasi-Kangevari, M., Abd-Allah, F., Abdelalim, A., Abdollahi, M., Abdollahpour, I., et al. (2020). Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*, 396(10258), 1223-1249. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2)
- Okunogbe, A., Nugent, R., Spencer, G., Ralston, J., & Wilding, J. (2021). Economic impacts of overweight and obesity: Current and future estimates for eight countries. *BMJ Global Health*, 6(10), e006351. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006351>
- Paganelli, A. I., Mondéjar, A. G., da Silva, A. C., Silva-Calpa, G., Teixeira, M. F., Carvalho, F., Raposo, A., & Endler, M. (2022). Real-time data analysis in health monitoring systems: A comprehensive systematic literature review. *Journal of Biomedical Informatics*, 127, 104009. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2022.104009>
- Pate, R. R., O'Neill, J. R., & Lobelo, F. (2008). The evolving definition of “sedentary”. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 36(4), 173-178. www.acsm-essr.org
- Piercy, K. L., Troiano, R. P., Ballard, R. M., Carlson, S. A., Fulton, J. E., Galuska, D. A., George, S. M., & Olson, R. D. (2018). The Physical Activity Guidelines for Americans. *JAMA*, 320(19), 2020-2028. <https://doi.org/10.1001/jama.2018.14854>

- Pinto, A. J., Bergouignan, A., Dempsey, P. C., Roschel, H., Owen, N., Gualano, B., & Dunstan, D. W. (2023). Physiology of sedentary behavior. *Physiological Reviews*, *103*(4), 2561-2622. <https://doi.org/10.1152/physrev.00022.2022>
- Prince, S. A., Adamo, K. B., Hamel, M. E., Hardt, J., Gorber, S. C., & Tremblay, M. (2008). A comparison of direct versus self-report measures for assessing physical activity in adults: A systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, *5*, 56. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-5-56>
- Quigley, K. S., Gianaros, P. J., Norman, G. J., Jennings, J. R., Berntson, G. G., & de Geus, E. J. C. (2024). Publication guidelines for human heart rate and heart rate variability studies in psychophysiology—Part 1: Physiological underpinnings and foundations of measurement. *Psychophysiology*, *61*(9), e14604. <https://doi.org/10.1111/psyp.14604>
- Razjouyan, J., Naik, A. D., Horstman, M. J., Kunik, M. E., Amirmazaheri, M., Zhou, H., Sharafkhaneh, A., & Najafi, B. (2018). Wearable Sensors and the Assessment of Frailty among Vulnerable Older Adults: An Observational Cohort Study. *Sensors*, *18*(5), 1336. <https://doi.org/10.3390/s18051336>
- Redenius, N., Kim, Y., & Byun, W. (2019). Concurrent validity of the Fitbit for assessing sedentary behavior and moderate-to-vigorous physical activity. *BMC Medical Research Methodology*, *19*(29). <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0668-1>
- Reyes Molina, D., Zapata Lamana, R., Cigarroa, I., Palma Leal, X., Aguilar Farías, N., & Nazar, G. (2023). Actividad física incidental: avanzar en un paradigma de actividad física integrado y multidimensional. *Revista Médica de Chile*, *151*, 530-538. <https://doi.org/10.4067/s0034-98872023000400530>
- Riebe, D., Ehrman, J. K., Liguori, G., & Magal, M. (2018). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (10th) [Guía oficial del ACSM para prescripción de ejercicio]. American College of Sports Medicine.
- Romero, M., Barrientos-Gutiérrez, T., Cuevas-Nasu, L., Bautista-Arredondo, S., Colchero, M. A., Gaona-Pineda, E. B., Martínez-Barnetche, J., Alpuche-Aranda, C., Gómez-Acosta, L. M., Mendoza-Alvarado, L. R., Rivera-Dommarco, J., Lazcano-Ponce, E., & Shamah-Levy, T. (2022). Design of the Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 and planning and design of the Ensanut Continua 2020-2024. *Salud Pública de México*, *64*(5), 522-529. <https://doi.org/10.21149/14186>
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications* (3rd). John Wiley & Sons Ltd.
- Rothney, M. P., Schaefer, E. V., Neumann, M. M., Choi, L., & Chen, K. Y. (2008). Validity of physical activity intensity predictions by ActiGraph, Actical, and RT3 accelerometers. *Obesity*, *16*(8), 1946-1952. <https://doi.org/10.1038/oby.2008.279>

- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Santos, A. C., Willumsen, J., Meheus, F., Ilbawi, A., & Bull, F. C. (2023). The cost of inaction on physical inactivity to public health-care systems: a population-attributable fraction analysis. *The Lancet Global Health*, 11(1), e32-e39. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00464-8](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00464-8)
- Santos, J. C., Wong, J. H. D., Pallath, V., & Ng, K. H. (2021). The perceptions of medical physicists towards relevance and impact of artificial intelligence. *Physical and Engineering Sciences in Medicine*, 44(3), 833-841. <https://doi.org/10.1007/s13246-021-01036-9>
- Schrack, J. A., Cooper, R., Koster, A., Shiroma, E. J., Murabito, J. M., Rejeski, W. J., Ferrucci, L., & Harris, T. B. (2018). Using heart rate and accelerometry to define quantity and intensity of physical activity in older adults. *The Journals of Gerontology: Series A*, 73(5), 668-675. <https://doi.org/10.1093/gerona/gly029>
- Schuch, F. B., Vancampfort, D., Firth, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., Silva, E. S., Hallgren, M., Ponce De Leon, A., Dunn, A. L., Deslandes, A. C., Fleck, M. P., Carvalho, A. F., & Stubbs, B. (2018). Physical Activity and Incident Depression: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies [Relación bidireccional entre actividad física y bienestar psicológico]. *American Journal of Psychiatry*, 175(7), 631-648. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17111194>
- Shamah-Levy, T., Romero-Martínez, M., Barrientos-Gutiérrez, T., Cuevas-Nasu, L., Bautista-Arredondo, S., Rivera-Dommarco, J., & Campos-Nonato, I. (2023). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 sobre COVID-19: Resultados nacionales. *Salud Pública de México*, 65. <https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/index.php>
- Shcherbina, A., Mattsson, C. M., Waggott, D., et al. (2017). Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort. *Journal of Personalized Medicine*, 7(2), 3. <https://doi.org/10.3390/jpm7020003>
- Shetty, R. (2018). Medical Diagnosis using Fuzzy Logic. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 6(4), 5048-5052. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2018.4823>
- Soares-Miranda, L., Sattelmair, J., Chaves, P., Duncan, G. E., Siscovick, D. S., Stein, P. K., & Mozaffarian, D. (2014). Physical activity and heart rate variability in older adults: The cardiovascular health study. *Circulation*, 129(21), 2100-2110. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005361>

- Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4), 427-437. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002>
- Strain, T., Wijndaele, K., Dempsey, P. C., Sharp, S. J., Pearce, M., Jeon, J., Lindsay, T., Wareham, N., & Brage, S. (2020). Wearable-device-measured physical activity and future health risk. *Nature Medicine*, 26(9), 1385-1391. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1012-3>
- Strategic Plan Advisory Group PAHO. (2020). *Strategic Plan of the Pan American Health Organization 2020-2025: Equity at the Heart of Health* (inf. téc.). Pan American Health Organization. <http://www.paho.org/permissions>
- Strefezza, M. (2009). Lógica difusa, un punto de vista. *Revista Ciencia e Ingeniería*, 30(3).
- Swinburn, B. A., Kraak, V. I., Allender, S., Atkins, V. J., Baker, P. I., Bogard, J. R., Brinsden, H., Calvillo, A., De Schutter, O., Devarajan, R., Ezzati, M., Friel, S., Goenka, S., Hammond, R. A., Hastings, G., Hawkes, C., Herrero, M., Hovmand, P. S., Howden, M., et al. (2019). The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. *The Lancet*, 393(10173), 791-846. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32822-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32822-8)
- Syaffa Zakaria, A., Ammar Shafi, M., Arif Mohd Zim, M., & Noor Asyikin Mohd Razali, S. (2023). The Use of Fuzzy Linear Regression Modeling to Predict High-risk Symptoms of Lung Cancer in Malaysia. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(5). www.ijacsa.thesai.org
- Syed-Abdul, S., Luque, L. F., Hsueh, P., García-Gomez, J. M., & Garcia-Zapirain, B. (2020). Data Analytics and Applications of the Wearable Sensors in Healthcare. *Sensors*, 20, 1379. www.mdpi.com/journal/sensors
- Tajammul, P. (2023, noviembre). Wearable Technology Statistics: A Tech and Human.
- Tanaka, H., Monahan, K. D., & Seals, D. R. (2001). Age-Predicted Maximal Heart Rate Revisited. *Journal of the American College of Cardiology*, 37(1), 153-156. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)01054-8](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)01054-8)
- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *Circulation*, 93(5), 1043-1065. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043>
- Tremblay, M. S., Aubert, S., Barnes, J. D., Saunders, T. J., Carson, V., Latimer-Cheung, A. E., Chastin, S. F. M., Altenburg, T. M., Chinapaw, M. J. M., Aminian, S., et al. (2017). Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - Terminology Consensus Project process and outcome. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 14(75). <https://doi.org/10.1186/s12966-017-0525-8>

- Tremblay, M. S., Colley, R. C., Saunders, T. J., Healy, G. N., & Owen, N. (2010). Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 35(6), 725-740. <https://doi.org/10.1139/H10-079>
- Tsoukalas, L. H., & Uhrig, R. E. (1997). *Fuzzy and Neural Approaches in Engineering*. Wiley-Interscience.
- Vellido, A. (2020). The importance of interpretability and visualization in machine learning for applications in medicine and health care. *Neural Computing and Applications*, 32(24), 18069-18083. <https://doi.org/10.1007/S00521-019-04051-W>
- White, T., Westgate, K., Hollidge, S., Venables, M., Olivier, P., Wareham, N., & Brage, S. (2019). Estimating energy expenditure from wrist and thigh accelerometry in free-living adults: a doubly labelled water study. *International Journal of Obesity*, 43(11), 2333-2342. <https://doi.org/10.1038/s41366-019-0352-x>
- World Health Organization. (2009). *Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- World Health Organization. (2018). *Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030: More Active People for a Healthier World* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- World Health Organization. (2020a). WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>
- World Health Organization. (2020b). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour: Web Annex Evidence Profiles* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland. <http://apps.who.int/bookorders>
- World Health Organization. (2022). *Informe sobre la situación mundial de la actividad física 2022: Resumen ejecutivo* (inf. téc.). World Health Organization. Geneva, Switzerland.
- Wright, S. P., Brown, T. S. H., Collier, T. S., & Sandberg, K. (2017). How consumer physical activity monitors could transform human physiology research. *American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, 312, R358-R367. <https://doi.org/10.1152/ajpregu.00349.2016>
- Yamada, Y., Yoshida, T., Yokoyama, K., Watanabe, Y., Miyake, M., Yamagata, E., Yamada, M., Kimura, M., & Kyoto-Kameoka Study Group. (2019). Accuracy of 12 wearable devices for estimating physical activity energy expenditure using a metabolic chamber and the doubly labeled water method: Validation study. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(8), e13938. <https://doi.org/10.2196/13938>
- Yoo, I., Alafaireet, P., Marinov, M., Pena-Hernandez, K., Gopidi, R., Chang, J.-F., & Hua, L. (2012). Data mining in healthcare and biomedicine: A survey of the literature. *Journal of Medical Systems*, 36(4), 2431-2448. <https://doi.org/10.1007/s10916-011-9710-5>

Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338-353. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)